СЕМИНАР «ПРОСТРАНСТВО НОВЫХ ИДЕЙ 2.0» · МИНТРУД РОССИИ · САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25–27 АВГУСТА 2026

Сколько стоит достойная жизнь

Реформа психоневрологических интернатов: сколько стоит месяц жизни человека в интернате и в квартире, что показал мировой опыт и что можно сделать в российском регионе на имеющиеся деньги.

Доклад для руководителей организаций социального обслуживания и региональных министров.

Редакция 6.1, октябрь 2026. Калькулятор пересчитан в ценах одного года; добавлены путь из детских домов-интернатов, оценка Комитета ООН 2018 года и поддержка семей. Текст подготовлен ИИ и прочитан отдельными ИИ-сессиями; это не рецензия людей. Список изменений — в приложении Б.

Содержание

ДОКЛАД	Предисловие
ДОКЛАД	Резюме: главное на трёх страницах
ЧАСТЬ 1	Люди за цифрой: город, в котором три четверти жителей не могут подписать документ
ЧАСТЬ 2	Цена месяца: 44,8 тысячи в интернате и 52,9 в квартире
ЧАСТЬ 3	Что знает наука: качество изучено лучше, чем экономия
ЧАСТЬ 4	Что переносимо из мирового опыта
ЧАСТЬ 5	Россия: десять лет реформы и сто человек в Петербурге
ЧАСТЬ 6	Калькулятор: сколько заботы на миллион
ЧАСТЬ 7	План для региона: сначала люди, потом здания
ДОКЛАД	Заключение: что из этого следует для политики
ПРИЛОЖЕНИЕ А	Словарь
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	Журнал изменений
ПРИЛОЖЕНИЕ В	Что не удалось подтвердить и что не нашлось
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	Источники
ПРИЛОЖЕНИЕ Д	Как повторить расчёты
ПРИЛОЖЕНИЕ Е	Раскрытие: как готовился доклад
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж	Страны подробно
ПРИЛОЖЕНИЕ З	Доказательная база подробно
ПРИЛОЖЕНИЕ И	Россия подробно

Реформа психоневрологических интернатов в России: деньги, доказательства, решения

Доклад для руководителей организаций социального обслуживания и региональных министров. Редакция 6.1, октябрь 2026 года.

ДОКЛАД

Предисловие

О чём этот доклад и как его читать

В России около ста сорока тысяч человек живут в психоневрологических интернатах. Для большинства из них интернат — не больничная палата, куда ложатся на время, а дом на десятилетия: с общим расписанием, общей столовой, с чужим человеком в роли опекуна. Этот доклад о том, сколько стоит такая жизнь, сколько стоит другая и что можно купить на те деньги, которые у страны уже есть.

Он обращён к тем, кто принимает решения: к директорам интернатов и организаций социального обслуживания и к региональным министрам, которые подписывают им бюджеты. Поэтому в нём много цифр. Но цифры здесь служат людям, а не наоборот: за каждой строкой сметы стоит чей-то распорядок дня, чьё-то право выйти за ворота, чья-то возможность самому решить, что приготовить на ужин.

Доклад отвечает на четыре вопроса. Во что обходится месяц жизни человека в интернате и в квартире с сопровождением. Что говорит научная доказательная база об исходах и затратах. Что из опыта других стран, от Чехии и Молдовы до Германии, США и Австралии, переносимо в Россию, причём не только из успехов, но и из дорогих провалов. И что из этого можно сделать в российском регионе сейчас, без ожидания новых законов и новых денег.

Читать доклад можно по-разному. Министру, у которого есть полчаса, достаточно резюме и частей 4 и 7: там сведено, что переносимо из мирового опыта, и план действий. Директору интерната полезнее части 2, 5 и 6: российские цифры, опыт регионов и калькулятор. Тем, кто будет защищать решение перед финансистами или правозащитниками, понадобятся часть 3 и приложения Ж и З с подробным разбором стран и исследований.

Это редакция 6.1, дополненная по исследованию пробелов шестой. Ранние версии ошибочно принимали капитальные затраты за текущие и обещали экономию. История исправлений собрана в приложении Б.

Главный вывод

По российским данным разница в текущих затратах между интернатом и сопровождаемым проживанием при сопоставимых потребностях жителей не измерена. Единственная найденная оценка, НИУ ВШЭ, даёт 44,8 тыс. ₽ в месяц на человека в ПНИ и 52,9 тыс. ₽ в проектах сопровождаемого проживания, но сравнивает данные разных лет и людей с разной потребностью в помощи [1]. С учётом капитальных затрат диапазоны перекрываются: ПНИ 52,8–68,8 тыс. ₽ против 54,9–58,9 тыс. ₽ в сопровождаемом проживании, в ценах данных ВШЭ (оценка составителя: 44,8 + 8–24 и 52,9 + 2–6) [1]. Экономию обещать нельзя. Аргументы за реформу другие: качество жизни и отказ от строительства новых корпусов, где одно койко-место обходится в 2,8 млн ₽ [1].

Как отмечены цифры

Метка	Что она означает
Число в квадратных скобках, например [1]	Номер источника в приложении Г. У каждого источника там указано, как он был получен: «прочитан», «только аннотация», «только поисковая выдача», «вторичный пересказ».
†	Цифра или утверждение опирается только на поисковую выдачу, аннотацию или чужой пересказ либо помечено в рабочих заметках как непроверенное. С редакции 6.1 тот же знак стоит у цифр из пресс-релизов, которые никто независимо не проверял. Перед публичным выступлением такую цифру стоит сверить по первоисточнику.
«оценка составителя»	Расчёт на основе цифр из источников и явно названных допущений. Формула приведена рядом. Скрипт `calc.py` и фрагмент в приложении Д пересчитывают всё заново.

Валюты не пересчитаны в рубли намеренно: курсы за разные годы и паритет покупательной способности сильно меняют картину, а сопоставимого пересчёта в рабочих материалах нет. Международные цифры сравниваются не в рублях, а через отношения «учреждение к сообществу» внутри одной страны (часть 4).

Российские суммы в расчётах приводятся в двух вариантах: «как в данных ВШЭ» и «в ценах 2025 года», если цифры ВШЭ даны в ценах года сбора данных. ВШЭ не указала, в ценах какого года её цифры, поэтому верным может оказаться любой из вариантов (часть 6).

ДОКЛАД

Резюме: главное на трёх страницах

Для министра

1. **В ПНИ живёт около 139 тысяч человек в 466 учреждениях** (2024). Средний интернат рассчитан на 289 мест, в 2022 году интернаты были заполнены на 98,6 % [3, 5]. По цифре, приведённой ещё в редакции 4 и с тех пор не перепроверенной, в очереди стоят около 2,8 тысячи человек† [3]. Минтруд, считающий также отделения внутри других организаций, называет цифру больше 174 тысяч [4].

2. **По российским данным разница в текущих затратах при сопоставимых потребностях не измерена.** Единственная найденная оценка — ВШЭ: 44,8 тыс. ₽ в месяц на человека в ПНИ и 52,9 тыс. ₽ в проектах сопровождаемого проживания, в столице — 111,9 тыс. ₽ [1]. Но затраты ПНИ взяты из обследования 2019 года, затраты проектов — из опроса 2021 года; проектов всего шесть, их жителям нужна интенсивная помощь, а «расходы ФЛ», включённые в обе суммы, не расшифрованы. По этим несопоставимым данным квартира дороже на 18 %; при одинаковых потребностях разница неизвестна. С учётом капитальных затрат диапазоны перекрываются: ПНИ 52,8–68,8 тыс. ₽, сопровождаемое проживание 54,9–58,9 тыс. ₽ в ценах данных ВШЭ (оценка составителя) [1]. Экономию обещать нельзя.

3. **Аргументы за реформу — качество жизни и отказ от новых корпусов.** Строительство нового интерната обходится в 2,8 млн ₽ на койко-место [1]. На одного жителя квартиры приходится 8,2 оплаченного часа работы персонала в сутки, в интернате — 3,5 [1]. Индекс качества жизни — 76,9 балла в квартирах против 56,9 в интернатах; это экспертная пилотная оценка ВШЭ, известная по пересказу Агентства социальной информации† [2].

4. **За рубежом учреждение выглядит дороже квартиры — в Германии, США и Молдове в 1,7–4,6 раза, — но эти цифры не переносятся на Россию** [88, 116, 117, 157]. Везде сравниваются разные люди и разные статьи затрат: немецкие суммы не включают жильё, американские известны по поисковой выдаче†, а в учреждениях остаются люди с наибольшими потребностями. Сравнений людей с сопоставимыми потребностями мало, и они противоречивы: по тезисам конференции 2000 года† значимой разницы в скорректированных затратах не нашлось, европейский отчёт 2007 года не нашёл данных о том, что жизнь в сообществе по своей природе дороже, а из двух исследований систематического обзора 2019 года одно показало в сообществе более низкие затраты, другое — значимо более высокие [24, 25, 182] (часть 4).

5. **Исследования говорят о качестве увереннее, чем об экономии.** Обзоры, известные по аннотациям и пересказам, последовательно указывают на преимущество жизни в сообществе в большинстве областей† [177–179]. Систематический обзор затрат нашёл лишь два сопоставимых исследования с противоположными выводами [25]. Важен не только тип здания, но и то, как работает персонал: метод Active Support — один из наиболее изученных рычагов качества [185].

6. **Переход стоит денег и требует осторожности.** Ирландские оценки описывают разные показатели: Национальное управление по делам инвалидности оценивает дополнительные затраты примерно в 80 тыс. € на каждого переселённого† [135], а обзор потенциала служб 2018 года называл среднюю стоимость переезда в 140,2 тыс. € на человека [136]. В южноафриканской провинции Гаутенг поспешный перевод 1 711 человек в 2016 году сопровождался гибелью 144 из них† [194]. Переходный фонд и медицинское сопровождение переезда — обязательные статьи.

7. **Восточная Европа показывает, как реформа застревает.** В Чехии за 2017–2024 годы число жителей домов для людей с инвалидностью снизилось лишь на 8 %, а «дома с особым режимом» выросли с 17,9 до 25,5 тысячи клиентов; в них живут и люди с деменцией, и разбивки по группам статистика не даёт [74]. В Молдове за семь лет программы в сообщество переселено около 10 % жителей учреждений; по журналистскому расследованию, за 2018–2023 годы на 133 «социально интегрированных» пришёлся 131 возврат в учреждение, но те ли это люди, из него не ясно [89]. В Чехии и Болгарии вложения в здания без запрета новых поступлений и без перевода текущего финансирования «за человеком» сопровождались созданием малых учреждений [76, 92].

8. **Охват в России мал, правовой барьер высок.** По данным Минтруда, в 2025 году сопровождаемым проживанием пользовались около 8 тысяч человек с инвалидностью [4]; независимые аналитики насчитывают на постоянном проживании вне интерната не более 1,8 тысячи [3, 6]. В Петербурге в 2025 году такую услугу получили 100 человек при почти 6 тысячах взрослых в домах социального обслуживания [54]. 74 % жителей ПНИ признаны недееспособными, и их опекуном, как правило, становится сам интернат [3]; в Петербурге в 2025 году дееспособность восстановили двум проживающим при 66 новых лишениях и ограничениях [54]. Законопроект о распределённой опеке Госдума отклонила в феврале 2025 года [15].

9. **Есть риск реформы только на вывеске.** Интернаты переименованы как минимум в 41 регионе [3], а в июле 2026 года Минтруд убрал «дом-интернат» из примерной номенклатуры организаций социального обслуживания; номер и дату приказа публикация не приводит [56]. Новое название не меняет ни состава жителей, ни их правового статуса. Мерилом успеха остаётся одно: сколько людей живёт за пределами интерната и в каких группах.

10. **Часть жителей приходит из детских домов-интернатов.** По оценке АСИ на 2018 год, около трети жителей ПНИ — бывшие воспитанники ДДИ† [209]; в Петербурге выпускников ДДИ в 18 лет, как правило, переводят в ПНИ [211]. Сколько их поступает ежегодно по стране, неизвестно. Пока этот вход открыт, освободившиеся места есть кому занять (оценка составителя; части 5 и 7).

11. **Комитет ООН по правам инвалидов в 2018 году отметил отсутствие в России стратегии деинституционализации** и рекомендовал её принять, а также перейти от замещающего принятия решений к поддерживаемому [217]. Это оценка Комитета на 2018 год, а не описание права на 2026 год; следующий цикл рассмотрения не завершён (часть 5, приложение 3).

Для директора

1. **Начните с обследования своих жителей и очереди.** В Нижегородской области из 350 обследованных у каждого пятого потребность в сопровождении не превышала двенадцати часов в неделю [8]. В петербургской выборке мониторинга документов 2023–2024 годов потенциал для перехода на сопровождаемое проживание нашли у 26 % [54]. Обе выборки не случайные, и какова эта доля у вас, не знает никто, пока её не измерят. Обследование лучше поручить внешним специалистам, а не интернату-опекуну, и включить в него людей из очереди (часть 7).

2. **Считайте в часах, а не только в местах.** Миллион рублей в год — это около двух мест в интернате по цифрам ВШЭ (1,2 места в ценах 2025 года) или 1 700–2 900 часов сопровождения: этого хватит примерно 2,7–4,6 человека по 12 часов в неделю без учёта жилья или 1,2–2,1 человека с жильём и бытом (оценка составителя, часть 6). По петербургской шкале — до 14, 28 и 42 часов в неделю [54] — и московскому тарифу надомного обслуживания одно лишь сопровождение стоит 20–31, 41–62 и 61–92 тыс. ₽ в месяц.

3. **Знак разницы зависит от года цен и от регионального тарифа.** ВШЭ не указала, в ценах какого года её цифры [1]. Если это цены года сбора данных, место в ПНИ в ценах 2025 года стоит около 70,8 тыс. ₽, и квартира для человека с лёгкой потребностью (до 12 часов в неделю) обходится дешевле во всех трёх сценариях калькулятора: для 80 человек из условного интерната на 400 мест — на 1,6–29,4 млн ₽ в год (оценка составителя). Если ВШЭ уже дала текущие цены, квартира дешевле только в оптимистичном сценарии (−4,4 млн ₽), а в базовом и пессимистичном дороже (+9,5 и +23,4 млн ₽). Человеку, которому помощь нужна большую часть суток, квартира с индивидуальным сопровождением по калькулятору не дешевле интерната в обоих вариантах. Проверьте свой тариф часа и цену жилья и планируйте по когортам, а не по принципу «всех в квартиры».

4. **Малая группа — необходимое, но не достаточное условие качества.** Минтруд рекомендует три-четыре человека в квартире, а на практике в среднем живут семь-восемь [6]. В Грузии новые дома рассчитаны на пять-шесть человек [83], в Молдове — на два-шесть [89]; чешский методический стандарт допускает 12–18 человек на здание† [77], и это, по оценке составителя, слишком много.

5. **Учите персонал, а не только ремонтируйте.** Активная поддержка (Active Support) — методика, при которой сотрудник не делает за человека, а помогает ему участвовать в повседневных делах, — повышает вовлечённость жителей через полгода после обучения; эффект от малого (d = 0,33) до большого в зависимости от дизайна исследования [185]. Российских данных об эффекте и о стоимости внедрения нет.

6. **Снизьте плату для тех, кто учится жить сам.** Нижегородская область ограничила плату за сопровождаемое проживание 15 % среднедушевого дохода; без этого, по данным «Особого права», из заработка человека могут удерживать до трёх четвертей [57]. Источники о правиле расчёта дохода противоречат друг другу [16, 57], так что действующее правило стоит проверить.

7. **Откройте интернат для внешних глаз.** Внешний доступ — дешёвая мера; в Нижегородской области, по сообщению «Ведомостей», открытие интернатов для волонтёров снизило число нарушений [4].

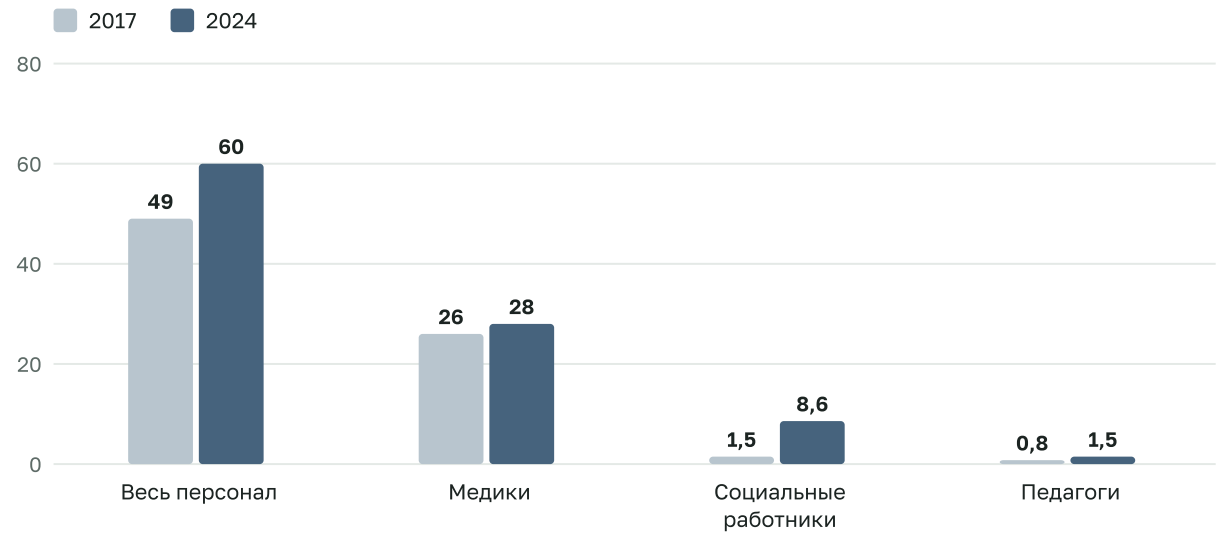
8. **Готовьте переезд как медицинское событие.** В одном контролируемом исследовании в Нью-Джерси (150 переехавших и 150 оставшихся) смертность предсказывали возраст, медицинские состояния, эпилепсия и перевод в дома престарелых, а сам переезд в этой работе её не предсказывал† [191]. Калифорнийские работы 1990-х годов, напротив, сообщали о смертности в сообществе выше на 25–72 %† [188, 189]. Медицинский план переезда нужен каждому.

9. **Решите судьбу освободившихся мест до старта.** Если их займут люди из очереди, расходы региона не снизятся, а охват вырастет (часть 6). Это нормальный исход, но о нём нужно заранее сказать финансистам.

ЧАСТЬ 1

Люди за цифрой: город, в котором три четверти жителей не могут подписать документ

Сто тридцать девять тысяч — население небольшого областного центра. Если собрать всех жителей российских интернатов в одном месте, получился бы город, в котором три четверти горожан лишены права подписывать документы, а у большинства один и тот же опекун — директор учреждения.



Персонал ПНИ на 100 жителей, 2017 и 2024 годы («Если быть точным»).

Кто живёт в ПНИ

Показатель	Значение	Ист.
Жители ПНИ, 2024	**139 тыс.** человек в 466 учреждениях; пик — 161 тыс. в 2018 году	[3, 5]
Недееспособные	**74 %**; опекун — как правило, интернат	[3]
Старше 45 лет	**65 %** при 43 % в среднем по стране	[3]
Не встают с постели	**11 %**	[3]
Медики среди специалистов, работающих с жителями	**74 %**	[5]

Цифры о числе жителей расходятся: 139 тысяч в 466 интернатах для взрослых по подсчёту «Если быть точным» [3] и более 174 тысяч во всех отделениях для людей с психическими расстройствами, включая отделения внутри других организаций, по данным Минтруда [4]. Число ПНИ за 2022–2025 годы снизилось с 536 до 466, но аналитики и НКО объясняют это прежде всего объединением и переименованием, а не закрытием [4]. Почему ряды не стыкуются и чего нет в федеральной статистике, разобрано в приложении И.

Портрет этого «города» складывается из нескольких штрихов. Почти две трети жителей имеют вторую группу инвалидности, около трети — первую. Две трети старше сорока пяти лет. Каждый десятый не встаёт с постели. Интернат в среднем рассчитан на 289 мест, хотя эксперты называют разумным размером двадцать–пятьдесят; самые крупные учреждения доходили до тысячи [3]. Места заполнены почти полностью, и в очереди стоят ещё несколько тысяч человек† [3]. Среди специалистов, работающих с жителями, три четверти — медики; педагогов в 2017 году было 8 на тысячу жителей, в 2024 году — 15 [5].

Самые подробные свежие официальные данные есть по Санкт-Петербургу — из доклада городского уполномоченного по правам человека за 2025 год. На 31 декабря 2025 года в городе было 473 752 человека с инвалидностью, из них 5 977 взрослых жили в домах социального обслуживания — так теперь называются бывшие ПНИ. В другом месте того же доклада, со ссылкой на сами учреждения, названо 6 270 проживающих; вероятно, с учётом несовершеннолетних или на другую дату, но сам доклад расхождения не объясняет [54]. Недееспособными признаны 3 471 проживающий, ограниченно дееспособными — 41 [54]. Петербург, таким образом, — около 4 % всех жителей интернатов страны (оценка составителя: 6 тыс. ÷ 139 тыс.).

Важно помнить, что ПНИ — не больница. Больница лечит и выписывает; интернат организует жизнь на годы: кормит, одевает, помогает в быту, решает, когда гулять и когда спать. Поэтому разговор о деньгах здесь — это разговор о социальном обслуживании, а не о психиатрии, и мировые сравнения уместно вести в рамках того, что ОЭСР называет долговременным уходом [28].

Новое имя без нового содержания

В июле 2026 года Минтруд утвердил новую примерную номенклатуру организаций социального обслуживания вместо приказа № 918н от 17 декабря 2020 года. Наименование «дом-интернат» из неё исключено; вместо него — «дом социального обслуживания», «центр социального обслуживания», «центр социальной адаптации» и другие. Номер и дату нового приказа публикация не приводит

[56]. Петербургский опыт показывает, чего стоит переименование само по себе: все городские ПНИ уже стали домами социального обслуживания, а их жители — «проживающими», но контингент и правовой статус людей остались прежними [54]. Переименования уже прошли как минимум в 41 регионе [3], и исчезновение слова «интернат» из названий не означает исчезновения интернатов.

Что такое сопровождаемое проживание

Сопровождаемое проживание — это жизнь в обычном жилье, одному или в небольшой группе, с помощью, которая подстраивается под человека: от нескольких часов в неделю до постоянного присутствия рядом. Федеральный закон от 28 апреля 2023 года № 137-ФЗ ввёл это понятие в закон «О социальной защите инвалидов» (статья 9.1); норма действует с 1 сентября 2023 года и касается инвалидов старше восемнадцати лет, которые не могут жить самостоятельно без посторонней помощи [11]. Правила организации утвердило постановление Правительства № 910 от 3 июля 2024 года [12], методические рекомендации — приказ Минтруда № 85 от 25 февраля 2025 года, действующий с 1 марта [13].

Методические рекомендации проводят важную границу. Постоянное сопровождаемое проживание возможно только в квартире или доме за пределами территории организации; учебное может идти и в тренировочных квартирах на её территории. Рекомендуемая длительность учебного проживания — не менее четырёх месяцев подряд или один–два месяца два–три раза в год; вопрос о выписке рассматривается не раньше чем через полгода учёбы. Межведомственная «дорожная карта» по развитию сопровождаемого проживания действует до 2026 года [57].

Две формы, которые легко спутать. Учебное сопровождаемое проживание — временная школа самостоятельности, чаще всего в квартире на территории интерната. Постоянное — жизнь за его пределами. Минтруд учитывает обе формы вместе; «Если быть точным» выделяет постоянную и насчитывает не более 1,8 тысячи человек в 214 квартирах [3, 6]. На начало 2024 года 74 % участников программы жили в учебных квартирах [6].

Единицы заботы

Споры об «объёме услуг» часто заходят в тупик потому, что стороны меряют разными мерками. Министр думает о местах, директор — о ставках, семья — о часах, которые кто-то проведёт рядом с её сыном. У каждой единицы своя цена и своё назначение.

Единица	Что покупают	Кому подходит	Ориентир цены
Место	Проживание, питание и уход круглые сутки	Тем, кто полностью зависит от помощи и не имеет поддержки	ПНИ: 44,8 тыс. ₽ в месяц как в данных ВШЭ, около 70,8 тыс. ₽ в ценах 2025 года, если это цены 2019 года [1, 208]; в пересказе «Известий» по исследованиям 2021–2022 годов — 50–120 тыс. ₽† [7]
Час	Помощь по дому, сопровождение, занятость	Тем, кто живёт дома или в квартире	Москва, 2026: час социального обслуживания на дому — 507 ₽ (основные услуги) и 337 ₽ (дополнительные) [22]; это тарифы надомного обслуживания, а не сопровождаемого проживания
Квартира с сопровождением	Своё жильё и помощь по индивидуальному плану	Части жителей ПНИ после обучения	52,9 тыс. ₽ в месяц в среднем как в данных ВШЭ (73,6 в ценах 2025 года, если это цены 2021 года); в столице — 111,9 (155,6) [1, 208]

Таблица 1.1. Единицы заботы

Кто и как платит за место

Житель интерната вносит плату за стационарное обслуживание. По статье 32 Федерального закона № 442-ФЗ её размер не может превышать 75 % среднедушевого дохода получателя [14]. Поскольку главный доход большинства жителей — пенсия, в обиходе говорят просто: «интернат забирает три четверти пенсии».

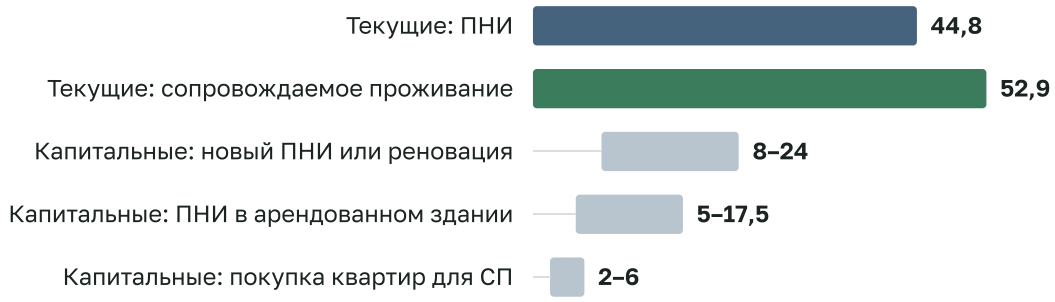
С расчётом этого дохода связаны два противоречащих сообщения. По «Парламентской газете», заработная плата работающих в интернатах людей с инвалидностью больше не учитывается при расчёте среднедушевого дохода; номер и дата поправки не указаны† [16]. «Особое право» в декабре 2025 года пишет обратное применительно к сопровождаемому проживанию: зарплата участника засчитывается в доход, и без снижения платы из неё может уходить около 75 % [57]. Источники называют и разные постановления о расчёте дохода — № 1075 от 18 октября 2014 года [16] и № 1873 от 23 декабря 2024 года [57]. Возможно, сообщения касаются разных форм обслуживания или разных дат; согласовать их не удалось, и перед расчётом платы это нужно проверить по действующему тексту.

Методические рекомендации Минтруда (приказ № 85, пункт 36) советуют снижать плату за сопровождаемое проживание. Нижегородская область ограничила её 15 % среднедушевого дохода [57]. Для человека, который впервые получил зарплату, разница между 15 и 75 % — это разница между стимулом работать и его отсутствием.

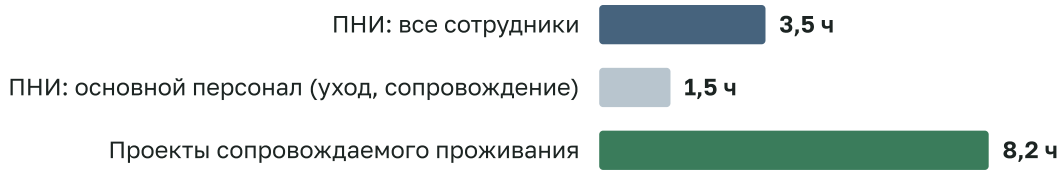
ЧАСТЬ 2

Цена месяца: 44,8 тысячи в интернате и 52,9 в квартире

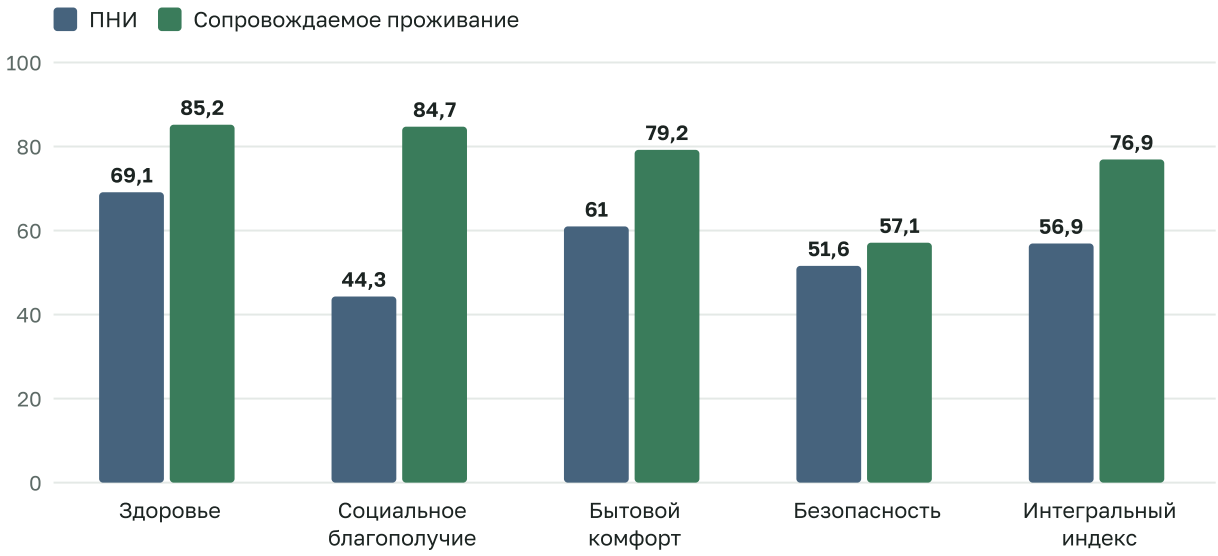
Есть соблазн считать, что жизнь в интернате дёшева, потому что она бедна. Расчёты ВШЭ дают для интерната и для квартиры с сопровождением близкие суммы, хотя сравнивают они разные годы и разных людей. Главная разница видна не в сумме, а в том, на что эта сумма уходит.



Текущие и капитальные затраты на человека в месяц, тыс. ₽, в ценах данных ВШЭ.



Оплаченные часы работы персонала на одного человека в сутки (ВШЭ, 2022).



Индекс качества жизни, баллы из 100 (ВШЭ, по пересказу АСИ †).

Что посчитала ВШЭ

Самая подробная из найденных российских работ на эту тему — исследование Института социальной политики НИУ ВШЭ «Разработка финансово-экономической модели сопровождаемого проживания граждан с ментальной инвалидностью и её сравнение с ПНИ», выполненное в 2021–2022 годах при поддержке Фонда Потанина по инициативе петербургских «Перспектив» [1, 2]. Для интернатов исследователи использовали обследование НИИ труда 2019 года (390 учреждений), для сопровождаемого проживания — опрос шести проектов НКО 2021 года; кроме того, они провели интервью с представителями восемнадцати проектов, шестью сотрудниками интернатов и тремя экспертами [1]. Шесть проектов — маленькая и не случайная выборка; разброс затрат между ними в рабочих материалах не приведён.

Результат таков. Затраты на одного проживающего в месяц, включая его личные расходы, составили 44,8 тыс. ₽ в ПНИ и 52,9 тыс. ₽ в проектах сопровождаемого проживания в регионах; в столице (по-видимому, Москва) — 111,9 тыс. ₽ [1]. Авторы прямо пишут, что модель сопровождаемого проживания «обеспечивает лучший результат при сопоставимом или чуть более высоком уровне текущих

затрат» [1]. По этим несопоставимым данным квартира в регионах дороже места в интернате примерно на 18 % (оценка составителя: 52,9 ÷ 44,8 ≈ 1,18); при одинаковых потребностях разница неизвестна.

В ценах какого года даны эти суммы, ВШЭ не указывает, и индексации между данными 2019 и 2021 годов в тексте нет [1]. Если цифры даны в ценах года сбора, то в ценах 2025 года по индексу потребительских цен Банка России [208] это около 70,8 тыс. ₽ для ПНИ и 73,6 тыс. ₽ для сопровождаемого проживания (столица — 155,6 тыс. ₽). Если ВШЭ уже индексировала цифры, такой пересчёт их завышает (оценка составителя, часть 6).

Вид затрат	ПНИ	Сопровождаемое проживание
Текущие, на человека в месяц, включая личные расходы	44,8 тыс. ₽	52,9 тыс. ₽ (регионы); 111,9 тыс. ₽ (столица)
Капитальные в пересчёте на месяц (амортизация)	8–24 тыс. ₽ (новое строительство и реновация); 5–17,5 тыс. ₽ (аренда здания)	2–6 тыс. ₽ (покупка квартир, в зависимости от региона)

Таблица 2.1. Текущие и капитальные затраты на человека в месяц. Источник — НИУ ВШЭ [1]

Отдельно ВШЭ посчитала капитальные затраты. Строительство нового интерната обходится в 2,8 млн ₽ на одно койко-место, реновация спального корпуса — в 0,75 млн ₽. В пересчёте на месяц с учётом амортизации это 8–24 тыс. ₽ на жителя для нового строительства и реновации и 5–17,5 тыс. ₽, если интернат размещается в арендованном здании; для сопровождаемого проживания с покупкой квартир — 2–6 тыс. ₽ в зависимости от региона [1]. Если сложить текущие и капитальные затраты, диапазоны перекрываются: 52,8–68,8 тыс. ₽ в месяц для ПНИ при новом строительстве или реновации и 54,9–58,9 тыс. ₽ для сопровождаемого проживания с покупкой квартир (оценка составителя: 44,8 + 8–24 и 52,9 + 2–6, в ценах данных ВШЭ) [1]. Какая форма окажется дешевле, зависит от того, строит ли регион новые корпуса или живёт в старых; в «цене места» стоимость зданий почти не видна (см. ниже).

Куда уходят деньги

Сравнение структуры затрат объясняет, почему при близких суммах результат так разнится. В интернате на одного жителя приходится 0,56 штатной ставки, в проектах сопровождаемого проживания — 1,28. В сутки на одного человека в ПНИ оплачено 3,5 часа работы всех сотрудников, из них лишь 1,5 часа — работы тех, кто непосредственно ухаживает и сопровождает; в сопровождаемом проживании — 8,2 часа [1]. Административно-управленческий персонал составляет 9 % штата интерната и 6,9 % — в проектах; обслуживающий персонал (кухня, прачечная, охрана, ремонт) — 29,4 % против 13,1 % [1]. Иначе говоря, интернат тратит заметную часть денег на то, чтобы содержать само себя.

Показатель	ПНИ	Сопровождаемое проживание
Штатных ставок на одного жителя	0,56	1,28
Оплаченных часов работы всех сотрудников в сутки на человека	3,5	8,2
Из них — часов тех, кто непосредственно ухаживает и сопровождает	1,5	нет данных
Доля административно-управленческого персонала	9 %	6,9 %
Доля обслуживающего персонала	29,4 %	13,1 %

Таблица 2.2. Сколько человеческого времени покупают одни и те же деньги. НИУ ВШЭ [1]

Чтобы дать жителям интернатов столько же человеческого времени, сколько получают люди в квартирах, к штатному расписанию ПНИ по всей стране пришлось бы добавить 154 тысячи ставок. Операционные расходы выросли бы в два–три раза, а реновация, которая обеспечила бы сопоставимые условия проживания, потребовала бы единовременно не менее 200–300 млрд ₽ [1]. В расчёте на одного жителя это 1,4–2,2 млн ₽ (оценка составителя: 200–300 млрд ₽ ÷ 139 тыс. человек).

В интернате питание финансируется централизованно, по тарифам от 180 до 450 ₽ в сутки, а меню и время еды определяет распорядок. В квартирах продукты покупают сами жители на свои деньги, и эти траты составляют 10–15 % совокупного бюджета проекта, то есть 150–500 ₽ в день [1]. В проектах сопровождаемого проживания на одного жителя приходится в среднем 17,5 м² жилой площади; средняя площадь спальни в стационаре, по открытым данным 2010 года, — 6,1 м² на койко-место [1].

Другие оценки и почему их нельзя просто сложить

Помимо ВШЭ, в публичном поле есть и другие цифры. «Известия» в 2026 году приводили диапазон 50–120 тыс. ₽ в месяц для ПНИ со ссылкой на исследования 2021–2022 годов†; руководитель ярославского проекта «Дом как дом» оценил месяц жизни человека с тяжёлыми нарушениями в своём доме примерно в 90 тыс. ₽ при полной загрузке, из которых основная часть — оплата ассистентов, 15 млн ₽ в год [7]. Сравнивать эти цифры напрямую нельзя по трём причинам.

Первая — **разные люди.** В обследованных ВШЭ проектах, по пересказу Агентства социальной информации, большинству подопечных требуется круглосуточное сопровождение† [2]. Средняя цена места в интернате, напротив, усредняет людей с очень разными потребностями. Вторая — **разный состав затрат.** По наблюдению ВШЭ, имущество, которое государство безвозмездно передаёт интернату, некорректно учитывается в себестоимости и тарифах [1]; стоимость зданий в «цене места» почти не видна. Не расшифрована и формулировка «включая расходы ФЛ»: неясно, учтены ли в 44,8 тыс. ₽ пенсии жителей, а не только бюджетные деньги [1]. Третья — **столица.** Столичная цена сопровождаемого проживания более чем вдвое выше средней по регионам [1].

Первая причина особенно важна для честного вывода. Если в квартирах ВШЭ жили преимущественно люди с высокой потребностью в помощи, а в интернатах — люди с любой потребностью, то сравнение 52,9 с 44,8 тыс. ₽ ставит квартиру в заведомо невыгодное положение. Это аргумент в пользу того, что при сопоставимых людях разница может оказаться меньше или исчезнуть. Но это гипотеза, а не измерение: российского исследования, которое сравнило бы людей с одинаковыми потребностями в двух формах жизни, в рабочих материалах нет.

Что получает человек

ВШЭ разработала индекс качества жизни на основе зарубежных методик и адаптировала его к российской практике [1]; Агентство социальной информации пишет также о критериях ВОЗ† [2]. Интегральное значение, по пересказу АСИ, — 76,9 балла из 100 в сопровождаемом проживании и 56,9 в интернате† [2]; в тексте презентации ВШЭ этих значений нет, вероятно, они приведены на диаграммах-картинках [1]. По тому же пересказу сильнее всего разнится социальное благополучие (84,7 против 44,3 балла) и здоровье (85,2 против 69,1), а безопасность различается мало (57,1 против 51,6)† [2]. Индекс апробирован в пилотном формате на экспертных оценках, а не на опросе самих жителей; число экспертов и разброс оценок в рабочих материалах не указаны, и сами авторы предлагают доработать методику [1]. Это сигнал, но ещё не доказательство.

Компонент индекса	Сопровождаемое проживание	ПНИ
Интегральный индекс†	76,9	56,9
Социальное благополучие†	84,7	44,3
Здоровье†	85,2	69,1
Безопасность†	57,1	51,6

Таблица 2.3. Индекс качества жизни, баллы из 100. Методика НИУ ВШЭ [1]; все значения — по пересказу АСИ [2]

Как менялся персонал интернатов

Между 2017 и 2024 годами обеспеченность интернатов персоналом выросла с 49 до 60 работников на 100 жителей, но три четверти основного персонала по-прежнему медики [3]. Хоть какая-то занятость в 2020 году была только у 19,2 % жителей ПНИ [1]. С 1 сентября 2025 года действуют новые правила и нормативы штатной численности стационарных организаций (приказ Минтруда № 305н) [55]. Подробнее — в приложении И.

Вывод второй части. По российским данным разница в текущих затратах при сопоставимых потребностях не измерена: сравнения людей с одинаковой потребностью в помощи нет. С учётом капитальных затрат диапазоны перекрываются (ПНИ 52,8–68,8 против 54,9–58,9 тыс. ₽ в сопровождаемом проживании, в ценах данных ВШЭ), поэтому экономию обещать нельзя. Данные позволяют сказать другое. На близкие суммы человек в квартире получает больше оплаченного времени персонала — по всем сотрудникам 8,2 часа в сутки против 3,5 в интернате — и, по пилотной экспертной оценке, более высокое качество жизни. Интернату, чтобы сравняться с квартирой, понадобились бы 154 тысячи новых ставок и не менее 200–300 млрд ₽ на реновацию, а новый корпус обходится в 2,8 млн ₽ на койко-место [1]. Отсюда два аргумента за реформу: качество жизни и отказ от строительства новых корпусов.

ЧАСТЬ 3

Что знает наука: качество изучено лучше, чем экономия

Прежде чем пересказывать исследования, три оговорки. Почти все строгие работы сделаны в Великобритании, США, Канаде, Скандинавии и Ирландии; для Восточной Европы и стран со средним доходом сопоставимых количественных исследований в рабочих материалах не нашлось. Большинство работ касается людей с нарушениями интеллектуального развития, а работы о жилье для людей с тяжёлыми психическими расстройствами — в основном о бездомных. Наконец, многие полные тексты открыть не удалось, и часть сведений взята из аннотаций; такие места помечены знаком †. Подробный разбор каждой работы — в приложении 3.

Что меняется в жизни человека после переезда

Исследования исходов отвечали на вопрос, лучше ли людям с интеллектуальными нарушениями живётся в небольшом жилье в сообществе, чем в крупном учреждении. Систематический обзор работ 1997–2007 годов (Kozma, Mansell, Beadle-Brown, 2009) показал преимущество жизни в сообществе в большинстве из десяти областей исходов† [177]; цифру «7 из 10» удалось увидеть только во вторичных пересказах† [178]. Обзор 2019 года описывает «последовательную картину»: переезд связан с ростом качества жизни (McCarron et al., 2019, по аннотации†) [179]. Американские сводки исследований 1977–2010 годов собраны в аналитической записке Университета Миннесоты (Lakin, Larson, Kim, 2011)† [180].

Британское сравнение 63 человек в квартирах с сопровождением, 55 в малых и 152 в больших групповых домах (Emerson et al., 2001) по тезисам конференции† нашло у жителей квартир больше выбора и участия в жизни сообщества [181, 182]. Там же отмечены меньшая занятость по расписанию и больший риск эксплуатации† [182]. Эффект зависит не только от размера жилья, но и от работы персонала. Метод Active Support повышает вовлечённость жителей: через шесть месяцев эффект от малого (d = 0,33) до большого, в зависимости от дизайна (Flynn et al., 2018) [185]. Но более ранняя строгая оценка признала метод лишь «многообещающим» (Hamelin, Sturmey, 2011)† [186]. Ограничение для России: все эти работы сделаны в странах с иной системой услуг, а полные тексты обзоров при подготовке доклада не открывались.

Сколько это стоит

Строгих экономических сравнений мало. Систематический обзор затрат (May et al., 2019) после отбора по качеству оставил два британских когортных исследования о выписке из больниц длительного пребывания в 1984–1992 годах [25]. Их выводы противоположны:

- **Северная Ирландия:** в сообществе дешевле, 356 £ против 574 £ в неделю, без проверки значимости [25].
- **Англия:** в сообществе дороже на всех трёх замерах, через 1, 5 и 12 лет, статистически значимо [25].

Европейское исследование DECLOC (Mansell, Knapp, Beadle-Brown, Beecham, 2007) не нашло данных о том, что модели в сообществе по своей природе дороже учреждений при сопоставимых потребностях и качестве (том 1, с. 7) [24]. Дешёвые учреждения, по выводу авторов, почти всегда дают низкое качество. Переход требует вложений на старте и нескольких лет двойного финансирования (с. 9) [24]. Отдельные британские сравнения противоречивы:

- рассредоточенное жильё на 15 % дороже «кампусов» при лучшем качестве (Emerson et al., 2000†) [183];
- с учётом стоимости жилья дома ухода дороже сопровождаемого проживания (исследование «200 Lives»†) [184].

Итого вывод «при сопоставимых потребностях затраты близки» держится на узкой базе: тезисах конференции 2000 года† [182], обзоре 2011 года, известном по аннотации† [109], отчёте DECLOC 2007 года [24] и обзоре 2019 года с двумя противоположными исследованиями [25]. Точнее говорить так: данных мало, и они противоречивы.

Единственная найденная российская оценка (Синявская и др., ВШЭ, 2022) даёт 44,8 тыс. ₽ в месяц в ПНИ и 52,9 тыс. ₽ в проектах сопровождаемого проживания [1]. Но данные по ПНИ взяты за 2019 год, по проектам — за 2021-й, и проектов всего шесть, причём с людьми высокой потребности (слайды 16, 23, 26) [1].

> **Что это значит для переговоров с Минфином.** Обещать экономию «в разы» нет научных оснований. Есть основания говорить, что дешёвое учреждение почти всегда плохое учреждение [24], а сравнения при сопоставимых потребностях немногочисленны и не показывают устойчивого разрыва ни в одну сторону [24, 25]. Это скромная позиция, но она выдерживает проверку. Сильнее звучат два других довода: качество жизни и отказ от строительства новых корпусов по 2,8 млн ₽ за койко-место [1]. Количественных данных о том, сколько длится и сколько стоит период двойного финансирования, рабочие материалы не дали; ориентиры — ирландские оценки стоимости переезда (приложение Ж).

Чем рискует человек при переезде

Риск смерти при переводе — спорная часть литературы. Калифорнийские исследования 1990-х годов сообщали о повышенной смертности в сообществе после поправки на риск:

- **около +25 %** у детей с тяжёлыми нарушениями (Strauss, Eyman, Grossman, 1996†) [188];
- **+72 %** у взрослых (Strauss, Kastner, 1996, по аннотации†) [189].

Проспективное контролируемое исследование в Нью-Джерси (Lerman, Apgar, Jordan, 2003, по аннотации†) сравнило 150 переехавших со 150 оставшимися [191]. Сам факт переезда смертность не предсказывал. Её предсказывали возраст, медицинские состояния, эпилепсия и размещение в домах престарелых† [191]. Поспешный перевод 1 711 человек в провинции Гаутенг (ЮАР) в 2016 году сопровождался гибелью 144 человек, ещё 44 пропали без вести† [194]. Насилию люди с интеллектуальными нарушениями подвергаются чаще населения: распространённость за последний год около 6 %, отношение шансов 1,60† (Hughes et al., 2012) [206].

Однако данных, разделяющих учреждения и жизнь в сообществе, нет. Имеющиеся работы совместимы с тем, что риск во многом определяется качеством подготовки перехода, но они противоречивы и не позволяют исключить эффект самого переезда. Систематического обзора смертности при деинституционализации людей с интеллектуальными нарушениями найдено не было.

Жильё и помощь при тяжёлых психических расстройствах

Для людей с тяжёлыми психическими расстройствами и опытом бездомности сильная доказательная база у модели Housing First. Метаанализ четырёх рандомизированных испытаний (Baxter et al., 2019) показал рост шансов получить стабильное жильё (RR 2,46; 95 % ДИ 1,58–3,84) [195]. Число обращений за неотложной помощью снизилось (IRR 0,63), госпитализаций — тоже (IRR 0,76). Различий в психическом здоровье, употреблении психоактивных веществ и качестве жизни не найдено, а риск систематической ошибки во всех испытаниях высок [195]. Кэмпбелловский обзор 43 исследований (Munthe-Kaas, Berg, Blaasvær, 2018) подтверждает, что такие вмешательства снижают бездомность лучше обычных услуг† [196]. Канадский эксперимент At Home/Chez Soi показал, что затраты окупаются частично: 9,60 $ экономии на каждые 10 $ у людей с высокими потребностями и 3,42 $ у людей с умеренными [168]. Полная окупаемость достигается только у 10 % самых затратных участников [168]. По данным ВОЗ, в странах со средним доходом более 70 % государственных расходов на психическое здоровье по-прежнему уходит в психиатрические больницы (Атлас психического здоровья 2020, по сообщению ВОЗ) [197]. Переносить эти результаты на жителей ПНИ можно только по аналогии.

Пробел в данных и что с ним делает доклад

Международная литература согласна в двух вещах. Качество жизни в сообществе в среднем выше. А экономия не доказана: данных о затратах при сопоставимых потребностях мало, и они противоречат друг другу. Российских работ, где цены учреждения и квартиры сравнивались бы для людей с одинаковой потребностью в помощи, в собранных материалах нет. Единственная оценка ВШЭ сравнивает разные годы и разные группы людей. Доклад не закрывает этот пробел измерением. Он показывает, от каких параметров зависит ответ: года цен, тарифа часа сопровождения, цены жилья, доли людей с лёгкой потребностью и судьбы освободившихся мест. И даёт региону калькулятор, чтобы получить ответ на своих данных (часть 6).

ЧАСТЬ 4

Что переносимо из мирового опыта

Чужой опыт полезен не как образец для копирования, а как зеркало. Таблица ниже сводит восемнадцать стран и групп стран: что там сделано, что это стоило или как измеряется результат, что из этого переносимо в российский регион и можно ли сравнивать их цены с российскими. Подробные главы по странам с полными ссылками — в приложении Ж.

Страна	Что сделано	Сколько стоило или как измеряется	Что переносимо в Россию	Цены сопоставимы с российскими
Германия	После закона BTHG помощь по интеграции учитывается отдельно; рост идёт за счёт жизни в собственном жилье, доля амбулантизации 61,5 % [116]	28,7 млрд € нетто в 2024 году [113]; особая форма проживания 48–57 тыс. € в год, своё жильё 12,6–15,2 тыс. €, без жилья и содержания [116, 117]	Считать отдельно деньги на сопровождение и на жильё; объём помощи по уровню потребности, а не по диагнозу	Нет: жильё не входит, люди разные
Англия	81,4 % взрослых 18–64 лет с нарушениями интеллекта на долговременной поддержке живут дома или с семьёй [118]; цель вдвое сократить число пациентов стационаров не достигнута [121]	Интернат для этой группы — 1 629 £ в неделю [32]; показатели ASCOF публикуются ежегодно [118]	Отдельная строка бюджета на сопровождаемое проживание; показатель «доля живущих дома»	Нет: цены supported living в статистике нет
Ирландия	Программа вывода из «конгрегированных» учреждений: в них оставались 1 953 человека в конце 2019 года и 1 415 в конце 2023-го [133, 134]	Дополнительные затраты около 80 тыс. € на переселённого† [135]; средняя стоимость переезда 140,2 тыс. € по обзору 2018 года [136]	Стоимость переезда — отдельной строкой; последние переезды дороже первых	Неизвестно
Нидерланды	Деревня Хогевейк для людей с деменцией [37]; реформа 2015 года передала часть помощи муниципалитетам [52]	Оценок исходов и эффективности затрат нет [36]	Подбор соседей по укладу жизни, малые группы	Нет: другая группа людей
Италия	Закон Базальи закрыл психиатрические больницы; в Триесте — круглосуточные центры [41]	Пребывание в резидентных структурах в среднем больше трёх лет† [141]	Районный кризисный центр; работа в кооперативах [143]	Неизвестно
Скандинавия	Норвегия закрыла учреждения в 1991–1995 годах [129]; Финляндия почти завершила закрытие [148]	Швеция, Сольна: 0,53–2,1 млн крон в год за место [127]; Дания: около 650 тыс. крон (2018) [150]	Права жильца, а не «проживающего»; не урезать лёгкую помощь	Нет: другой уровень цен и состав услуг
Япония, Корея	Страхование долговременного ухода с 2000 и 2008 годов [38, 40]	Япония: 11,5 трлн иен в 2023 году [38]; Корея: около 1,0–1,1 % ВВП в 2019 году [40]	Оценка потребности вместо диагноза; кейс-менеджер	Нет: в основном пожилые
Бразилия	Закон 10.216 (2001): психиатрических коек стало на 41 % меньше [48]	Доля госпитализаций в расходах снизилась с 95,5 до 49 % [48]	Структура бюджета может меняться без роста общей суммы	Нет: психиатрия, а не интернаты
Чехия	Трансформация с 2007 года; вызовы IROP на 3,84 млрд крон [76]	Клиентов домов для лиц с инвалидностью −8 %, домов с особым режимом +43 % за 2017–2024 годы [74]; 60 % новых мест — те же дома, только меньше [76]	Мораторий на приём; предельный размер группы в нормативном акте	Неизвестно: методика цен не видна† [79]
Грузия	Дома семейного типа на 5–6 человек на чешские деньги [83]	Стоимость не раскрывается [83]	Малые дома как пилот, но с контролем размера групп	Неизвестно
Молдова	Программа 2018–2026 годов: переселено около 10 % жителей [89]	133 интеграции и 131 возврат за 2018–2023 годы по одному расследованию [89]; место около 4,8 тыс. €, ассистенция 2,65–2,8 тыс. € в год [88]	Мерить возвраты и смертность; без моратория места заполняются [87]	Нет: ассистент — чаще родственник за 150 € в месяц
Болгария	68 «центров резидентного типа» на 3 060 человек, в среднем 45 мест [92]	50,8 млн € на инфраструктуру [92]	Не начинать с заказа зданий	Неизвестно
Литва, Латвия, Эстония, Румыния	Проекты на фонды ЕС, групповые дома и малые учреждения [102, 103, 105]	Литва: госпитализации снизились с 29 до 11 на тысячу получателей, без контрольной группы [102]	Мерить исходы с первого дня	Неизвестно
Казахстан, Беларусь	Та же модель; программ деинституционализации взрослых не найдено [96, 99]	Стоимость содержания не найдена	Отделение сопровождаемого проживания внутри интерната — ещё не выход	Неизвестно
США	Доля услуг на дому в расходах Medicaid на долговременную помощь выросла с 1,1 % в 1981 году до 63,8 % в 2023-м [152]; решение Olmstead [160]	Около 145 тыс. $ на человека в учреждении и 50 тыс. $ в программах на дому† [157]	Сначала альтернатива, потом выписка [49]	Нет: люди разные
Канада	Онтарио закрыло учреждения в 2008–2009 годах, затем коллективные иски [164, 165]	Около 100 млн канадских долларов по трём соглашениям (оценка составителя) [164–166]	Скрытая цена институционализации в смету не попадает	Неизвестно
Австралия	Страховка NDIS оплачивает групповые дома (SIL) [169]	Около 444 тыс. австралийских долларов в год на участника SIL† [169]	Деньги без правил создают малые учреждения [174, 176]	Нет
ЮАР	Спешный перевод 1 711 человек из учреждений Life Esidimeni в 2016 году [194]	144 погибших† [194]	Не переводить людей «к дате»	–

Таблица 4.1. Что сделано в других странах и что из этого переносимо. Колонки «Что переносимо в Россию» и «Цены сопоставимы с российскими» — оценка составителя по материалам приложения Ж, а не вывод источников. Подробности и все источники — в приложении Ж

Повторяющиеся ошибки

Кейсы из таблицы указывают на несколько ошибок, которые повторяются от страны к стране. Это наблюдения по отдельным историям, а не установленные причины: ни в одной стране эффект моратория или другой меры не измерен.

- **Нет запрета на новые поступления.** На его отсутствие прямо указывают чешское министерство («в эти услуги поступают новые клиенты») [76] и Keystone в Молдове [87]; там, где приём остановили, как в десяти болгарских учреждениях с марта 2018 года, закрытие хотя бы становится возможным [92].
- **Деньги идут на здания, а не за человеком.** В Чехии и Болгарии капитальные гранты без перевода текущего финансирования сопровождались созданием малых учреждений [76, 92]; в Австралии страховка оплатила групповые дома, в которых Королевская комиссия задокументировала насилие [176].
- **Размер группы закреплён в методичке, а не в законе.** Чехия собиралась закрепить критерии услуг «характера сообщества» в законе до 2025 года и не сделала [76].
- **Мерят места, а не исходы.** Молдавская пара «133 интеграции и 131 возврат» была бы невидимой, если бы журналисты не посчитали оба числа [89].
- **Спешка.** Перевод «к дате» в Гаутенге сопровождался гибелью 144 человек† [194].

Почему зарубежный разрыв в ценах не переносится

Частый вопрос к авторам подобных докладов: если за рубежом учреждение стоит втрое–вчетверо дороже квартиры, почему в России цифры близки? Ответ требует посмотреть, что именно стоит за каждой цифрой. Таблица ниже сводит пары «учреждение — сообщество» из рабочих материалов. Отношения посчитаны внутри каждой пары, чтобы не пересчитывать валюты. Российской строки в таблице нет намеренно: пара ВШЭ (44,8 и 52,9 тыс. ₽, отношение 0,85) сравнивает данные 2019 и 2021 годов и людей с разной потребностью [1]. В ценах 2025 года, если цифры ВШЭ даны в ценах года сбора, отношение было бы около 0,96 (70,8 ÷ 73,6; оценка составителя, часть 6).

Страна, год	Учреждение	Сообщество	Отношение (оценка составителя)	Потребности сопоставимы	Что включено и чего нет	Ист.
Германия, NRW 2023	Особая форма проживания: 57 160 €/год	Собственное жильё: 12 561 €/год	4,6	Нет	Только помощь по интеграции; жильё и прожиточный минимум не входят; в особых формах люди старше и с более высокими потребностями	[117]
Германия, Гессен 2024	52 066 €/год	15 209 €/год	3,4	Нет	То же	[116]
США, 2020	ICF/IID: 145 306 $/год	Программы на дому: 49 723 $/год	2,9†	Нет	Расходы Medicaid на получателя; в учреждениях — люди со сложными медицинскими и поведенческими потребностями; включены ли жильё и питание в программах на дому, в заметках не раскрыто	[157]
США, Индиана 2021	93 649 $/год	25 042 $/год	3,7†	Нет	То же; крупные частные ICF/IID — около 425 тыс. $, supported living — около 73,6 тыс. $	[158]
Чехия, около 2019	Около 400 тыс. крон/год (491 крона/сут)	Около 144 тыс. крон/год (420 крон/сут)	2,8 по годовым, 1,17 по суточным†	Неизвестно	Методика неизвестна; две пары цифр не согласуются	[79]
Молдова, 2020	Около 4 767–4 854 €/год	Персональная ассистенция: около 2 650–2 800 €/год	1,7–1,8	Неизвестно	Ассистент получает около 150 €/мес, чаще всего это родственник; это не равноценная услуга. Цена общинного дома не найдена	[88]
Англия, 2018	Дом ухода: 1 760 £/нед; стационар: 3 500 £/нед	Специализированное сопровождаемое жильё: 1 569 £/нед	1,1 к дому ухода; 2,2 к стационару†	Неизвестно	Цены для государства; изложение для парламента	[34]
Англия, 2024/25	Интернат для взрослых с нарушениями интеллекта: 1 629 £/нед	Отдельной цены supported living в статистике нет	—	Нет	«200 жизней»: с учётом жилья интернат дороже, но у его жителей выше потребности†	[32, 184]
Австралия, 2025	SIL (групповые дома): около 444 тыс. AUD/год	Участники без SIL: около 47 тыс. AUD/год	Не сравнимо†	Нет	«Без SIL» — все остальные участники схемы, включая детей и людей с лёгкими нарушениями	[169]
Великобритания, исследования	Малые и большие групповые дома	Supported living	Разницы в скорректированных затратах нет†	Да, с поправкой	Вывод известен по тезисам конференции 2000 года	[181, 182]
Великобритания, исследования	Резидентные кампусы	Рассредоточенное жильё	Кампусы на 15 % дешевле, но хуже по качеству†	Да, с поправкой	Скорректированные полные затраты	[183]

Таблица 4.2. Пары цен «учреждение — сообщество» из разных стран. Колонка «Потребности сопоставимы» — оценка составителя по описанию источников

Первая причина — разные люди. Почти во всех парах, где учреждение дороже в разы, в учреждении живут люди с наибольшими потребностями, а в «сообществе» — все остальные. В Германии доля людей старше 60 лет в особых формах проживания выросла до 29,2 % [117]; в США, по выводу рабочих заметок, в учреждениях остаются люди со сложными медицинскими и поведенческими проблемами [157]; в Австралии «без SIL» означает вообще всех остальных участников схемы [169]. Российское сравнение ВШЭ устроено наоборот: в проектах сопровождаемого проживания, судя по пересказу, большинству нужна круглосуточная помощь† [2], а цена места в ПНИ усредняет всех жителей. Если разрыв за рубежом завышен составом людей в пользу квартиры, то российский, возможно, занижен в пользу интерната. Но размер этих поправок никто не измерял.

Вторая — разные статьи затрат. Немецкие суммы не включают жильё и прожиточный минимум ни в учреждении, ни дома [117]; российская цена ВШЭ включает личные расходы жителя, но почти не видит стоимости зданий, переданных интернату безвозмездно [1]. Молдавская персональная ассистенция дёшева потому, что ассистенту платят около 150 € в месяц и это чаще всего родственник [88]: часть цены оплачивает семья своим трудом.

Третья — пустеющие учреждения дорожают. Когда из учреждения уходят люди с лёгкими потребностями, постоянные издержки делятся на всё меньшее число оставшихся, и цена места растёт. Американский разрыв в 2,9 раза, вероятно, отчасти результат сорока лет деинституционализации, а не её причина (оценка составителя; прямой проверки в рабочих материалах нет). Российские ПНИ в 2022 году были заполнены на 98,6 % [3, 5], и этого эффекта в них пока нет.

Четвёртая — цена человеческого времени. Прямых данных о том, как цена часа персонала влияет на зарубежный разрыв, в рабочих материалах нет. Зато известно, что российский интернат, по данным ВШЭ, держится на 0,56 ставки на жителя против 1,28 в проектах сопровождаемого проживания [1]. Российская «дешевизна» интерната — это дешевизна человеческого времени, а не эффективность.

Пятая — сопоставимых сравнений мало, и они противоречивы. За выводом «при сопоставимых потребностях большого разрыва нет» стоят четыре работы: тезисы конференции 2000 года по британскому исследованию группы Эмерсона† [181, 182], обзор Нэппа 2011 года, известный по аннотации† [109], отчёт DECLOC 2007 года [24] и систематический обзор 2019 года, в котором из двух отобранных исследований одно показало более низкие затраты в сообществе, а другое — значимо более высокие [25].

Что из этого следует. Зарубежные данные выводу доклада не противоречат, но и не проверяют его. Учреждение кажется дешёвым там, где оно бедно людьми, и дорогим там, где в нём остались только самые тяжёлые жители. Ни в одной стране из рабочих материалов не найдено исследования, которое показало бы, что перевод людей с сопоставимыми потребностями из учреждения в сообщество при сохранении качества помощи снижает общие расходы в разы. Поэтому немецкий, американский или молдавский разрыв нельзя предъявлять Минфину как обещание экономии. Его можно предъявлять как доказательство другого: страны, которые перевели большинство людей в обычное жильё, не разорились, хотя их расходы на поддержку растут и за счёт числа получателей, и за счёт цены случая: в Германии за 2024 год число людей вне особых форм выросло на 8,9 %, а цена случая в Гессене — на 11,8–15,3 % [116]; в США за 2023 год число пользователей услуг на дому выросло на 7,5 %, а расходы на них — на 12,8 %† [153] (приложение Ж). Для российского региона вывод тот же, что и в части 2: по российским данным разница в текущих затратах при сопоставимых потребностях не измерена, экономию обещать нельзя, а будет ли квартира дешевле для конкретной когорты, зависит от года цен, тарифа часа и цены жилья (часть 6).

Сколько тратит мир

ОЭСР измеряет расходы на долговременный уход — всё, что общество тратит на помощь людям, которые не справляются с повседневной жизнью. В 2021 году в среднем по странам ОЭСР это около 1,8 % ВВП. Больше всех тратили Нидерланды (4,4 %), затем Норвегия (3,5 %), Швеция (3,4 %) и Дания (3,2 %); Греция, Польша и Латвия — около 0,5 % или меньше [28]. В среднем на долговременный уход приходится 13 % расходов на здравоохранение, а в странах с развитыми системами — четверть и больше [28].

Страна	Расходы на долговременный уход, % ВВП	Ист.
Нидерланды	4,4	[28]
Норвегия	3,5	[28]
Швеция	3,4	[28]
Дания	3,2	[28]
Среднее по ОЭСР	1,8	[28]
Корея (2019)	около 1,0–1,1	[40]
Греция, Польша, Латвия	около 0,5 или меньше	[28]

Таблица 4.3. Расходы на долговременный уход. Российская оценка — в тексте ниже: она охватывает только текущие расходы на ПНИ и с определением ОЭСР несопоставима

Для России такой оценки в статистике ОЭСР нет. Грубый расчёт для одной лишь системы интернатов: 139 тысяч жителей × 44,8 тыс. ₽ × 12 месяцев ≈ 74,7 млрд ₽ в год [1, 3]. Если это цены 2019 года, то относительно ВВП 2024 года, принятого равным примерно 201 трлн ₽, это около 0,037 %; в ценах 2024 года (индекс потребительских цен 2019 → 2024 — 1,497 [208]) — около 112 млрд ₽, или около 0,056 %. Итого около 0,04–0,06 % ВВП (оценка составителя; значение ВВП взято округлённо из файла `calc.py`, его первоисточник в список не внесён). Сюда не входят дома-интернаты для престарелых, надомное обслуживание и система долговременного ухода, на которую в 2026 году выделено 31,5 млрд ₽ [10]. Полная цифра выше, но порядок отставания от стран ОЭСР понятен.

ЧАСТЬ 5

Россия: десять лет реформы и сто человек в Петербурге

За десять лет российская реформа прошла путь от первых методических рекомендаций до федерального закона и новых штатных нормативов. Путь от закона до квартиры для каждого, кто может в ней жить, оказался длиннее.

Хронология реформы с первой дорожной карты 2016 года до новой номенклатуры 2026 года — в приложении И.

Сколько людей вышло за ворота

Показатель	Значение	Ист.
Жители ПНИ (2024)	139 тыс.	[3]
Все отделения для людей с психическими расстройствами, по Минтруду	более 174 тыс.	[4]
Потенциал перехода, по оценке Минтруда	до 45 % жителей; около 63 тыс. (оценка составителя: 0,45 × 139 тыс.)	[6, 71]
Пользуются сопровождаемым проживанием, по Минтруду (2025)	около 8 тыс., из них 6,4 тыс. с психическими расстройствами	[4]
Живут на постоянном сопровождаемом проживании, по независимым аналитикам	не более 1,8 тыс. в 214 квартирах	[3, 6]

Таблица 5.1. Жители ПНИ, потенциал перехода и фактический охват

По данным Минтруда, в 2024 году сопровождаемым проживанием пользовались около 7 тысяч человек, в 2,7 раза больше, чем шестью годами раньше; в 2025 году — около 8 тысяч человек с инвалидностью, из них 6,4 тысячи с психическими расстройствами [4, 6]. Независимые аналитики насчитывают на постоянном проживании не более 1,8 тысячи человек в 214 квартирах [3, 6]. Оценка потенциала в 45 % жителей — старая, времён министра Топилина [71]. По сведениям Совета при Правительстве на ноябрь 2024 года, сопровождаемое проживание реализуется в 84 регионах, социальная занятость — в 69, сопровождаемая трудовая деятельность — в 67 [8]. Активнее всего формат развивается в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Свердловской областях [6]; Минтруд называет передовыми также Пензенскую, Псковскую, Челябинскую области и Якутию [3]. ВШЭ оценивала потенциальный круг получателей сопровождаемого проживания минимум в 216 тысяч человек с психическими расстройствами, а потребность в целом была покрыта, по её оценке, лишь примерно на 20 % [1]. С цифрами выше эта оценка не сходится: 1,8–8 тысяч получателей из 216 тысяч — это 1–4 % (оценка составителя). Возможно, ВШЭ считала охват иначе; согласовать оценки по рабочим материалам не удалось.

Вход в ПНИ: из детского дома-интерната в 18 лет

Выход из интерната — только половина движения. Другая половина — вход, и один из путей в ПНИ — по оценке АСИ, крупный — начинается в детском доме-интернате. По оценке Агентства социальной информации на 2018 год, около трети жителей ПНИ — бывшие воспитанники ДДИ; ещё около 20 тысяч человек жили тогда в самих ДДИ и в 18 лет переводились во взрослые интернаты† [209]. Обе цифры округлены, доля в треть приведена без ссылки на первоисточник, а 20 тысяч — это число жителей, а не ежегодный поток. Сколько выпускников ДДИ поступает в ПНИ каждый год, по стране найти не удалось.

Петербургские цифры конкретнее, но это устное заявление в пересказе городского СМИ. По словам председателя городского комитета по социальной политике Александра Ржаненкова, в 2008–2018 годах из ДДИ во взрослую сеть перевели 685 человек, из них 45 впоследствии умерли, в том числе 8 в 2018 году† [210]. Чиновник назвал долю 6,4 %; пересчёт даёт 6,6 % (оценка составителя: 45 ÷ 685 ≈ 6,57 %). Сравнения с людьми того же возраста и состояния здоровья, оставшимися в другой обстановке, нет, поэтому о повышенной смертности после перевода эта цифра не говорит. В 2023 году аппарат петербургского уполномоченного по правам человека писал, что выпускников ДДИ, «как правило», переводят в ПНИ по достижении 18 лет, и считал оптимальным, чтобы они могли и после совершеннолетия жить в знакомом ДДИ [211].

Москва пробует готовить выпускников к другой жизни. По пресс-релизам города, в 2022 году социальные дома — бывшие ДДИ — подготовили к самостоятельному или семейному проживанию более 80 выпускников; с 2014 года работает центр постинтернатной адаптации на 100 квартир, который в 2020 году помог 128 людям, и 36 из них переехали в собственные квартиры от города† [18, 212]. Это рекламные публикации, независимо их цифры не проверены; подробности — в приложении И.8.

Петербург под лупой

Доклад уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге за 2025 год — самый подробный из найденных официальных документов о том, как реформа выглядит на земле [54].

В 2025 году сопровождаемое проживание на дому в городе предоставляла 21 организация: 19 государственных и 2 НКО. В групповой форме его вели центр социальной реабилитации Адмиралтейского района (10 человек, в квартирах специализированного жилищного фонда) и две некоммерческие организации — «Новые Перспективы» и ГАООРДИ, вместе 62 человека. В индивидуальной форме — 12 районных центров реабилитации и 7 комплексных центров социального обслуживания, 28 человек. Всего за год услугу получили 100 человек, из них 72 в групповой форме, и 62 из этих 72 — у НКО. Районы сообщили о 38 получателях, у 27 из которых нуждаемость впервые определена в 2025 году; в Центральном районе таких было пятеро, в Приморском — ни одного, в большинстве остальных — по одному–три [54]. На почти шесть тысяч взрослых в домах социального обслуживания районная система обслуживает меньше 1 % (оценка составителя: 38 ÷ 5 977 ≈ 0,6 %; все 100 получателей — около 1,7 %), а основную нагрузку несут две НКО.

Петербургские правила устроены через шкалу нарушения автономии. Объём услуг по распоряжению № 1519-р зависит от балла по чек-листу: при I степени (23–68 баллов) — до 2 часов в день и до 14 часов в неделю, при II (69–136) — до 4 и до 28, при III (137–204) — до 6 и до 42. При IV степени (205–272 балла), когда человеку нужна круглосуточная помощь, сопровождаемое проживание не предоставляется: ему определяют уход на дому, систему долговременного ухода, полустационар или стационар. Уполномоченный эту норму критикует: «этой формы поддержки оказались лишены инвалиды, нуждающиеся в постоянной посторонней помощи» [54].

В показатели эффективности администраций районов включён новый показатель по сопровождаемому проживанию; районам рекомендовано использовать свободные квартиры в «социальных домах» специализированного жилищного фонда, но, по данным уполномоченного, они этого не делают [54].

По итогам мониторинга документов с ноября 2023 по декабрь 2024 года потенциал для перевода на сопровождаемое проживание на дому нашли у 116 человек, или 26 % выборки; выборка не случайная. Главным барьером уполномоченный называет жильё [54]. Подробности мониторинга, наблюдения о собственности недееспособных и о приёме проживающих — в приложении И.

Что сделано в других регионах

Регион	Что сделано	Ист.
Нижегородская область	Пилот Минтруда с 2022 года. Обследовали 350 жителей ПНИ: у каждого пятого потребность в сопровождении не более двенадцати часов в неделю. 11 человек живут в специализированном жилом доме; двое бывших воспитанников детских домов получили положенное им жильё и переехали. План на 2025 год — ещё 4 квартиры, программы в двух детских домах-интернатах, стандарты. Приказ № 860 от 02.10.2024 о пилоте организационно-финансовой модели на 2024–2025 годы. Плата за сопровождаемое проживание ограничена 15 % дохода. По сообщению «Ведомостей», открытие интернатов для волонтёров снизило число нарушений. «Регион заботы» сообщал, что 22 человека вышли из нижегородских ПНИ на сопровождаемое проживание и 14 из них работают; дата публикации не установлена. Итоги пилота 2025 года не найдены.	[4, 8, 57, 58, 69]
Ленинградская область	Мультицентр социальной и трудовой интеграции сопровождает 150 человек; создан дополнительный перечень из четырнадцати услуг, включая помощь в управлении финансами; работодатель получает до 500 тыс. ₽ на оборудование рабочего места, наставникам до трёх месяцев выплачивают стимулирующие выплаты.	[8]
Москва	Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский»: общежития более чем на 120 мест и квартиры в обычных домах. В 2021 году город объявил о передаче шести НКО девятнадцати квартир на пять лет; фактическая передача по найденным материалам не подтверждена†. За 2022 год социальные дома подготовили к самостоятельной или семейной жизни более 80 выпускников† (по пресс-релизу). Особенности услуг сопровождаемого проживания включены в стандарт стационарных услуг.	[18, 57, 212]
Санкт-Петербург	100 получателей сопровождаемого проживания в 2025 году; шкала 14/28/42 часа в неделю; потенциал у 26 % обследованных (см. выше).	[54]
Челябинская область	ВЭБ.РФ реализует проект социального воздействия в сфере сопровождаемого проживания для людей старше 18 лет с нарушениями интеллекта: проживание малыми группами в обычном жилье или сопровождение на дому. Целевое значение в отчёте о мониторинге — 12 получателей; фактические итоги в доступных материалах не опубликованы.	[20]
Якутия	ВЭБ.РФ и ГАООРДИ планировали к концу 2024 года открыть отделение постоянного сопровождаемого проживания на 12 человек и сопровождение на дому ещё для 18.	[21]
Свердловская область	Организация «Благое дело» готовила дом сопровождаемого проживания на семь человек в усадьбе 1880 года в посёлке Верх-Нейвинский, рядом со своими мастерскими.	[17]
Ярославская область	Дом «Дом как дом» для людей с тяжёлыми нарушениями: около 90 тыс. ₽ в месяц на жителя.	[7]

Таблица 5.2. Региональные практики

По Тюменской области, ХМАО, Курганской области, ЯНАО, Пензенской, Псковской и Владимирской областям первоисточников за 2024–2026 годы найти не удалось (приложение В). Сборник Минтруда и ФНОЦ им. Альбрехта о региональных практиках не прочитан.

Дееспособность и работа

Восстановление дееспособности остаётся единичным явлением. В Петербурге число лишённых или ограниченных в дееспособности проживающих за год снижалось: 196 в 2022 году, 152 в 2023-м, 106 в 2024-м, 66 в 2025-м. Восстановлений за те же годы было 1, 2, 2 и 2 (в 2025 году — двое из ДСО «Серафимовский»), а обжалований отказов — ни одного [54]. Судебные психиатры городской психиатрической больницы № 6 на встрече в январе 2025 года объяснили это скудными характеристиками, которые учреждения дают на своих подопечных, и тем, что иски подаются только о полной дееспособности; они рекомендуют просить в рамках одной экспертизы и полную, и ограниченную [54]. Похоже, реформа скорее тормозит новые лишения, чем возвращает права уже лишённым. Если перенести долю 74 % на 139 тысяч жителей, недееспособных по стране около 100 тысяч (оценка составителя: 0,74 × 139 тыс. ≈ 103 тыс.), а восстановления единичны; федеральной статистики восстановлений найти не удалось.

Тренинги по восстановлению дееспособности в ПНИ нескольких регионов дали первые единичные результаты (приложение И) [67].

С работой картина похожая. В Петербурге по итогам 2025 года из 6 270 проживающих 216 работали на штатных должностях в самих домах социального обслуживания, 52 — за их пределами, ещё 101 был трудоустроен при содействии НКО; всего 369 человек, около 5,9 % [54]. По стране в лечебно-трудовых мастерских при ПНИ занято около 7 % жителей [3, 5].

Насилие, смерти, уголовные дела

За 2023–2026 годы известны уголовные дела о смертях проживающих петербургского ПНИ № 10 [61], о тяжком вреде здоровью связанной проживающей московского «Обручевского» [62], о присвоении пенсий недееспособных в Дальнегорске [64] и о гибели привязанного к кровати подростка в детском учреждении Троицка [65]. В том же ПНИ № 10 весной 2020 года была вспышка COVID-19: к 18 мая выявили 467 случаев, 411 среди жителей и 56 среди сотрудников† [216]; сколько человек умерло, найти не удалось. Федеральной статистики смертей в ПНИ за 2024–2026 годы и от COVID-19 в 2020–2021 годах, а также прокурорских проверок и представлений за 2024–2026 годы в открытых источниках найти не удалось. Подробности дел — в приложении И.

Деньги: что известно и что нет

Конкретных сумм федерального и регионального финансирования строительства ПНИ на 2025–2026 годы и региональных тарифов на сопровождаемое проживание найти не удалось; отдельной строки «ПНИ» в найденных документах национального проекта «Семья» нет [59]. Что известно о федеральных программах и субсидиях, сведено в приложении И.

Система долговременного ухода

Рядом с реформой интернатов растёт другая федеральная система — долговременного ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью. В июне 2026 года она охватывала около 184 тысяч человек, 11 % нуждающихся (годом раньше — 10,5 %), из них 45 тысяч в сельской местности; к 2030 году охват должен вырасти до 30 %, около 500 тысяч человек. На 2026 год на неё выделено 31,5 млрд ₽, а в федеральный проект «Старшее поколение» заложено 362 млрд ₽, из которых 307 млрд — на организацию ухода [9, 10]. Для темы доклада она важна тем, что создаёт то, чего недостаёт при выходе из интерната: надомный уход и подготовленных людей. Петербургские правила прямо направляют в неё тех, кому нужна круглосуточная помощь [54].

Взгляд со стороны: Комитет ООН, 2018 год

В 2018 году Комитет ООН по правам инвалидов рассмотрел доклад России и в заключительных замечаниях (CRPD/C/RUS/CO/1) выразил глубокую обеспокоенность большим числом людей с инвалидностью в учреждениях и отсутствием стратегии деинституционализации. Он рекомендовал принять такую стратегию, развивать поддержку по месту жительства, заменить замещающее принятие решений поддерживаемым и пересмотреть законодательство о принудительном введении препаратов; упомянуты и сообщения о физической и химической фиксации в учреждениях [217]. Российская делегация назвала тогда около 150 тысяч жителей ПНИ и сказала, что деинституционализация «только начинается»† [218]. Это последние замечания Комитета по России: следующий цикл не завершён, и описывают они положение на 2018 год, а не действующее право. Подробнее — в приложении 3.

Шесть барьеров

Барьер	Суть	Что делают
Недееспособность	74 % жителей недееспособны, их опекун — интернат [3]. В Петербурге — 2 восстановления на 3 471 недееспособного за год [54].	Ленинградская область ввела услугу «помощь в управлении финансами» [8]. Минтруд рекомендует работу по восстановлению дееспособности; в 2024 году число частично недееспособных, вернувших полную дееспособность, выросло примерно в полтора раза [4]. Центр лечебной педагогики проводит тренинги и предлагает передавать функции опекуна организациям-поставщикам услуг [8, 67]. Судебные психиатры советуют просить и полную, и ограниченную дееспособность в одной экспертизе [54].
Жильё	Некуда выписываться; положенные бывшим сиротам квартиры нельзя использовать, пока человек живёт в интернате; недвижимость недееспособных простаивает [8, 54].	Нижний Новгород восстанавливает сиротские права [8]. Приказ № 305н (п. 39) и Жилищный кодекс позволяют организовывать групповое сопровождаемое проживание в свободных помещениях специализированного жилищного фонда района [54, 57]. Постановление Конституционного суда № 30-П от 18.07.2025 касается жилья сирот и к ПНИ относится лишь косвенно [72].
Плата за место	До 75 % дохода уходит учреждению [14].	Нижегородская область ограничила плату за сопровождаемое проживание 15 % дохода; приказ № 85 рекомендует снижать плату [57]. Полной стоимости жизни это не меняет, но меняет, кто её оплачивает и есть ли у человека стимул работать.
Деньги «на место»	Бюджет привязан к койкам: сократил места — потерял финансирование.	Норматив «на человека с потребностью» и включение сопровождения в региональный перечень услуг. Приказ № 305н разрешает стационарной организации оказывать услуги на дому [54, 57].
Кадры	Сопровождающих мало, зарплаты в социальной сфере неконкурентны [9]; новые нормативы № 305н убрали должности сиделок и младших медсестёр по уходу [54].	Переобучение сотрудников интернатов, которые знают людей; кейс-менеджер по японскому образцу; отдельное финансирование сопровождения выпускников [19]; обучение активной поддержке (часть 3).
Страх ответственности	«Что, если с человеком что-то случится за стенами?»	Районный кризисный центр по образцу Триеста, учебная квартира как ступенька, ясный порядок действий при обострении, медицинский план переезда.

Таблица 5.3. Шесть барьеров

Российские версии зарубежных ошибок

Ошибки, которые повторяются в других странах (часть 4), видны и в России.

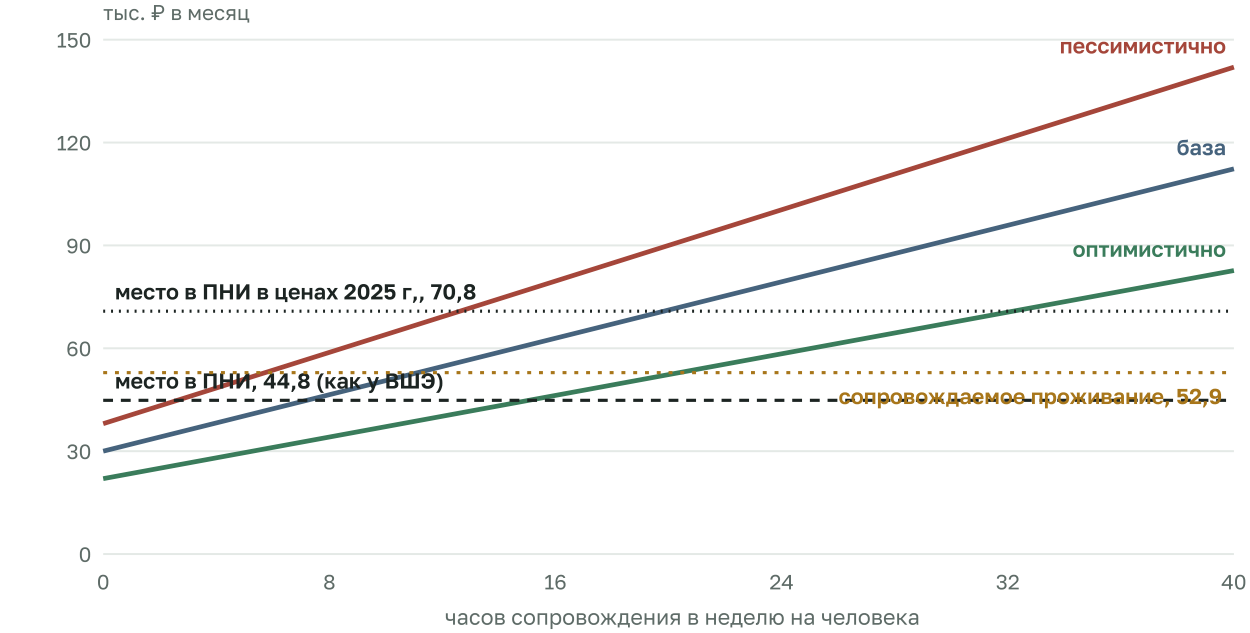
Риск	Что видно в России	Ист.
Вывеска вместо реформы	К концу 2025 года интернаты переименованы как минимум в 41 регионе; первой была Москва в 2022 году. В июле 2026 года «дом-интернат» исключён из примерной номенклатуры. В Петербурге все ПНИ стали домами социального обслуживания, но контингент и статус жителей не изменились.	[3, 5, 54, 56]
Новые большие здания	Минтруд и Минстрой объявляли программу строительства современных домов престарелых и ПНИ на 40 млрд ₽; с 2025 года федеральные средства направляются на строительство и реновацию региональных учреждений. Эксперты называют это препятствием реформе. Отдельной строки «ПНИ» в найденных документах нацпроекта «Семья» нет.	[4, 5, 23, 59]
Учёба как конечная станция	74 % участников программы — в учебных квартирах, часто на территории интерната; часть возвращается обратно.	[6]
Большие группы	В среднем 7–8 человек в квартире при рекомендованных 3–4.	[3, 6]
Выпуск без поддержки	По наблюдению «Перспектив», без сопровождения часть выпускников теряет жильё, попадает к мошенникам и возвращается в интернат†.	[19]
Недееспособность как стена	74 % жителей недееспособны, опекун — интернат; законопроект о распределённой опеке отклонён в 2025 году. В Петербурге в 2025 году — 2 восстановления дееспособности на 66 новых лишений и ограничений.	[3, 15, 54]
Отсечение тех, кому нужна круглосуточная помощь	Петербургская норма не предоставляет сопровождаемое проживание при IV степени нарушения автономии; омбудсмен считает, что этой формы поддержки лишены люди, нуждающиеся в постоянной помощи.	[54]
«Связали и забыли»	Москва, «Обручевский» (2025): связанной проживающей ампутировали обе кисти; Троицк (2022, приговор 2026): привязанный к кровати подросток умер от асфиксии.	[62, 65]

Таблица 5.4. Риски реформы в российском исполнении

ЧАСТЬ 6

Калькулятор: сколько заботы на миллион

Этот калькулятор не обещает экономии. Он показывает, при каких условиях она возможна, а при каких нет, и что именно нужно измерить в своём регионе, чтобы ответ перестал быть мнением. Все расчёты этой части — оценки составителя; формулы и допущения собраны в файле `calc.py` и в приложении Д.



Стоимость жизни в квартире в зависимости от часов сопровождения (модель составителя); горизонтальные линии — цена места в ПНИ как у ВШЭ и в ценах 2025 года.

В ценах какого года считать

ВШЭ не указала, в ценах какого года приведены 44,8 и 52,9 тыс. ₽ [1]. Калькулятор исходит из допущения, что это цены года сбора данных: для ПНИ — 2019 год (обследование НИИ труда 2019 года), для сопровождаемого проживания — 2021 год (опрос проектов ВШЭ 2021 года). Для перевода в цены 2025 года взят индекс потребительских цен Банка России, декабрь к декабрю: 2020 — 4,90 %, 2021 — 8,39 %, 2022 — 11,94 %, 2023 — 7,42 %, 2024 — 9,52 %, 2025 — 5,59 % [208]. Цены за 2019–2025 годы выросли в 1,581 раза, за 2021–2025 годы — в 1,391 раза. Если ВШЭ уже индексировала свои цифры, второй вариант их завышает. Поэтому ниже везде даны оба.

Показатель, тыс. ₽ на человека в месяц	Как в данных ВШЭ	В ценах 2025 года, если цифры ВШЭ даны в ценах года сбора
Место в ПНИ	44,8	70,8
Сопровождаемое проживание, регионы	52,9	73,6
Сопровождаемое проживание, столица	111,9	155,6

Таблица 6.1. Два варианта цен ВШЭ [1]. Индекс — по ИПЦ Банка России [208]

Цена часа сопровождения в калькуляторе — 350–600 ₽. Она привязана к московским тарифам 2026 года на социальное обслуживание на дому, 337–507 ₽ [22]. Это тарифы надомного обслуживания, а не сопровождаемого проживания, и московские, а не средние по стране. Стоимость жилья и быта тоже взята в текущих ценах. Тарифы — 2026 года, а индексация мест доведена до декабря 2025 года; разница в год сравнение слегка смещает в пользу ПНИ (оценка составителя). Значит, сравнение квартиры с местом в ПНИ «как в данных ВШЭ», вероятно, занижает цену места, а сравнение с индексированной ценой может её завышать (оценка составителя: какой вариант ближе к истине, зависит от неизвестного года цен ВШЭ).

Что можно купить на миллион рублей в год

Единица	На 1 млн ₽, как в данных ВШЭ	На 1 млн ₽, в ценах 2025 года	Основание
Место в ПНИ	1,9 человека	1,2 человека	44,8 тыс. ₽ × 12 = 537,6 тыс. ₽ в год; 70,8 × 12 ≈ 850 тыс. ₽ [1, 208]
Сопровождаемое проживание, регионы	1,6 человека	1,1 человека	52,9 × 12 = 634,8 тыс. ₽; 73,6 × 12 ≈ 883 тыс. ₽ [1, 208]
Сопровождаемое проживание, столица	0,7 человека	0,5 человека	111,9 × 12 = 1 342,8 тыс. ₽; 155,6 × 12 ≈ 1 867 тыс. ₽ [1, 208]
Часы сопровождения	1 700–2 900 ч	то же	Цена часа 350–600 ₽ уже в текущих ценах (допущение; московские тарифы надомного обслуживания 2026 года — 337–507 ₽ [22]). Это 32–55 часов в неделю круглый год, или около трёх–пяти человек на 12 ч сопровождения в неделю без учёта жилья

Таблица 6.2. Объём услуг на 1 млн ₽ в год (оценка составителя)

Один и тот же миллион — это около двух мест в интернате по цифрам ВШЭ (1,2 места в ценах 2025 года) или три–пять человек на 12 часов сопровождения в неделю без учёта жилья (точнее, 2,7–4,6). С жильём и бытом по допущениям таблицы 6.3 миллион покрывает 1,2–2,1 человека с такой потребностью, в базовом сценарии — 1,5. Какой вариант разумнее, зависит не от бюджета, а от того, что нужно конкретным людям. Поэтому первый шаг всякой реформы — обследование.

Для сравнения — не цена услуги, а выплата семье: неработающий трудоспособный человек, ухаживающий за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, получает 10 000 ₽ в месяц в базовом размере и 10 950 ₽† после индексации с 1 февраля 2025 года [213, 214]; размер после индексации февраля 2026 года не проверен. Это сырые числа, а не элемент модели: выплата не оплачивает ни часов помощи, ни жилья, и калькулятор её не учитывает (таблица 6.6, приложение И.9).

Когда квартира дешевле места

Модель предельно проста. Полная стоимость жизни в квартире равна стоимости сопровождения (часы в неделю × 52 ÷ 12 × цена часа) плюс «жильё и быт» — доля аренды и коммунальных платежей, еда, одежда. Для «жилья и быта» взяты три уровня — 22, 30 и 38 тыс. ₽ в месяц, для часа — 350, 475 и 600 ₽. Всё это допущения, а не данные. Сравнение ведётся с местом в ПНИ в обоих вариантах: 44,8 и 70,8 тыс. ₽.

Часов в неделю	Оптимистично (350 ₽, 22 тыс.)	База (475 ₽, 30 тыс.)	Пессимистично (600 ₽, 38 тыс.)
6	31,1	42,4	53,6
12	40,2	54,7	69,2
24	58,4	79,4	100,4
40	82,7	112,3	142,0
Точка безубыточности, ПНИ как в данных ВШЭ (44,8)	15 ч	7 ч	3 ч
Точка безубыточности, ПНИ в ценах 2025 года (70,8)	32 ч	20 ч	13 ч

Таблица 6.3. Стоимость жизни в квартире, тыс. ₽ в месяц на человека, и число часов сопровождения в неделю, при котором квартира стоит столько же, сколько место в ПНИ. Модель составителя

Как читать эту таблицу. Таблица не предсказывает цены, она показывает чувствительность. Если цифра ВШЭ по ПНИ уже в текущих ценах, квартира дешевле места только до 15 часов в неделю при дешёвом жилье и недорогом часе, а при дорогих — не дешевле уже на трёх часах. Если это цены 2019 года, порог поднимается до 13–32 часов в неделю. Знак разницы зависит от трёх чисел: года цен, регионального тарифа часа и стоимости жилья.

Где проходит граница лёгкой когорты. В калькуляторе «лёгкая» когорта — люди с потребностью не больше 12 часов сопровождения в неделю, по нижегородскому обследованию [8]. Петербургская шкала устроена иначе: I степень нарушения автономии допускает до 14 часов в неделю [54]. Это разные инструменты, и регион может пользоваться любым из них. При 14 часах стоимость квартиры видна в таблице 6.4.

Ограничения модели. Первое: сопровождение в ней индивидуальное. В квартире на трёх–четырёх человек часть времени специалиста делится между жильцами, а ночное дежурство одно на всех; это снижает цену, но в модель не заложено. Второе: квартира сравнивается со средней ценой места в ПНИ, а не с предельной. Когда из интерната уходят 80 человек, часть его расходов — здание, кухня, администрация — не сокращается, и реальная экономия меньше разницы средних. Третье: «жильё и быт» в 22–38 тыс. ₽ — допущение составителя. Цифра ВШЭ по ПНИ дана «включая расходы ФЛ», то есть с личными тратами жителя, и что в них входит, не расшифровано [1]. Если еда и одежда в квартире и личные траты в ПНИ учтены по-разному, часть расходов может оказаться посчитана дважды или пропущена. Для сравнения: в проектах, изученных ВШЭ, на человека приходилось 8,2 оплаченного часа в сутки, то есть почти 57 часов в неделю [1]. Это люди с высокой потребностью, и для них квартира не дешевле интерната ни в одном из вариантов.

Петербургская шкала в рублях

Петербургские правила дают готовую сетку часов: до 14 часов в неделю при I степени нарушения автономии, до 28 при II и до 42 при III [54]. Если наложить её на московский тариф надомного обслуживания 2026 года [22], получится порядок месячных расходов на одно лишь сопровождение. Это иллюстрация, а не официальный тариф: петербургские часы и московские цены относятся к разным регионам, а тариф — к другой услуге.

Степень (часов в неделю)	Сопровождение по 337 ₽/ч	Сопровождение по 507 ₽/ч	Полная стоимость: оптимистично	База	Пессимистично
I (14)	20,4	30,8	43,2	58,8	74,4
II (28)	40,9	61,5	64,5	87,6	110,8
III (42)	61,3	92,3	85,7	116,5	147,2

Таблица 6.4. Месячная стоимость по петербургской шкале, тыс. ₽ на человека (оценка составителя: часы × 52 ÷ 12 × цена часа; полная стоимость — по допущениям таблицы 6.3). Шкала — [54], тарифы — [22]

Если сравнивать с местом в ПНИ как в данных ВШЭ (44,8 тыс. ₽), даже при I степени и оптимистичных допущениях полная стоимость (43,2 тыс. ₽) лишь чуть ниже цены места, а при базовых — выше. Если сравнивать с ценой места в ценах 2025 года (70,8 тыс. ₽), I степень дешевле интерната в оптимистичном и базовом сценариях и дороже лишь в пессимистичном; II степень дешевле только в оптимистичном (64,5 тыс. ₽); III степень дороже во всех сценариях. Индивидуальное сопровождение по верхней границе часов при

II–III степени дороже интерната почти всегда. Квартира становится дешевле, если реальная потребность ниже потолка шкалы, если часть часов делится между соседями или если жильё достаётся почти бесплатно — из сиротского фонда, специализированного жилищного фонда района, собственности самого человека.

Условный регион N

Возьмём интернат на 400 мест. Его годовые текущие расходы — 400 × 44,8 тыс. ₽ × 12 ≈ 215 млн ₽ по цифрам ВШЭ или 400 × 70,8 × 12 ≈ 340 млн ₽ в ценах 2025 года. Допустим, что, как в Нижегородской области, у каждого пятого жителя — 80 человек — потребность не превышает двенадцати часов в неделю. Это допущение для иллюстрации; долю нужно измерить.

Допущение	Квартира, тыс. ₽ в месяц	Разница на 80 человек, ПНИ как в данных ВШЭ (44,8), млн ₽ в год	Разница на 80 человек, ПНИ в ценах 2025 года (70,8), млн ₽ в год
Оптимистично: 350 ₽ в час, жильё и быт 22 тыс.	40,2	−4,4	−29,4
База: 475 ₽, 30 тыс.	54,7	+9,5	−15,5
Пессимистично: 600 ₽, 38 тыс.	69,2	+23,4	−1,6

Таблица 6.5. Перевод 80 человек с лёгкой потребностью в квартиры: разница с ПНИ по средней цене места, млн ₽ в год (оценка составителя)

Если перевести ещё сто человек, доведя долю до 45 %, в групповое сопровождаемое проживание по средней цене ВШЭ, это добавит 9,7 млн ₽ в год к стоимости их мест в интернате по цифрам ВШЭ или 3,3 млн ₽ в ценах 2025 года; по столичной цене — 80,5 и 101,7 млн ₽.

К этим текущим суммам нужно прибавить стоимость самих переездов. Отечественной оценки нет. Ирландские цифры описывают разные показатели: около 80 тыс. € дополнительных затрат на переселённого по оценке Национального управления по делам инвалидности† [135] и 140,2 тыс. € средней стоимости переезда по обзору 2018 года [136]. Они относятся к другой стране и другим ценам и годятся лишь как напоминание, что такая строка в бюджете должна быть.

Что показывает расчёт. Если цифры ВШЭ даны в ценах года сбора, квартира для лёгкой когорты дешевле места в ПНИ во всех трёх сценариях; если ВШЭ уже дала текущие цены — только в оптимистичном. Знак разницы, таким образом, зависит от года цен и от регионального тарифа, и ответ можно получить только на своих данных. Обе оценки завышают экономию в одном отношении: они берут среднюю, а не предельную цену места. И обе занижают её в другом: сопровождение в них не делится между соседями. Если освободившиеся места тут же займут люди из очереди — а заполненность интернатов в 2022 году составляла 98,6 % [3, 5], — общие расходы не снизятся. Реформа тогда увеличит охват, а не уменьшит бюджет. Для людей это хорошая новость; Минфину её нужно сообщить заранее. Чешский и молдавский опыт указывает, что без остановки приёма так и происходит [76, 87]. Переходный фонд на годы двойного финансирования закладывается обязательно [24].

Что регион может посчитать сам

Полную стоимость места в своём интернате, включая питание, медицину, коммунальные услуги, управление и капитальный ремонт, и отдельно — какие из этих расходов реально сократятся, если уйдут 80 человек. Год, в ценах которого посчитана каждая цифра. Распределение жителей и людей из очереди по часам потребности — по итогам обследования, например по петербургскому чек-листу. Тариф часа сопровождения: зарплату специалиста с налогами, дорогу, администрирование, долю времени, которую можно разделить между соседями. Стоимость аренды или социального найма квартиры на трёх–четырёх человек и наличие свободных квартир в специализированном жилищном фонде. Размер платы жителя в интернате и в квартире. И переходный фонд: оплаченные места плюс уже открытые квартиры плюс стоимость переездов.

Где искать деньги

Механизм	Пример	Оговорка
Перенос части бюджета со статьи интерната на статью сопровождения	Бразилия: внебольничные расходы превысили больничные с 2006 года [48]; Германия: рост помощи по интеграции почти целиком за счёт людей в собственном жилье [116]	Работает, если места действительно сокращаются и приём ограничен
Дополнительный перечень социальных услуг	Ленинградская область, 14 услуг [8]	Услуга вне перечня не финансируется
Услуги на дому от стационарной организации	Приказ № 305н разрешает стационарной организации оказывать услуги на дому [54, 57]	Нужен тариф и норматив, а не «в нагрузку»
Специализированный жилищный фонд района	Приказ № 305н, п. 39; петербургские «социальные дома» [54]	Районы фонд пока не используют
Субсидия работодателю	Ленинградская область, до 500 тыс. ₽ [8]	Из существующих программ занятости
Внебюджетные деньги под результат	ВЭБ.РФ в Челябинской области и Якутии [20, 21]; Golden Lane Housing в Англии [35]	Итоги российских проектов пока не опубликованы
Федеральные субсидии	«Доступная среда», с 2019 года [8]	Объём доступа нужно уточнять
Донорские и грантовые деньги на жильё	Чешская помощь в Грузии и Молдове [83, 91]	Покрывают капитальные затраты, но не текущие; работают точечно
Поддержка семьи, чтобы человек не попал в интернат	Федеральная выплата по уходу за ребёнком-инвалидом и инвалидом с детства I группы: 10 000 ₽ базово, 10 950 ₽† с 1.02.2025; с 2025 года её получают и другие неработающие ухаживающие; в Вологде и области с районным коэффициентом — 12 592,50 ₽, в Череповце — 13 687,50 ₽ [213, 214]	Это выплата, а не тариф услуги; размер после индексации в феврале 2026 года не проверен; помощь на дому и передышку для семьи она не заменяет
Приёмные семьи для пожилых и инвалидов	Минтруд в 2020 году обещал регионам методические рекомендации; федерального закона, по публикации 2020 года, не было† [215]	Рекомендации не нормативный акт; размер выплат и охват не проверены

Таблица 6.6. Источники денег

ЧАСТЬ 7

План для региона: сначала люди, потом здания

Ничего из сказанного выше не требует ждать нового федерального закона. Требуется последовательность: сначала узнать людей, потом посчитать, потом написать правила и только потом переселять. Зарубежный опыт добавляет к этой последовательности три жёстких условия, без которых она буксует: ограничить приём, пустить деньги вслед за человеком и мерить исходы, а не места.

Три условия до начала

1. **Обследование проводят внешние специалисты, а не интернат-опекун.** Учреждение, которое одновременно опекун большинства жителей и получатель денег за их места, — не лучший оценщик их готовности жить самостоятельно.
2. **В обследование включают очередь в ПНИ.** Люди, которые ждут места, — тоже кандидаты на сопровождаемое проживание, и без них нельзя понять, займут ли они освободившиеся места.
3. **Судьбу освободившихся мест решают до старта.** Закрыть их, перепрофилировать или заполнить из очереди — от этого решения зависит, сократит реформа расходы или расширит охват (часть 6).

Пять шагов

Шаг	Содержание	Срок
1. Обследование	Междисциплинарная оценка всех жителей и людей из очереди силами внешних специалистов: потребность в часах, навыки, жильё, семья, правовой статус, медицинские риски переезда (эпилепсия, нарушения глотания, тяжёлые соматические болезни). Разделение на когорты — лёгкую (до 12 часов в неделю по нижегородскому порогу; петербургская I степень — до 14 часов), среднюю и тяжёлую. Образцы — нижегородский и петербургский [8, 54].	3–6 месяцев
2. Расчёт	Таблицы части 6 на собственных тарифах и в ценах одного года; предельная, а не только средняя стоимость места. Решение о судьбе освободившихся мест и о приёме новых жителей — до первых переездов. Размер переходного фонда, включая стоимость переездов.	1–2 месяца
3. Правила	Региональный порядок сопровождаемого проживания в развитие постановления № 910 и приказов № 85 и № 305н; перечень услуг; норматив «на человека»; порядок учебных квартир; сниженная плата по нижегородскому образцу; субсидия работодателям; стандарт сопровождения выпускников; предельный размер группы [12, 13, 19, 55, 57].	6–12 месяцев
4. Первая волна	Пятнадцать–тридцать человек из лёгкой когорты; учебная квартира как ступенька к постоянной; первые рабочие места; обучение персонала активной поддержке; медицинский план переезда для каждого.	1–2 год
5. Масштаб	Перепрофилирование корпусов в малые дома, жилищный фонд, кейс-менеджеры, целевые значения размера групп и числа людей за пределами интерната; ограничение приёма в интернат для молодых людей и выпускников детских домов-интернатов, когда для них есть альтернатива.	2–5 год

Таблица 7.1. Пять шагов

По оценке составителя, план должен касаться не только тех, кто уже живёт в интернате: его частью стоит сделать закрытие входа. Это подготовка выпускников детских домов-интернатов, которых в 18 лет, как правило, переводят в ПНИ [211]: включать их в обследование до совершеннолетия и искать для них учебную квартиру, сопровождение или поддержку семьи раньше, чем место во взрослом интернате. Иначе, по той же оценке, освободившиеся места могут занять вчерашние воспитанники ДДИ; насколько велик этот поток, по стране неизвестно (часть 5).

Что можно сделать без новых денег

Назначить ответственного за сопровождаемое проживание на уровне заместителя руководителя и дать ему календарь, а не поручение «в нагрузку». Открыть интернат для внешних глаз: дни семей, волонтёры, независимые визиты, публичная страница; по сообщению «Ведомостей», в Нижегородской области открытие интернатов для волонтёров снизило число нарушений [4]. Расселить жителей по укладу жизни и дружбе, а не только по диагнозам, — в тех комнатах, что уже есть. Заменить часть обслуживания обучением: готовка, деньги, транспорт. Обучить хотя бы одну смену активной поддержке. Включить в обследование вопрос о восстановлении дееспособности и подавать иски так, как советуют судебные психиатры, — и о полной, и об ограниченной дееспособности сразу [54]. Найти первую квартиру: муниципальный фонд, служебное жильё, социальный наём, свободные помещения специализированного жилищного фонда. Запросить готовые документы у Нижегородской и Ленинградской областей, Москвы и Петербурга, а не писать свои с нуля. Закрепить в договорах право семей на посещения и информацию. Запретить фиксацию без медицинских показаний и документировать каждый её случай.

Чему научил чужой опыт

Из зарубежного опыта (часть 4 и приложение Ж) следуют пять правил, которые стоит вписать в региональную программу. Не начинать с заказа зданий: в Болгарии и Чехии капитальные деньги без текущих сопровождались созданием малых учреждений — центров в среднем на 45 мест и малых домов для лиц с инвалидностью [76, 92]. Остановить приём хотя бы для молодых: без этого освободившиеся места заполняются, как в Чехии и Молдове [76, 87]. Закрепить предельный размер группы в нормативном акте, а не в методичке: три-четыре человека, как рекомендует Минтруд, а не семь-восемь, как получается на практике [6]. Мерить смертность, возвраты и качество жизни с первого дня: молдавский счёт «133 на 131» виден только потому, что кто-то посчитал оба числа [89]. И никогда не переводить людей «к дате»: спешный перевод в Гаутенге сопровождался гибелью 144 человек† [194].

Шесть вопросов, которые стоит задать себе до начала

Что будет с освободившимися местами: мы их закроем или заполним из очереди? Кто будет отвечать за человека за пределами интерната, если опекуном остаётся директор? Какой размер группы мы считаем нормой и почему? Что мы будем мерить: число переведённых или то, как они живут через год? Что подхватит расходы на третий год, когда закончится пилот? Кто со стороны видит, что происходит внутри?

Как мерить результат

Показатель	Как считать
Люди за пределами интерната через год	Только постоянное проживание, без учебного
Возвраты	Доля вернувшихся в интернат за первый и второй годы
Смертность	Среди переехавших и оставшихся, с учётом возраста и тяжести состояния
Качество жизни	Индекс по методике ВШЭ до переезда и после
Полная стоимость на человека	Включая жильё и быт, а не только сопровождение
Размер групп	Среднее и максимум по квартирам
Работа	На открытом рынке, а не в мастерской при учреждении
Дееспособность	Число восстановлений и новых лишений за год
Безопасность	Вызовы скорой, экстренные госпитализации, жалобы, случаи фиксации, смерти

Таблица 7.2. Показатели результата

Мир за полвека прошёл путь от острова Лерос до маленьких домов, где люди сами решают, что приготовить на ужин. Он заплатил за этот путь ошибками, которые нам не обязательно повторять, — и ближайшие соседи добавили к ним свои: малые учреждения вместо жизни в сообществе, реформу, которая кормит учреждения, переименование вместо перемен. Российские регионы уже сделали первые шаги. Следующие зависят не столько от размера бюджета, сколько от того, захотим ли мы узнать каждого жителя интерната по имени и посчитать, сколько на самом деле стоит его жизнь.

ДОКЛАД

Заключение: что из этого следует для политики

Главный вывод доклада скромнее, чем хотелось бы сторонникам реформы. По российским данным разница в текущих затратах между интернатом и сопровождаемым проживанием при сопоставимых потребностях не измерена. С учётом капитальных затрат диапазоны перекрываются: 52,8–68,8 тыс. ₽ в месяц для ПНИ против 54,9–58,9 тыс. ₽ для сопровождаемого проживания в ценах данных ВШЭ [1]. Экономию обещать нельзя. Аргументы за реформу — качество жизни и отказ от строительства новых корпусов по 2,8 млн ₽ за койко-место [1]. Зарубежные данные этому выводу не противоречат, но и не проверяют его: там сравнивают других людей и другие статьи затрат, а сравнений при сопоставимых потребностях мало, и они противоречивы.

Будет ли квартира дешевле для конкретной группы жителей, решают не средние цифры, а три местных числа: год, в ценах которого посчитана стоимость места, тариф часа сопровождения и цена жилья. По калькулятору доклада при одном допущении о годе цен людям с лёгкой потребностью квартира обходится дешевле интерната во всех сценариях, при другом — только в оптимистичном. Людям, которым помощь нужна большую часть суток, она при индивидуальном сопровождении не дешевле ни при одном из двух допущений; разделяемое сопровождение калькулятор не учитывает. Региону, который хочет знать ответ, придётся посчитать его на своих данных.

Повторяющиеся ошибки соседей связаны не с ценой квартиры, а с тем, куда направлялись деньги. В Чехии и Болгарии вложения в перемены сопровождались созданием малых учреждений, в Молдове — ростом бюджетов старых и, по данным одного расследования, почти таким же числом возвратов, как выходов; в Австралии страховка оплатила дорогие групповые дома. Кейсы указывают, что денег на реформу недостаточно и нужны правила, которые не дают деньгам снова осесть в здании: запрет на новые поступления, финансирование вслед за человеком, предельный размер группы в нормативном акте. Эффект таких правил ни в одной из описанных стран не измерен, поэтому это выводы из историй, а не доказанные причины.

Для регионального министра из этого следуют четыре решения. Не строить новые корпуса под очередь, пока не посчитано, сколько людей из этой очереди может жить в квартирах. Поручить обследование жителей и очереди внешним специалистам, а не интернату-опекуну. До начала переездов решить, что будет с освободившимися местами, и сообщить финансистам, что реформа может расширить охват, а не сократить бюджет. И мерить людей, а не места: часы потребности, возвраты, смерти, дееспособность и качество жизни. Петербургская шкала часов, нижегородская плата в 15 % дохода и ленинградский перечень услуг показывают, что инструменты для такого счёта в России уже есть; их результаты пока не опубликованы. Не хватает решения пользоваться ими везде и публиковать то, что они покажут.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Словарь

Термин	Значение
Долговременный уход	Помощь людям, которые из-за состояния здоровья не справляются с повседневной жизнью: еда, гигиена, жильё, передвижение, общение.
Деинституционализация	Переход от больших учреждений к жизни в обычном жилье с поддержкой. Не закрытие здания, а перенос помощи к человеку.
Сопровождаемое проживание	Российская форма поддержки жизни в квартире или малой группе по индивидуальному плану (статья 9.1 закона № 181-ФЗ).
Учебное проживание	Временное обучение навыкам самостоятельной жизни, часто на территории интерната.
ДСО	Дом социального обслуживания — новое название бывших ПНИ в Петербурге и наименование в примерной номенклатуре 2026 года.
Степень нарушения автономии	В петербургских правилах — результат оценки по чек-листу (I–IV степени, 23–272 балла), от которого зависит объём часов сопровождения.
Housing First	«Сначала жильё»: постоянная квартира без предварительных условий, поддержка приходит следом.
Supported living	Жизнь в обычном жилье с индивидуальной поддержкой; английский аналог постоянного сопровождаемого проживания.
Active Support (активная поддержка)	Методика работы персонала, при которой сотрудник не делает за человека, а организует его участие в повседневных делах.
Eingliederungshilfe	Немецкая помощь по интеграции людей с инвалидностью по девятой книге Социального кодекса; после закона BTHG учитывается отдельно.
Особая форма проживания (besondere Wohnform)	Немецкое название бывших стационаров для людей с инвалидностью после реформы BTHG.
HCBS	Услуги на дому и по месту жительства в американской системе Medicaid.
ICF/IID	Американские промежуточные учреждения ухода для людей с нарушениями интеллекта, оплачиваемые Medicaid.
SIL	Supported Independent Living — оплачиваемое австралийской схемой NDIS проживание с поддержкой, в основном в групповых домах.
DOZP, DZR	Чешские дома для лиц с инвалидностью и дома с особым режимом.
Малая институция	Небольшое учреждение (групповой дом, малый дом), сохраняющее учрежденческий распорядок, культуру и зависимость жителей.
Мораторий на приём	Запрет принимать новых жителей в учреждение, которое предстоит закрыть или трансформировать.
Распределённая опека	Возможность иметь нескольких опекунов, а не только интернат. Законопроект отклонён в 2025 году.
Двойное финансирование	Период, когда оплачиваются и старая, и новая системы; обычно несколько лет.
Кейс-менеджер	Специалист, собирающий для человека пакет помощи из разных служб.
Трансинституционализация	Мнимый выход: человек покидает интернат, но оказывается в другой закрытой структуре — тюрьме, доме престарелых, частном пансионе без контроля.
СДУ	Система долговременного ухода для пожилых и людей с инвалидностью.
Цены 2025 года	Суммы, пересчитанные по индексу потребительских цен Банка России (декабрь к декабрю) из цен года сбора данных; используются в калькуляторе как второй вариант.
OPEX и CAPEX	Текущие (операционные) и капитальные затраты. Путаница между ними стала главной ошибкой первой версии доклада.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Журнал изменений

Изменения в редакции 6.1 по сравнению с редакцией 6

Дополнения сделаны по рабочим заметкам исследования пробелов от 20.10.2026 (как оно проводилось — в приложении Е). Новых выводов о стоимости они не дают; калькулятор не менялся.

№	Было в редакции 6	Стало в редакции 6.1
1	Путь из ДДИ в ПНИ не описан	В части 5 — подраздел «Вход в ПНИ: из детского дома-интерната в 18 лет»: около трети жителей ПНИ — бывшие воспитанники ДДИ и около 20 тыс. жителей ДДИ (АСИ, 2018†); Петербург, 2008–2018: 685 переведённых и 45 умерших (названо 6,4 %, пересчёт — 6,57 %, сравнения нет†); заявление аппарата омбудсмена 2023 года; московские программы выпуска†. Подробности — новое приложение И.8.
2	Оценка Комитета ООН по России не приводилась	Часть 5 — краткий подраздел «Взгляд со стороны: Комитет ООН, 2018 год»; приложение З — пп. 17–18, 26–27, 34–36 и 40–41 замечаний CRPD/C/RUS/CO/1 и позиция делегации (около 150 тыс. жителей ПНИ†). Оговорено, что это оценка 2018 года и что следующий цикл не завершён.
3	Поддержка семей не рассматривалась	Таблица 6.6 — строки о выплате по уходу (10 000 ₽, 10 950 ₽† с 1.02.2025, вологодские суммы) и о приёмных семьях для пожилых (Минтруд, 2020†); в части 6 — выплата как точка сравнения без включения в модель; новое приложение И.9. Индексация февраля 2026 года не проверена.
4	Вспышка COVID-19 в ПНИ не упоминалась	Часть 5 и приложение И.4: ПНИ № 10, 467 случаев к 18.05.2020†; число смертей не установлено.
5	Москва: «шесть НКО получили девятнадцать квартир»; 80+ выпускников без оговорки	«Город объявил о передаче»; фактическая передача не подтверждена; 80+ выпускников помечены † как цифра пресс-релиза. Метка источника [18] уточнена: «прочитан (пресс-релиз)»; метка [19] (новость АСИ о предложении «Перспектив») изменена на «вторичный пересказ», а наблюдение «Перспектив» в таблице рисков части 5 помечено †.
6	Знак † — только поисковая выдача, аннотация, пересказ	Знак † ставится и у цифр из пресс-релизов без независимой проверки.
7	—	Часть 7: подготовка выпускников ДДИ как часть плана (оценка составителя). Резюме для министра: пункты 10 и 11.
8	—	Приложение В: открытые пробелы по итогам поиска 20.10.2026 и раздел «Проверено и не подтвердилось» (ПП № 481, дата и формулировка перехода 1 200 → 10 000 ₽, выплаты приёмным семьям в Татарстане).
9	—	Хронология (таблица И.1): 2018 год (рассмотрение в Комитете ООН) и май 2020 года (COVID-19 в ПНИ № 10). Приложение Д: пересчёт 45 ÷ 685 и вологодских сумм.
10	208 источников	Добавлены источники 209–218.

Изменения в редакции 6 по сравнению с редакцией 5

Правки сделаны по внутренней рецензии отдельной ИИ-сессии и выводам совета трёх ИИ-сессий от 19.10.2026; это не внешняя рецензия.

№	Было в редакции 5	Стало в редакции 6
1	Калькулятор сравнивал 44,8 тыс. ₽ (данные 2019 года) и 52,9 тыс. ₽ (2021) с ценой часа и жилья в текущих ценах	В `calc.py` добавлена индексация по ИПЦ Банка России [208]: 2019→2025 — 1,581, 2021→2025 — 1,391. Везде даны два варианта: «как в данных ВШЭ» (44,8 / 52,9) и «в ценах 2025 года» (70,8 / 73,6; столица 155,6). Оговорено, что ВШЭ год цен не указала. Таблица 6.1 — новая; таблицы 6.2–6.5 (бывшие 10.1–10.4) пересчитаны: на 1 млн ₽ — 1,18 места в ПНИ и 1,13 человека в сопровождаемом проживании в ценах 2025 года; точки безубыточности 15/7/3 и 32/20/13 ч в неделю; регион N — 215 и 340 млн ₽ в год; когорта из 80 человек — −4,4/+9,5/+23,4 и −29,4/−15,5/−1,6 млн ₽ в год.
2	Ограничения калькулятора названы частично	Названы явно: сопровождение индивидуальное, а не разделяемое; цена места средняя, а не предельная; «жильё и быт» — допущение, возможно пересечение с «расходами ФЛ»; цена часа привязана к московским тарифам надомного обслуживания.
3	«Три–пять человек в своих квартирах» на 1 млн ₽	«Три–пять человек на 12 ч сопровождения без учёта жилья»; с жильём — 1,2–2,1 человека.
4	Центральный тезис «не дешевле, но лучше», «квартира дороже на 18 %» в заголовках	Тезис: разница в текущих затратах при сопоставимых потребностях не измерена; с учётом капитальных затрат диапазоны перекрываются (52,8–68,8 против 54,9–58,9 тыс. ₽); экономию обещать нельзя; аргументы — качество жизни и отказ от новых корпусов (2,8 млн ₽ за койко-место). 18 % оставлены только как сырое сравнение с оговорками. Заголовок части 2 сохранён как описание двух цифр.
5	Резюме и заключение сильнее тела доклада	Применены строки таблицы рецензии с вердиктами «преувеличено», «не подтверждено», «частично»: убраны «проверила на двух десятках стран», «размер группы и есть качество», «открытость защищает лучше любой проверки», скандинавское «возвращает в учреждения», «а не сам факт переезда» без оговорки, 308 молдавских смертей; добавлены † у очереди 2,8 тыс., разведены ирландские 80 и 140,2 тыс. €, оговорка о деменции в чешских DZR, «экспертная пилотная оценка» у индекса качества жизни, «в обследованных выборках», «данных мало и они противоречивы».
6	Одиннадцать частей, около 23,5 тыс. слов до приложений	Семь частей. Страновые части 4–7 перенесены в приложение Ж; подробный обзор доказательств — в приложение З; российские подробности (хронология, мониторинг петербургских документов, уголовные дела, динамика персонала, федеральные деньги, расхождения в числе жителей) — в новое приложение И; в основном тексте — часть 4 «Что переносимо из мирового опыта» со сводной таблицей 4.1 и сравнением цен. Таблица российских рисков перенесена в часть 5.
7	Часть 3 — подробный обзор на 3 тыс. слов	Часть 3 переписана по черновику обзора литературы: четыре темы (исходы, затраты, риски переезда, жильё при тяжёлых психических расстройствах) и пробел в данных; метки † сохранены. Подробная версия — приложение З.
8	Таблица 8.1 с российской строкой рядом с зарубежными	Таблица 4.2 без российской строки, с колонкой «потребности сопоставимы». Российская пара вынесена в текст.
9	Россия: около 0,04 % ВВП (цены 2019 года к ВВП 2024 года)	Около 0,04–0,06 % ВВП: 0,037 % в ценах 2019 года и 0,056 % в ценах 2024 года (индекс 2019→2024 — 1,497). Российская строка таблицы ОЭСР перенесена в текст.
10	План без условий совета	В часть 7 добавлены три условия: обследование силами внешних специалистов, включение очереди в ПНИ, решение о судьбе освободившихся мест до старта.
11	«Оценка автора»	«Оценка составителя».
12	Порог лёгкой когорты 12 ч не согласован с петербургской I степенью (до 14 ч)	Объяснены оба порога (часть 6, часть 7).
13	Таблица 1.1: строка «Койка» без цены	Строка убрана. Московские тарифы помечены как тарифы надомного обслуживания.
14	Таблица 2.2: прочерк; «вдвое больше внимания»; «десятки тысяч новых сотрудников»	«Нет данных»; «по всем сотрудникам 8,2 против 3,5»; «154 тысячи ставок».
15	Охват «около 20 %» по ВШЭ без сверки	Отмечено расхождение с расчётом 1–4 % (часть 5, приложение В).
16	Скандинавия: «около 87–100 тыс. €»	Убрано: противоречило правилу не пересчитывать валюты.
17	Страновые части 4–7 редакции 5 (стали приложением Ж)	Скандинавский урок переписан без утверждения о возврате в учреждения; Гаутенг — «сопровождался гибелью»; к молдавским цифрам добавлены оговорки о знаменателе; к сравнению с Казахстаном — о разных типах учреждений.
18	Предисловие пересказывало историю редакций; заключение «что меняет пятая редакция»	В предисловии две фразы о прежних редакциях; история — здесь; заключение посвящено политическим выводам.
19	207 источников	Добавлен источник 208 (Банк России, ИПЦ).

Что изменилось в редакции 5 (текст предисловия редакции 5)

Четвёртая редакция исправила главную ошибку первой: диапазоны 8–24 тыс. ₽ для интерната и 2–6 тыс. ₽ для сопровождаемого проживания оказались капитальными, а не текущими затратами. Текущие расходы на одного человека в месяц, включая его личные траты, НИУ ВШЭ оценила в 44,8 тыс. ₽ для интерната и 52,9 тыс. ₽ для проектов сопровождаемого проживания [1]. Из этого следовал трудный, но прочный вывод: реформа не обещает экономии, она обещает другое качество жизни за сопоставимые деньги. Пятая редакция этот вывод сохраняет.

Нового в ней много. Появилась отдельная часть о Восточной Европе и постсоветских странах: Чехии, Грузии, Молдове, Болгарии, Казахстане, Беларуси, Литве и Румынии. Расширен рассказ о Западной Европе: немецкая помощь по интеграции (Eingliederungshilfe) после реформы BTHG, английские расходы на людей с нарушениями интеллектуального развития, ирландская программа вывода из «конгрегированных» учреждений, Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания. Появилась часть о США, Канаде и Австралии. Доказательная база вынесена в самостоятельную большую часть: систематические обзоры исходов, Active Support, смертность после переезда, Housing First, данные ВОЗ. Российская часть дополнена данными доклада петербургского уполномоченного по правам

человека за 2025 год, приказом Минтруда № 305н, новой номенклатурой без слова «дом-интернат», уголовными делами 2023–2026 годов и нижегородской нормой о плате в 15 % дохода. Отдельная часть сводит международные цены и объясняет, почему разрыв «в разы», который видно за рубежом, нельзя просто перенести на Россию.

Изменилось и обращение с источниками. Каждый источник теперь помечен по способу доступа, а знак † стоит у всего, что держится на поисковой выдаче, аннотации или пересказе. Несколько утверждений четвёртой редакции, у которых не было источника, убраны из основного текста в приложение В. Полный журнал изменений — в приложении Б, а раскрытие того, как готовился доклад, — в приложении Е.

Изменения в редакции 5 по сравнению с редакцией 4

Номера частей и таблиц в этой таблице — по редакции 5.

№	Было в редакции 4	Стало в редакции 5
1	Восемь частей; зарубежный опыт — восемь стран	Одиннадцать частей. Добавлены часть 5 (Восточная Европа и постсоветские страны), часть 6 (США, Канада, Австралия), часть 8 (сопоставление международных цен с оговорками); часть «Что знает наука» расширена до самостоятельного обзора доказательств.
2	Источники без меток доступа	У каждого источника указан способ доступа; знак † стоит у всего, что держится на поисковой выдаче, аннотации или пересказе. Номера 1–53 совпадают с редакцией 4, новые источники — 54–207.
3	Индекс качества жизни (76,9/56,9 и компоненты 84,7/44,3 и др.) и утверждение о круглосуточной потребности в проектах — без оговорок	Помечены †: они известны по пересказу АСИ [2], а не по тексту презентации ВШЭ.
4	Диапазон 50–120 тыс. ₽ из «Известий» без оговорки	Помечен †: это пересказ исследований в газете.
5	Mencap 2018: 1 569 / 1 760 / 3 500 £ без оговорки	Помечены †: источник — изложение для парламента.
6	Дания: переход к жилью из отдельных квартир в конце 1980-х (†, без источника)	Перенесено в приложение В: источника в рабочих материалах нет.
7	Греция: BBC в больнице Дромокаитио (†, без источника)	Перенесено в приложение В.
8	«Россия ратифицировала Конвенцию в 2012 году» без источника	Убрано из текста: источник в списке отсутствовал.
9	Сравнение с Майкопом	Убрано: численность города не подкреплена источником.
10	Санкт-Петербург: «68 кандидатов на индивидуальное и 48 на групповое» со ссылкой на отчёт за 2024 год	Уточнено по первоисточнику — докладу уполномоченного за 2025 год [54]: это итог мониторинга 11.2023–12.2024 (116 человек, 26 % выборки). Добавлены данные о 100 получателях, шкале часов, дееспособности и занятости.
11	Приказ № 85: «балльная шкала 23–272 балла и четыре степени» в списке неподтверждённого	Шкала подтверждена в петербургском распоряжении № 1519-р по докладу уполномоченного [54]; связь именно с приказом № 85 по-прежнему не подтверждена.
12	Правила расчёта дохода — постановление № 1075 (2014); зарплата в интернате не учитывается	Добавлено противоречие: «Особое право» называет постановление № 1873 от 23.12.2024 и пишет, что зарплата участника сопровождаемого проживания учитывается [57]. Согласовать не удалось.
13	At Home/Chez Soi: компенсация затрат на 54 %	Сохранено и дополнено цифрами итоговых «главных выводов»: 9,60, 3,42 и 21,72 $ экономии на 10 $ [168]; объяснено, что это разные разрезы.
14	Англия: 2 115 человек в стационарах (июль 2026)	Сохранено; добавлены ход программы Building the Right Support [121], цели NHS на 2025/26 год† [122] и пересказ PA о 2 025 людях в 2025 году† [123].
15	Германия: только страхование ухода	Добавлена помощь по интеграции: 28,7 млрд € (2024), цены случая 48–57 тыс. € и 12,6–15,2 тыс. € с оговоркой о жилье [113–117].
16	США: только история криминализации	Добавлены доля HCBS 63,8 % [152], стоимость ICF/IID и программ на дому† [157], закрытия учреждений, Olmstead, данные о койках 2023 года [162].
17	Финляндия: только Housing First	Добавлены данные о закрытии учреждений для людей с нарушениями интеллекта [148].
18	Норвегия, Ирландия, Австралия, Канада, Восточная Европа — отсутствовали	Добавлены [74–112, 129–138, 164–176].
19	Россия: хронология до сентября 2026 года без приказа № 305н и номенклатуры	Добавлены приказ № 305н [55], новая номенклатура [56], нижегородский приказ № 860 [58], уголовные дела [61–66], тренинги по дееспособности [67].
20	Калькулятор: таблицы 7.1–7.3	Сохранены как таблицы 10.1, 10.2, 10.4; добавлена таблица 10.3 по петербургской шкале и строка о стоимости переездов.
21	План: пять шагов и восемь действий без денег	Дополнено правилами из зарубежного опыта (мораторий, деньги за человеком, размер группы, мониторинг исходов, запрет спешки), показателями смертности, дееспособности и фиксации.
22	Приложения А–Д	Добавлено приложение Е «Раскрытие: как готовился доклад».

Исправления, сделанные в редакции 4 (для справки)

№	Было в ранних версиях	Стало в редакции 4
1	ПНИ стоит 8–24 тыс. ₽ в месяц, сопровождаемое проживание — 2–6 тыс. ₽, «в четыре раза дешевле»	По первоисточнику ВШЭ это капитальные затраты в пересчёте на месяц; текущие — 44,8 и 52,9 тыс. ₽. Вывод снят.
2	Регион N: экономия 35–38 %; «датская норма снимает дилемму»	Расчёт опирался на неверную базу; передача пенсии человеку не уменьшает полную стоимость. Заменено моделью чувствительности.
3	В ПНИ 160–220 тыс. человек; потенциал 70–100 тыс.	139 тыс. (2024) по «Если быть точным»; более 174 тыс. по Минтруду с учётом отделений; потенциал около 63 тыс.
4	Норма о 75 % — статья 31 закона № 442-ФЗ	Статья 32.
5	Статья 9.1 действует с 2023 или 2024 года	С 1 сентября 2023 года.
6	Цена часа 350–600 ₽ без опоры	Добавлен ориентир — московские тарифы 2026 года, 337–507 ₽.
7	Германия: 63,3 млрд €, 5,6 млн получателей	Расходы 2025 года — 73,8 млрд €; получатели на конец 2023 года — 5,58 млн; доплата за дом престарелых — 3 245 € в месяц.
8	Golden Lane Housing: 21 млн £, 62 объекта, 205 человек	Облигация 2014 года — 11 млн £, 30 домов, более ста человек; всего 83 млн £, 700 домов, 1 320 жильцов.
9	Хогевейк: «меньше лекарств, жители активнее»	Независимых оценок нет (CADTH); утверждение снято.
10	Финляндия — «единственная страна ЕС, где бездомность сокращается»	С 2024 года рост: 3 806 человек, затем 4 579 в 2025-м.
11	Дания: охват 80+ с 43 % до 27 %; Швеция: доступность мест с 20 % до 11 %	Дания по VIVE: с 43 % до 30 % (2019). Швеция: жителей домов престарелых со 118 тыс. до 90 тыс.
12	Нидерланды сократили расходы на стационар на 8 % за год	Не подтверждено; снято.
13	Бразилия: 24,8 % → 79,4 %	Подтверждено другое: 95,5 % → 49 % (1995–2005).
14	Россия: 0,1–0,2 % ВВП на долговременный уход	Заменено прозрачным расчётом только для ПНИ — около 0,04 % ВВП.
15	Челябинская область: проект ВЭБ.РФ и РМК, 16 и 8 человек	Подтверждён проект ВЭБ.РФ с целевым значением 12 получателей; остальное не подтверждено.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Что не удалось подтвердить и что не нашлось

Утверждения, не вошедшие в основной текст

Эти утверждения встречались в прежних версиях или в рабочих материалах, но подтверждения не найдено. Это не значит, что они ложны; это значит, что перед использованием нужен первоисточник.

Тюменская область: дорожная карта 2020–2024 годов, «3D-квартира», рост охвата с 65 до 75 человек. ХМАО: модельная программа сопровождаемого проживания в Излучинском доме-интернате для возраста 18–55 лет (само учреждение — ПНИ на 90 мест — существует). Курганская область: отделение на 14 мест при Галишевском ПНИ. ЯНАО: постановление № 1064-П (2021). Москва: сокращение коечного фонда со 118 до 62 на 100 тысяч. Челябинская область: участие РМК; 16 человек на самостоятельном проживании и 8 в семьях. Свердловская область: пекарня при доме в Верх-Нейвинском. Владимирская область: Арбузовский ПНИ — найдена только старая новость о строительстве корпуса. США: «31 000 $ за год в тюрьме против 10 000 $ в сообществе»; «650 млн $ в Техасе»; калифорнийское дело Coffelt 1990-х годов. Греция: суммы в драхмах и доли довольных жителей после реформы на Лесосе; число пациентов (1 200); обнаруженные BBC привязанные пациенты в больнице Дромокаитио. Дания: ограничение строительства традиционных домов престарелых в конце 1980-х и переход к жилью из отдельных квартир. Номер и дата постановления об исключении заработной платы из расчёта дохода жителей интернатов. Номер и дата приказа Минтруда о новой номенклатуре (июль 2026). Приказ Минтруда 2024 года о посещениях в ПНИ. Чехия: около 15–16 тысяч мест в домах для лиц с инвалидностью в 2007 году. Беларусь: сведения о первоначальном докладе по Конвенции. Эстония: цифры реформы AS Hoolekandeteenused. Молдова: связь пилотного центра психического здоровья в Орхее (2014) с закрытием интерната.

Проверено и не подтвердилось (редакция 6.1)

Три утверждения из поиска 20 октября 2026 года не прошли проверку: большинство из трёх независимых проверяющих ИИ-сессий их опровергли. В текст они не вошли.

- Что по постановлению Правительства № 481 от 24 мая 2014 года часть выпускников может оставаться в ДДИ после 18 лет — например, если у них нет жилья или оно не готово, если им нужно окончить школу, нужно особое питание или специализированный уход (0 из 3 подтвердили; утверждение извлечено со страницы петербургского уполномоченного [211]).
- Что до 2025 года выплата по уходу за ребёнком-инвалидом составляла 10 000 ₽ для родителей, усыновителей и опекунов и 1 200 ₽ для других ухаживающих, например бабушек и дедушек, а с 1 января 2025 года все ухаживающие получают 10 000 ₽ по постановлению Правительства № 1125 от 29.12.2024 (1 из 3). Не подтвердились дата и формулировка; в тексте доклада оставлена подтверждённая версия: с 2025 года, правовая основа — Указ Президента № 1125 от 29.12.2024, текст которого не читали [213, 214].
- Что в схеме приёмных семей Татарстана ежемесячная выплата составляла 4 000 ₽ за человека с III группой инвалидности или пожилого без инвалидности, 6 000 ₽ за II группу и 8 000 ₽ за I группу (постановление 2016 года, действует с 2017 года) (1 из 3; публикация «Бизнес Online» в список источников не включена).

Противоречия, оставленные открытыми

Число жителей ПНИ: 139 тыс. по «Если быть точным» и более 174 тыс. по Минтруду [3, 4]. Число ПНИ: 523 в 2017 году и 536 в 2022 году в разных рядах [3, 4]. Петербург: 5 977 взрослых и 6 270 проживающих в одном докладе [54]. Расчёт дохода жителя: постановление № 1075 и учёт зарплаты по «Парламентской газете» против постановления № 1873 и учёта зарплаты по «Особому праву» [16, 57]. Швеция: около 28 680 и около 36 тысяч жителей жилья по LSS [124, 125]. Болгария: 10 866 жителей по Validity и около 9 000 по национальному плану [92, 93]. Казахстан: 41,6 тыс. и 40 279 проживающих [96, 97]. Канада: даты закрытия Southwestern — 2008 или 2009 год [165]. Австралия: 451,8 тыс. и 434,4 тыс. австралийских долларов на участника SIL в разных файлах [169]. Чехия: годовые и суточные цены ANED, дающие разрыв в 2,8 и в 1,17 раза [79]. Ирландия: иллюстрация в ответе парламенту 2025 года с несходящейся арифметикой [135]. Англия: 2 025 человек в стационарах в 2025 году по пересказу PA и 2 115 в июле 2026 года по NHS England [33, 123]. Охват сопровождаемым проживанием: «около 20 %» по оценке ВШЭ и 1–4 % по расчёту из цифр Минтруда и независимых аналитиков [1, 3, 4]. Год цен в данных ВШЭ: не указан, поэтому калькулятор считает в двух вариантах [1].

Что искали и не нашли

Для России: федеральные данные за 2025–2026 годы о числе ПНИ и домов социального обслуживания, проживающих, очереди, смертности и штатах; аудиты Счётной палаты по ПНИ за 2024–2026 годы; «концепцию ПНИ до 2030 года»; суммы на строительство и реконструкцию ПНИ в 2025–2026 годах; региональные подушевые нормативы и тарифы на стационарное обслуживание и на сопровождаемое проживание; итоги нижегородского пилота 2025 года; приговоры по делам ПНИ № 10 и «Обручевского»; федеральную статистику восстановления дееспособности; постановления Конституционного суда 2024–2026 годов о дееспособности или ПНИ (найдено лишь № 30-П о жилье сирот); новые законопроекты о распределённой опеке; содержание разделов о ПНИ в докладах федерального уполномоченного.

Поиск 20 октября 2026 года (редакция 6.1) по России не закрыл следующие пробелы: ни одно найденное утверждение по ним проверку не прошло. Кадры и экономика ПНИ: зарплаты персонала и социальных работников в 2024–2026 годах, дефицит кадров, нормативы численности, тарифы на стационарное обслуживание по регионам, региональные расходы, проверки Счётной палаты. Имущество и квартиры жителей под опекой интерната, их пенсии и накопления, трудоустройство, участие в выборах. Смертность, пролежни и седация по стране, в том числе от COVID-19 в 2020–2021 годах, данные прокуратуры и Росздравнадзора. «Социальная передышка» и кратковременное пребывание, социальный контракт, приёмные семьи для пожилых и инвалидов — их распространённость, стоимость и охват по регионам. Последствия выхода России из Совета Европы. Число выпускников ДДИ, ежегодно поступающих в

ПНИ, по стране за 2022–2025 годы и изменения после переименования ДДИ в социальные дома. Размер выплаты по уходу после индексации в феврале 2026 года и компенсация 1 200 ₽ при уходе за взрослым инвалидом I группы не с детства или пожилым человеком.

Для Восточной Европы: официальные ряды по Чехии до 2017 года и официальная стоимость клиента; итоги чешского пилотного проекта 2009–2015 годов и количественные оценки качества жизни; стоимость места в малом доме в Грузии и текущее число жителей крупных учреждений; стоимость общинного дома в Молдове и официальная статистика за 2024–2026 годы; актуальные болгарские данные и стандарты стоимости; стоимость содержания в ПНИ Казахстана и Беларуси и официальная численность жителей белорусских интернатов; казахстанские пилоты сопровождаемого проживания взрослых; официальные цифры по Латвии и Эстонии; исследования смертности и качества жизни после переезда для региона, кроме молдавских данных о смертях в учреждениях; данные Всемирного банка и ЮНИСЕФ по взрослой деинституционализации.

Для Западной Европы: официальная таблица Destatis о числе получателей помощи по интеграции; общенациональная средняя цена амбулаторной поддержки в Германии за 2024 год; количественные итоги инспекций CQC 2024–2026 годов; число взрослых с нарушениями интеллекта в интернатах и supported living в Англии; данные Kolada и Социального управления Швеции за 2024–2025 годы; актуальные норвежские данные; свежие отчёты ирландской инспекции HIQA; полная годовая стоимость места в ирландском учреждении и в доме в сообществе; свежие данные о Триесте и итальянских кооперативах; число клиентов с нарушениями интеллекта в нидерландской системе; свежие данные VIVE и финского THL.

Для США, Канады, Австралии: данные CMS за 2024 год; доля услуг на дому только для людей с нарушениями развития; национальные цифры RISP за 2022–2023 финансовые годы и список штатов без учреждений; число мировых соглашений по Olmstead; пересчёт оценки 2014 года о людях с тяжёлыми психическими расстройствами в тюрьмах; стоимость проживания в учреждениях Онтарио до и после закрытия; канадские исследования смертности после переселения; официальная общая сумма расходов на SIL.

Для доказательной базы: полный текст обзора Козмы и сводные величины эффекта; полный текст обзора Маккэррон; работы Chowdhury и Benson (2011) и McConkey; данные о стоимости внедрения Active Support; систематический обзор смертности при деинституционализации и новые когортные исследования; обзор Aubry и соавторов (2020) о постоянном поддерживаемом жилье; данные о Housing First в странах со средним доходом; кокрейновский обзор интенсивного кейс-менеджмента 2017 года и исследования поддержки равных; количественные данные о стоимости и длительности двойного финансирования; экономические оценки из стран со средним доходом; данные о насилии именно в учреждениях; полный текст Атласа ВОЗ 2024 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Источники

Метки доступа означают: «прочитан» — текст источника открыт и прочитан при подготовке редакции 4 (источники 1–53), в исследовательских сессиях редакции 5 (54–207), при подготовке редакции 6 (208) или в исследовании пробелов для редакции 6.1 (209–218); «только аннотация» — прочитана аннотация или страница с описанием, полный текст не открыт; «только поисковая выдача» — сведения взяты из фрагмента поисковой выдачи, страница не открылась или не открывалась; «вторичный пересказ» — сведения взяты из чужого изложения первоисточника. Для источников 1–53 метка «прочитан» опирается на запись редакции 4 о том, что цифры сверены по публикации или первоисточнику; в редакции 5 эти источники заново не открывались, если не указано иное.

Россия: исследования, данные, право (редакция 4)

1. Синявская О. В., Селезнева Е. В., Якушев Е. Л., Горват Е. С. Разработка финансово-экономической модели сопровождаемого проживания граждан с ментальной инвалидностью и её сравнение с ПНИ. Институт социальной политики НИУ ВШЭ, 2022. https://hse.ru/data/2022/02/22/1749114966/01_Sinyavskaya_ISP_Wrokshop_22-02-2022_RU.pdf — прочитан.
2. АСИ, 22.12.2022. Развитие сопровождаемого проживания не только гуманно, но и экономически выгодно. https://asi.org.ru/news/2022/12/22/soprovozhdaemoe-prozhivanie-nenamnogo-dorozhe-prozhivaniya-cheloveka-v-internate-issledovanie/ — вторичный пересказ (изложение исследования ВШЭ).
3. «Если быть точным». Как устроены ПНИ в России. https://tochno.st/materials/kak-ustroeny-pni-v-rossii-issledovanie-esli-byt-tocnym — прочитан.
4. «Ведомости», 10.04.2026. Психоневрологических интернатов за три года стало на 13 % меньше. https://www.vedomosti.ru/society/articles/2026/04/10/1189295-psihonevrologicheskih-internatov-stalo-menshe — прочитан.
5. «Медуза», 14.04.2026, совместно с «Если быть точным». https://meduza.io/feature/2026/04/14/psihonevrologicheskie-internaty-zavedeniya-v-kotoryh-patsienty-regulyarno-podvergayutsya-nasiliyu-ot-nih-izbavlyayutsya-po-vsemu-miru-no-v-rossii-reforma-buksuet-uzhe-10-let — прочитан.
6. Vademecum, 10.04.2026. Программа сопровождаемого проживания охватывает менее 1,8 тысячи человек. https://www.vademec.ru/news/2026/04/10/analitiki-programma-soprovozhdaemogo-prozhivaniya-v-rf-okhvatyvaet-menee-1-8-tysyachi-chelovek/ — прочитан.
7. «Известия», 24.05.2026. Эксперт объяснил выгоду сопровождаемого проживания по сравнению с ПНИ. https://iz.ru/2102182/2026-05-24/ekspert-obiasnil-vygodu-soprovozhdaemogo-prozhivaniia-po-sravneniiu-s-pni — прочитан (диапазон 50–120 тыс. ₽ — пересказ исследований в газете).
8. АСИ, 18.11.2024. Сопровождаемое проживание: опыт регионов и точки роста. https://asi.org.ru/2024/11/18/soprovozhdaemoe-prozhivanie-opyt-regionov-i-tochki-rosta/ — прочитан.
9. АСИ, 21.07.2026. Долговременным уходом охвачено 11 % пожилых и людей с инвалидностью. https://asi.org.ru/news/2026/07/21/v-rossii-dolgovremennym-uhodom-ohvacheno-11-pozhilyh-i-lyudej-s-invalidnostyu-mintrud/ — прочитан.
10. «Ведомости», 20.07.2026. Только 11 % нуждающихся охвачены уходом. https://www.vedomosti.ru/society/articles/2026/07/20/1214844-tolko-11-nuzhdayuschihsya-pozhilih-lyudei-i-invalidov-ohvacheni-uhodom — прочитан.
11. Федеральный закон от 28.04.2023 № 137-ФЗ; статья 3 вступает в силу с 01.09.2023. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_445941/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/ — прочитан.
12. Постановление Правительства РФ от 03.07.2024 № 910. https://normativ.kontur.ru/document?documentId=473989&moduleId=1 — прочитан.
13. Приказ Минтруда России от 25.02.2025 № 85. https://ppt.ru/obzory/vstupaet-v-silu/prikaz-mintruda-rossii-25-02-2025-85 — прочитан.
14. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан», статья 32. https://vladimir.social33.ru/upload/medialibrary/dd4/FZ-442-2019.pdf — прочитан.
15. Vademecum, 14.02.2025. Госдума отклонила законопроект о распределённой опеке. https://vademec.ru/news/2025/02/14/gosduma-spustya-9-let-posle-pervogo-chteniya-otklonila-zakonoproekt-o-raspredelennoy-opeke-nad-posto/ — прочитан.
16. «Парламентская газета». Работающие в интернатах инвалиды смогут сохранить больше доходов. https://www.pnp.ru/social/rabotayushhie-v-internatakh-invalidy-smogut-sokhranit-bolshe-dokhodov.html — прочитан (номер и дата поправки в публикации не указаны).
17. E1.ru, 08.02.2021. В уральском посёлке обустроят дом для людей из интернатов. https://www.e1.ru/text/gorod/2021/02/08/69754799/ — прочитан.
18. Департамент труда и социальной защиты населения Москвы, 30.11.2022. Сопровождаемое проживание. https://www.mos.ru/news/item/116663073/ — прочитан (пресс-релиз).
19. АСИ, 25.09.2026. «Перспективы» предложили стандарт сопровождения выпускников ПНИ. https://asi.org.ru/news/2026/09/25/perspektivy-predlozhili-edinyi-standart-soprovozhdeniya-vypusknikov-pni/ — вторичный пересказ (изложение предложения «Перспектив» в новости АСИ; так источник отнесён в заметках исследования пробелов от 20.10.2026; с редакции 6.1).
20. ВЭБ.РФ. Проект в сфере сопровождаемого проживания, реализуемый в Челябинской области; отчёт о мониторинге. https://veb.ru/agent-pravitelstva/proekty-socialnogo-vozdejstviya/socialnye-proekty/project-05/ — прочитан.
21. ГАООРДИ. В Якутии создадут отделение сопровождаемого проживания. https://vk.ru/@gaoordi-v-yakutii-pri-podderzhke-gaoordi-sozdadut-otdelenie-soprovoz — прочитан.
22. ГБУ «Московская служба помощи». Тарифы на социальные услуги (приказ от 09.02.2026). https://msp.dszn.ru/servises/tarify-na-socialnye-uslugi — прочитан.
23. «Новострой». Топилин: для инвалидов и пожилых больше не будут строить казармы. https://www.novostroy.ru/news/market/maksim-topilin-dlya-invalidov-i-pozhilykh-bolshe-ne-budut-stroit-kazarmy/ — прочитан.

Мир: исследования и данные (редакция 4)

24. Mansell J., Knapp M., Beadle-Brown J., Beecham J. Deinstitutionalisation and community living — outcomes and costs. Tizard Centre, University of Kent, 2007. https://research.kent.ac.uk/tizard/2019/06/11/deinstitutionalisation-and-community-living-outcomes-and-costs/ — прочитан.
25. May P. et al. Effect of deinstitutionalisation for adults with intellectual disabilities on costs: a systematic review. BMJ Open, 2019;9:e025736. doi:10.1136/bmjopen-2018-025736. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6756329 — прочитан.
26. ENIL. EU Funds for Our Rights; брифинг 2018 года и теневой доклад 2025 года. https://enil.eu/eu-funds-for-our-rights-may-update/ — вторичный пересказ.
27. Комитет ООН по правам инвалидов. Guidelines on deinstitutionalization, including in emergencies (CRPD/C/5), 2022. https://digitallibrary.un.org/record/3990185 — прочитан.
28. OECD. Health at a Glance 2023: long-term care spending and unit costs. https://www.oecd.org/en/publications/2023/11/health-at-a-glance-2023_e04f8239/full-report/long-term-care-spending-and-unit-costs_cc989a20.html — прочитан.
29. GKV-Spitzenverband / dpa, 01.03.2026. Pflegeversicherung 2025; NWB о ставке взноса с 2025 года. https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/presse/pressemitteilungen/2026/20260301_dpa_Pflegeversicherung.pdf — прочитан.
30. vdek, 22.01.2026. Eigenanteile in der stationären Pflege. https://www.vdek.com/presse/pressemitteilungen/2026/eigenanteile-pflegeheim-auswertung/_jcr_content/par/download/file.res/vdek_pm_20260122_Eigenanteile_Pflege.pdf — прочитан.
31. Bundesministerium für Gesundheit. Zahlen und Fakten zur Pflegeversicherung (13.02.2025). https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Statistiken/Pflegeversicherung/Zahlen_und_Fakten/Zahlen-Fakten_Pflegeversicherung.pdf — прочитан.
32. DHSC. Adult social care finance report, England: 2024 to 2025. https://www.gov.uk/government/statistics/adult-social-care-finance-report-england-2024-to-2025/adult-social-care-finance-report-england-2024-to-2025 — прочитан.

13. NHS England. Learning disability services statistics, Assuring Transformation, July 2026. https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/learning-disability-services-statistics/at-july-2026-mhsds-june-2026/summary-report---at — прочитан.

14. Mencap, Housing LIN. Funding supported housing for all (2018), в изложении Campbell Tickell для парламента. https://committees.parliament.uk/writtenevidence/43344/html/ — вторичный пересказ.

15. Good Finance. Golden Lane Housing; Learning Disability Today. https://www.goodfinance.org.uk/case-studies/golden-lane-housing — прочитан.

16. CADTH. Dementia Villages: Innovative Residential Care for People with Dementia, 2020. https://www.cadth.ca:443/sites/default/files/pdf/in_brief_dementia_villages_innovative_residential_care_for_people_with_dementia.pdf — прочитан.

17. Hogeweyk: Wikipedia; Quartz «The Dutch village where everyone has dementia». https://en.wikipedia.org/wiki/Hogeweyk; https://qz.com/297706/the-dutch-village-where-everyone-has-dementia — вторичный пересказ.

18. Nippon.com. Expenditures on Nursing Care in Japan Reach ¥11.5 Trillion. https://www.nippon.com/en/japan-data/h02170/ — прочитан.

19. Mental Health Care in Japan: Balancing Care in Hospitals and in the Community (данные MHLW). https://www.mjphm.org.my/health/mental-health/ — прочитан.

20. KEIA. Improving Korea's Long-Term Care for the Elderly; LTCcovid, Republic of Korea. https://keia.org/analysis/improving-koreas-long-term-care-for-the-elderly/ — прочитан.

21. Australian Senate. Report of mental health services observed in Trieste, 2006; Mezzina R., 2012. https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Former_Committees/mentalhealth/report/e03 — прочитан.

22. Social cooperative (Wikipedia, по данным ISTAT); ETF, Social Economy, 2025. https://en.wikipedia.org/wiki/Social_cooperative — вторичный пересказ.

23. Y-Säätiö, 10.02.2025. Homelessness on the rise in Finland; Y-Säätiö и Yle о данных за 2025 год. https://ysaatio.fi/en/homelessness-on-the-rise-in-finland/; https://ysaatio.fi/en/housing-first/homelessness-in-finland/ — прочитан.

24. Homelessness in Finland (Wikipedia); CBC Radio. https://en.wikipedia.org/wiki/Homelessness_in_Finland — вторичный пересказ.

25. Mental Health Commission of Canada. At Home/Chez Soi, Final Report, Executive Summary. https://mentalhealthcommission.ca/wp-content/uploads/2021/09/At2520Home2520Final2520Report2520-2520Exec2520Summary2520-2520ENG_0.pdf — прочитан.

26. VIVE. VIVEs kommunetal 2020.5: Færre hjemmehjælpstimer til ældre. https://www.vive.dk/da/udgivelser/vives-kommunetal-20205-faerre-hjemmehjaelpstimer-til-aeldre-isaer-uden-for-hovedstadsomraadet-15076 — прочитан.

27. Sveriges Radio. Home care focus sparks dramatic cut in elderly home facilities. https://www.sverigesradio.se/artikel/home-care-focus-sparks-dramatic-cut-in-elderly-home-facilities — прочитан.

28. Cadernos de Saúde Pública; Ciência & Saúde Coletiva; Correio Braziliense, 18.01.2026 (по данным Saúde Mental em Dados). https://scielo.br/j/csp/a/LKMxbhKYbPHqP8snJjHwsLQ/?lang=en; https://edicao.correiobraziliense.com.br/correiobraziliense/2026/01/18/140269/pdf/A13-CID-1801-DIG.pdf — прочитан.

29. Treatment Advocacy Center. Serious Mental Illness Prevalence in Jails and Prisons. https://www.tac.org/reports_publications/serious-mental-illness-prevalence-in-jails-and-prisons/ — прочитан.

30. Leigh Day. Winterbourne View timeline since 2011. https://www.leighday.co.uk/media/fe5opksf/ld_winterbourne-view-timeline-since-2011-pdf.pdf — прочитан.

31. Harper's Magazine, 2019. Out of Sight: Leros; Henderson J., Grove B. Leros — Escape into Life, 1999. https://harpers.org/2019/09/out-of-sight-leros-greece-asylum; https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/13666282199900012/full/html — прочитан.

32. SCP. National evaluation of long-term care reforms in the Netherlands, 2018. https://english.scp.nl/documents/2018/06/27/summary-changing-care-and-support-for-people-with-disabilities — прочитан.

33. CBS, 2026. Spending on health care up by 6.1 percent in 2025. https://www.cbs.nl/en-gb/news/2026/26/spending-on-health-care-up-by-6-1-percent-in-2025 — прочитан.

Россия, 2023–2026 (редакция 5)

34. Доклад Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге за 2025 год (PDF от 25.03.2026). https://upchspb.ru/upload/files/upchspb_doklad_2025_25-03-2026.pdf — прочитан (разделы о домах социального обслуживания и ПНИ; подписи одной диаграммы о структуре штата в PDF разъехались).

35. ppt.ru. Приказ Минтруда России от 14.05.2025 № 305н. https://ppt.ru/obzory/vstupaet-v-silu/prikaz-mintruda-rossii-14-05-2025-305n — прочитан.

36. Vademecum, 06.07.2026. Минтруд обновил номенклатуру организаций соцобслуживания. https://www.vademec.ru/news/2026/07/06/mintrud-obnovil-nomenklaturu-organizatsiy-sotsobsluzhivaniya/ — прочитан.

37. «Особое право», 12.2025. Как стационарной организации организовать сопровождаемое проживание без искажения. https://www.osoboepravo.ru/post/2025/12/kak-stacionarnoy-organizacii-organizovat-soprovozhdaemoe-prozhivanie-bez-iskazheniya — прочитан.

38. Гарант. Приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 02.10.2024 № 860. https://base.garant.ru/410984578/ — прочитан.

39. Правительство России. Национальный проект «Семья». http://government.ru/news/54285/ — прочитан.

40. Гарант. Постановление Правительства РФ от 27.12.2024 № 1940 (программа госгарантий на 2025–2027 годы). https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/411138101/ — прочитан.

41. RTVI, 20.04.2023. СК возбудил уголовное дело из-за смерти подопечных ПНИ в Петербурге. https://rtvi.com/news/sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-iz-za-smerti-podopechnyh-pni-v-peterburge/ — прочитан.

42. «Настоящее время», 12.11.2025. В Москве задержали двух санитаров психоневрологического интерната «Обручевский». https://www.currenttime.tv/a/v-moskve-zaderzhali-dvuh-sanitarov-psihonevrologicheskogo-internata-obruchevskiy-veroyatno-prichastnyh-k-amputatsii-kistey-u-patsientki-/33588213.html — прочитан (число проверок с 2015 года — по поисковой выдаче).

43. «Такие дела». Обручевский ПНИ; «Радио Свобода». «Хотели успокоить: связали и забыли». https://takiedela.ru/notes/obruchevskiy-pni/; https://www.svoboda.org/a/hoteli-uspokoitj-svyazali-i-zabyli-/33597348.html — прочитан.

44. Newsvl, 26.06.2025. Дело о присвоении пенсий проживающих ПНИ в Дальнегорске. https://www.newsvl.ru/society/2025/06/26/232422/ — прочитан.

45. ЕАН, 03.07.2026. Экс-сотрудников челябинского интерната осудили за смерть воспитанника. https://eanews.ru/chelyabinsk/20260703110942/eks-sotrudnikov-chelyabinskogo-internata-osudili-za-smert-vospitannika — прочитан.

46. «Версия-Саратов». Первое уголовное дело в отношении руководства Озёрного ПНИ дошло до приговора. https://nversia.ru/news/priznana-vinovnoy-pervoe-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-rukovodstva-skandalno-izvestnogo-psihonevrologicheskogo-internata-doshlo-do-prigovora/ — прочитан (дата не установлена).

47. АСИ, 04.12.2025. Зачем нужны тренинги по восстановлению дееспособности жителей ПНИ; citydisabled.ru, 25.12.2025. Итоги проекта «Новые возможности». https://asi.org.ru/2025/12/04/zhivut-i-zhivut-ni-o-chem-ne-prosyat-zachem-nuzhnytreningi-po-vosstanovoleniyu-deesposobnosti-zhitelej-pni/; https://citydisabled.ru/regions/povyshenie-pravovogo-statusa-i-vosstanovlenie-deesposobnosti-itogi-proekta-novye — прочитан.

48. Милосердие.ru. Жизнь в ПНИ приводит к апатии и беспомощности: исследование. https://www.miloserdie.ru/news/zhizn-v-pni-privodit-k-apatii-i-bespomoshhnosti-issledovanie/ — прочитан.

49. «Регион заботы». Нижегородские ПНИ: выход на сопровождаемое проживание. https://regionzaboty.ru/news/ni1agmp8z1-pri-sodeistvii-proekta-narodnogo-fronta — прочитан (дата не установлена).

50. «Ведомости», 10.03.2026. Уполномоченным по правам человека станет Лантратова. https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2026/03/10/1181854-upolnomochennim-stanet-lantratova — прочитан.

51. Интерфакс. Оценка Минтруда: до 45 % жителей ПНИ могут перейти на сопровождаемое проживание. https://www.interfax.ru/russia/656132 — прочитан.

52. «Российская газета», 04.08.2025. Постановление Конституционного суда № 30-П от 18.07.2025. https://rg.ru/documents/2025/08/04/zhilije-dok.html — прочитан.

53. ngregion.ru. В 2026 году в Обнинске на месте санатория «Здоровье» должны открыть дом-интернат. https://ngregion.ru/gorod-i-gorozhane/v-2026-godu-v-obninske-na-meste-sanatoriya-zdorove-dolzhny-otkryt-dom-internat — прочитан (тип учреждения не проверен).

Восточная Европа и постсоветские страны (редакция 5)

'4. ČSÚ (Чешское статистическое управление). Sociální služby. https://csu.gov.cz/socialni-sluzby — прочитан.

'5. MPSV. Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016–2025. https://mpsv.gov.cz/cms/documents/4ad6d0df-caee-6ca8-c678-e15db4a7ca90/NSRSS.pdf — только поисковая выдача.

'6. MPSV. Akční plán pro deinstitucionalizaci sociálních služeb v ČR 2026–2028. https://mpsv.gov.cz/cms/documents/eb4fb5f2-4191-8a1d-2e18-1e8caa822304/Ak%C4%8Dn%C3%AD%20pl%C3%A1n%20pro%20deinstitucionalizaci%20soci%C3%A1ln%C3%ADch%20slu%C5%BEeb%20v%20%C4%8CR%202026-2028.pdf — прочитан (в том числе пересказы исследования Paleček, Kocman, Valianová 2024 и сравнительного анализа MPSV 2024).

'7. MPSV. DP Transformace sociálních služeb pro osoby s vysokou mírou podpory. https://mpsv.gov.cz/cms/documents/e80f8b11-65cc-3d52-1fa4-c4401b8a7e17/DP-Transformace-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-pro-osoby-s-vysokou-m%C3%ADrou-podpory_final.pdf — только поисковая выдача.

'8. MPSV. Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb (2007). https://mpsv.gov.cz/cms/documents/20acdd0e-4b15-dc71-87d6-b302dc64c86d/Koncepce_podpory.pdf — только поисковая выдача.

'9. ANED. Living independently and being included in the community: Czech Republic (2019). https://www.academia.edu/39069597/Living_independently_and_being_included_in_the_community_Czech_Republic — только поисковая выдача.

'0. Экономическая оценка выписки людей с психозами из чешских психиатрических больниц. Lancet Psychiatry, 2018. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30415938/ — только аннотация.

'1. Council of Europe. Needs assessment on social and economic rights of persons with disabilities in Georgia. https://rm.coe.int/needs-assessment-on-soc-econ-rights-of-pwd-final-eng/488029675b — только поисковая выдача (страница вернула 403).

'2. Народный защитник Грузии. Rights situation of persons with disabilities in state care institutions (2016). https://ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/rights-situation-of-persons-with-disabilities-in-state-care-institutions — прочитан.

'3. Georgia Today; Caritas Czech Republic Georgia, 14.12.2023. Adults with disabilities under state care will now live in family-type homes. https://georgiatoday.ge/adults-with-disabilities-under-state-care-will-now-live-in-family-type-homes/; https://georgia.caritas.cz/news/adults-with-disabilities-under-state-care-will-now-live-in-family-type-homes/ — прочитан.

'4. Georgia Today. «Way to Home»: Caritas Czech Republic supports deinstitutionalization process in Georgia. https://georgiatoday.ge/way-to-home-caritas-czech-republic-supports-deinstitutionalization-process-in-georgia/ — только поисковая выдача.

'5. Народный защитник Грузии, заявление декабря 2022 года; ENO, годовой доклад за 2024 год. https://ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/221203124245sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-shezghuduli-shesadzleblobis-mkone-pirta-saertashoriso-dghestan-dakavshirebit; https://eno.ombudsman.europa.eu/home/news/archives-2025/maincontent/annual-report-on-situation-of-hu.html — прочитан.

'6. Disability Rights International. Left Behind: exclusion of children and adults with disabilities from reform and rights protection. https://www.driadvocacy.org/reports/left-behind-exclusion-children-and-adults-disabilities-reform-and-rights-protection — прочитан.

'7. Keystone Human Services. Position Paper: Deinstitutionalization of Persons with Disabilities in the Republic of Moldova, ноябрь 2020. https://Khs.org/wp-content/uploads/2021/01/Position-Paper-Deinstitutionalization-of-Persons-with-Disabilities-in-the-Republic-of-Moldova-EN.pdf — прочитан.

'8. EASPD. Factsheet: financing of care services, Moldova (данные 2020 года). https://disabilitysupport.eu/fileadmin/user_upload/Publications/EAS_008-21_factsheet_financing_care_services_MD_v2.pdf — прочитан.

'9. Balkan Insight, 06.03.2025. «Inhumane and degrading»: Moldova is still failing the beneficiaries of disability centres. https://balkaninsight.com/2025/03/06/inhumane-and-degrading-moldova-is-still-failing-the-beneficiaries-of-disability-centres/ — прочитан.

'0. Moldpres, 2026. Around 120 people with disabilities in residential care to gain access to community-based living. https://www.moldpres.md/eng/society/around-120-people-with-disabilities-in-residential-care-to-gain-access-to-community-based-living — только поисковая выдача.

'1. Keystone Moldova, проекты; CMHCD (Чехия), Moldova. https://www.keystonemoldova.md/en/projects/institutional-consultancy-on-supporting-transformation-process-of-care/; https://www.cmhcd.cz/centre/current-projects/moldova/ — прочитан.

'2. Validity. Deinstitutionalisation and Life in the Community in Bulgaria, 2021. https://validity.ngo/wp-content/uploads/2021/09/Deinstitutionalisation-and-Life-in-the-Community-in-Bulgaria-FINAL.pdf — прочитан (включая изложение замечаний Комитета ООН CRPD/C/EU/CO/1, п. 51).

'3. European Commission. European Semester country fiche on disability: Bulgaria, 2023. https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=27045&langId=en — только поисковая выдача.

'4. Validity. DIS-CONNECTED national report: Bulgaria, 2024. https://validity.ngo/wp-content/uploads/2024/04/DIS-CONNECTED_NatRep_BG_EN_approved-1.pdf — прочитан.

'5. European Times, 02.2024. Bulgarian psychiatric hospitals, prisons, children's boarding schools and refugee centres. https://europeantimes.news/2024/02/bulgarian-psychiatric-hospitals-prisons-childrens-boarding-schools-and-refugee-centres-misery-and-violated-rights/ — вторичный пересказ.

'6. Бюро национальной статистики РК. Организации по предоставлению специальных социальных услуг в РК (2024); новость на stat.gov.kz. https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/stat-medicine/publications/337000/; https://stat.gov.kz/ru/news/v-kazakhstane-uvelichilos-kolichestvo-organizatsiy-predostavlyayushchikh-spetsialnye-sotsialnye-uslu/ — только поисковая выдача.

'7. DKNews.kz, 27.05.2025. Спецсоцуслуги в Казахстане: кому они нужны и сколько. https://dknews.kz/ru/ekonomika/360786-specsocuslugi-v-kazahstane-komu-oni-nuzhny-i-skolko — прочитан.

'8. Әділет. Социальный кодекс Республики Казахстан; правила услуг индивидуального помощника; стандарты специальных социальных услуг. https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2300000224; https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300032994; https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300032941 — прочитан.

'9. Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. Оказание социальных услуг в домах-интернатах. https://www.mintrud.gov.by/by/okazanie-sotsialnih-uslug-vdomah-internatah-by/ — прочитан (дата страницы неизвестна).

'0. WWB.by. Сопровождаемое проживание: история. https://wwb.by/soprovozhdaemoe-prozhivanie/istoriya/ — прочитан (дата и актуальность неизвестны; в заметках помечен как непроверенный).

'1. AiF.by. Путёвка в дом-интернат: кто и на каких условиях может поселиться. https://aif.by/social/putevka_v_dom_internat_kto_i_na_kakih_usloviyah_mozhet_poselitsya — только поисковая выдача (дата неизвестна).

'2. ESF+. Lithuania's path to community integration of persons with disabilities. https://european-social-fund-plus.ec.europa.eu/en/projects/lithuanias-path-community-integration-persons-disabilities — прочитан.

'3. Social Europe. Disability: EU funding of institutions barely legal. https://www.socialeurope.eu/disability-eu-funding-of-institutions-barely-legal — только поисковая выдача.

'4. Critique of deinstitutionalisation in postsocialist Central and Eastern Europe (ResearchGate). https://www.researchgate.net/publication/337038311_Critique_of_deinstitutionalisation_in_postsocialist_Central_and_Eastern_Europe — только поисковая выдача.

'5. Wikipedia. Disability in Romania (первоисточник — национальная стратегия «România echitabilă» 2022–2027). https://en.wikipedia.org/wiki/Disability_in_Romania; https://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/12/The-National-Strategy-for-the-Rights-of-Persons-with-Disabilities-An-equitable-Romania-2022-2027.pdf — вторичный пересказ.

'6. ESN. Social Services Index 2025: Romania. https://www.esn-eu.org/social-services-index/2025/romania — прочитан.

'7. Nine O'Clock. Sorin Grindeanu: Parliament prevented loss of €5.8 billion in PNRR funds. https://nineoclock.ro/sorin-grindeanu-parliament-prevented-loss-of-e5-8-billion-in-pnrr-funds-and-enabled-access-to-e16-7-billion-safe-financing/ — только поисковая выдача.

'8. ENIL. Statement regarding abuses in institutions for disabled people in Romania. https://enil.eu/statement-of-the-european-network-on-independent-living-regarding-abuses-in-institutions-for-disabled-people-in-romania/ — прочитан.

'9. Knapp M. et al. Health & Social Care in the Community, 2011 (обзор европейского опыта деинституционализации). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2524.2010.00969.x — только аннотация.

'0. European Parliament. State of play of independent living and deinstitutionalisation, 2024. https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/291558/QA-01-24-084-EN-N.pdf — только поисковая выдача (PDF не открылся).

1. China-CEE Institute. Latvia social briefing, 27.05.2022. https://china-cee.eu/2022/05/27/latvia-social-briefing-study-latvian-society-becoming-more-inclusive-towards-intellectually-disabled/ — только поисковая выдача.
2. FRA. Summary overview of types and characteristics of institutional and community-based services, 2017. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2017-10-independent-living-mapping-paper_en.pdf — только поисковая выдача.

Западная Европа (редакция 5)

3. Destatis через Presseportal. Нетто-расходы на Eingliederungshilfe в 2024 году. https://www.presseportal.de/pm/32102/6098431 — прочитан.
4. gegen-hartz.de. Änderungen bei der Eingliederungshilfe (со ссылкой на Destatis). https://www.gegen-hartz.de/news/aenderungen-bei-der-eingliederungshilfe-fuer-schwerbehinderte-was-sich-aendern-soll-und-was-jetzt-schon-gilt — вторичный пересказ.
5. Deutscher Landkreistag. Positionspapier Eingliederungshilfe, 17.09.2025. https://www.landkreistag.de/images/stories/publikationen/250917_PosPap_Eingliederungshilfe.pdf — прочитан.
6. LWV Hessen. Mitteilung M14/2026 (резюме BAGüS Kennzahlenvergleich 2026, отчётный год 2024). https://rim.ekom21.de/lwv-hessen/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZYUKRl6LoYDYL-e4z6AoIdB29y6Z3tROKJXtaxqe5_i5/Mitteilung_M14__-_2026_-_XVII.pdf — прочитан.
7. LAG Freie Wohlfahrtspflege NRW. Fact-Sheet Kostenentwicklung Eingliederungshilfe, 24.04.2026 (включая ссылку на финансовое исследование ISG для BMAS, FB 612). https://www.freiewohlfahrtspflege-nrw.de/fileadmin/user_data/2026/Pressemitteilungen/2026-04-24-LAGFWNRW-Fact-Sheet-KostenentwicklungEGH.pdf — прочитан.
8. DHSC. Measures from the Adult Social Care Outcomes Framework, England 2024 to 2025: statistical commentary. https://www.gov.uk/government/statistics/measures-from-the-adult-social-care-outcomes-framework-england-2024-to-2025/measures-from-ascof-england-2024-to-2025-statistical-commentary — прочитан.
9. Coventry City Council FOI 728312352; Wokingham Borough Council FOI. https://www.coventry.gov.uk/downloads/file/45523/foi728312352; https://www.wokingham.gov.uk/foi/adult-learning-disability-services-1 — вторичный пересказ (атрибуция цифр к советам не проверена).
10. PSSRU. Publication 5203 (стоимость ухода за взрослыми с нарушениями интеллекта и проблемным поведением). https://www.pssru.ac.uk/publications/pub-5203 — только аннотация.
11. Challenging Behaviour Foundation. Government misses target to reduce number of people … in inpatient units by 50 %; NHS Providers briefing. https://www.challengingbehaviour.org.uk/news/government-misses-target-to-reduce-number-of-people-with-a-learning-disability-and-autistic-people-in-inpatient-units-by-50/; https://nhsproviders.org/resources/briefings/briefing-on-house-of-lords-debate-the-nhs-long-term-plan-to-reduce-the-number-of-people-with-learning-disabilities-and-autism-in-inpatient-mental-health-care-by-50-per-cent-by-march-2024 — прочитан.
12. Learning Disability Today. Number of autistic people in inappropriate mental health settings has increased. https://www.learningdisabilitytoday.co.uk/news/number-of-autistic-people-in-inappropriate-mental-health-settings-has-increased/ — вторичный пересказ.
13. Irish News / PA. Too many people with autism still stuck in mental health hospitals. https://www.irishnews.com/news/uk/too-many-people-with-autism-still-stuck-in-mental-health-hospitals-charity-7LN4QL55HBI45LW2VLVCDLHZIA/ — вторичный пересказ.
14. SOU 2021:14 «Boende på (o)lika villkor». https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/boende-pa-olika-villkor-merkostnader-i-bostad_h9b314/html/ — прочитан.
15. Vårdföretagarna, май 2026. Ojämlika rättigheter: var du bor avgör om du får LSS-bostad. https://www.vardforetagarna.se/2026/05/ojamlika-rattigheter-var-du-bor-avgor-om-du-far-lss-bostad/ — вторичный пересказ.
16. Hejaolika. LSS-skolan 06: boende enligt LSS, 2026. https://hejaolika.se/artikel/lss-skolan-06-boende-enligt-lss/ — вторичный пересказ.
17. Solna stad. Utförare: bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. https://www.solna.se/omsorg--stod/for-utforare/information-till-utforare/utforare-bostad-med-sarskild-service-for-vuxna-lss — прочитан.
18. Socialstyrelsen. Öppna jämförelser: enhetsundersökning LSS; методическое описание 2026. https://socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/funktionsnedsattning/enhetsundersokning/ — прочитан.
19. Stortinget. Dokument 8:62 (1998–99). https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/1998-1999/dok8-199899-062/?lvl=0 — прочитан.
20. NAKU. Tøssebro J., Lundeby H. (2006), презентация. https://www.naku.no/sites/default/files/files/pendel.pdf — прочитан.
21. Stortinget. Dokument 8:139 (2010–11). https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-139/ — прочитан.
22. Scandinavian Journal of Disability Research, 2026 (институциональные черты «неинституционального» жилья в Финляндии, Дании и Швеции). https://reference-global.com/article/10.16993/sjdr.1329 — только аннотация.
23. HSE (Ирландия). Time to Move On annual progress report 2019. https://www.hse.ie/eng/services/list/4/disability/congregatedsettings/time-to-move-on-annual-progress-report-2019.pdf — прочитан.
24. HSE. Ответ на парламентский запрос PQ 28606/25, май 2025. https://www.hse.ie/eng/about/personalpq/pq/2025-pq-responses/may-2025/pq-28606-25-david-cullinane.pdf — прочитан.
25. HSE. Ответ на парламентский запрос PQ 46009/25, сентябрь 2025. https://www.hse.ie/eng/about/personalpq/pq/2025-pq-responses/september-2025/pq-46009-25-aidan-farrelly.pdf — только поисковая выдача (страница была временно недоступна).
26. HSE. Ответ на парламентский запрос PQ 29904/22 (со ссылкой на Disability Capacity Review 2018). https://www.hse.ie/eng/about/personalpq/pq/2022-pq-responses/june-2022/pq-29904-22-david-cullinane.pdf — прочитан.
27. HSE. Ответ на парламентский запрос PQ 41740/21. https://www.hse.ie/eng/about/personalpq/pq/2021-pq-responses/september-2021/pq-41740-21-david-cullinane.pdf — только поисковая выдача (в заметках помечен «проверить точный ответ»).
28. HSE. Ответ на парламентский запрос PQ 16963/21. https://www.hse.ie/eng/about/personalpq/pq/2021-pq-responses/march-2021/pq-16963-21-holly-cairns.pdf — прочитан.
29. LaPresse, 15.02.2026; L'Adige. О состоянии психиатрической помощи в Италии. https://www.lapresse.it/salute/sanita/2026/02/15/salute-mentale-in-italia-tra-sottofinanziamento-e-carenze-di-personale/; https://www.ladige.it/attualita/in-italia-posti-letto-per-ricoveri-psichiatrici-tra-i-piu-bassi-al-mondo-lhx5xtuv — вторичный пересказ.
30. Quotidiano Sanità. https://www.quotidianosanita.it/?p=139667 — вторичный пересказ.
31. Università di Trieste. Sintesi e schede regionali Trend 2024. https://moodle2.units.it/pluginfile.php/834379/mod_resource/content/9/Sintesi%20e%20schede%20regionali%20Trend_2024.pdf — прочитан (год данных не установлен).
32. Università di Torino. Материалы DSM Trieste (данные 2013 года). https://elearning.unito.it/scienzeumanistiche/mod/resource/view.php?id=3621 — прочитан (данные устарели).
33. Camera di Commercio Cuneo. Презентация CISEM, 2021. https://www.cn.camcom.gov.it/sites/default/files/uploads/documents/Atti_convegni/atti2021/Slide%20Cisem.pdf — прочитан.
34. Eerste Kamer. Письмо правительства / NZa, май 2026. https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20260518/brief_regering_nza/document3/f=/vmxmt57pc9ze.pdf — прочитан (в заметках помечен «проверить» из-за необычного роста).
35. Eerste Kamer, досье: письмо министра о расходах Wlz на сектор инвалидности, март 2026. https://eerstekamer.nl/9370000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvkfvj6b325az/vmibq0k8qezt — только поисковая выдача.
36. VGN. Onmisbaar Magazine, 2026. https://www.vgn.nl/system/files/2026-04/OnmisbaarMagazine.pdf — вторичный пересказ (по графику).
37. Zorgverzekeraars Nederland. Rapport Wachtlijsten Verpleeghuiszorg Q2 2024. https://www.zn.nl/app/uploads/2024/09/Rapport-Wachtlijsten-Verpleeghuiszorg-Q2-2024-DEF.pdf — прочитан.
38. Konola K. (KVPS). Towards inclusion, презентация, январь 2020. https://deinstitutionalisation.com/wp-content/uploads/2019/12/kirsi-konola_towardsinclusion.pdf — прочитан (не официальная статистика THL).
39. Danmarks Statistik. Услуги для взрослых с инвалидностью и уязвимых, 4 квартал 2023. https://www.dst.dk/nyt/49880 — прочитан.

10. VIVE. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde. https://vive.dk/da/udgivelser/udgifter-brugere-og-enhedsudgifter-paa-det-specialiserede-voksenomraade-10805 — прочитан.

11. København s Kommune. Приложение к заседанию о расходах на botilbud. https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/c6ca6730-0d8c-474f-ad71-1de0e2e2ec55/faa73aac-76f8-4838-9c22-807bab284e66-bilag-23_0.pdf — прочитан.

США, Канада, Австралия (редакция 5)

12. CMS / Mathematica. LTSS Rebalancing Brief 2023. https://www.medicaid.gov/medicaid/long-term-services-supports/downloads/ltss-rebalancing-brief-2023.pdf — прочитан.

13. CMS. LTSS Users & Expenditures by Category Brief 2023. https://www.medicaid.gov/medicaid/long-term-services-supports/downloads/ltss-users-expenditures-category-brief-2023.pdf — только поисковая выдача.

14. RISP / ICI University of Minnesota. How many people with IDD live in large public residential facilities (инфографика). https://publications.ici.umn.edu/risp/infographics/how-many-people-with-intellectual-or-developmental-disabilities-live-in-large-public-residential-facilities — только поисковая выдача (страница вернула 503).

15. RISP. Facility Open and Closed Dates; Data Bytes: Fewer People with IDD Live in ICF/IIDs (2024). https://risp.umn.edu/prf; https://ici.umn.edu/products/x-48MpFWSVKgo2hOafbOVw — только поисковая выдача.

16. KFF Health News, 2022. State institutions closures: families, disabilities, Iowa. https://kffhealthnews.org/news/article/state-institutions-closures-families-disabilities-iowa/ — прочитан.

17. RISP Data Bytes. Medicaid-funded services for people with IDD from institutions to HCBS, 1982–2020. https://publications.ici.umn.edu/risp/data-bytes/medicaid-funded-servic-for-people-with-IDD-from-institutions-to-home-and-community-based-services-between-1982-and-2020 — только поисковая выдача (страница вернула 503).

18. Indiana Institute on Disability and Community. HCBS full brief, July 2026. https://www.iidc.indiana.edu/doc/resources/research/hcbsfullbrief_july2026.pdf — только поисковая выдача.

19. RISP State Profiles: New Jersey, Connecticut, Vermont, Louisiana. https://publications.ici.umn.edu/risp/state-profiles/new-jersey; https://publications.ici.umn.edu/risp/state-profiles/connecticut; https://publications.ici.umn.edu/risp/state-profiles/vermont; https://publications.ici.umn.edu/risp/2018/state-profiles/louisiana — прочитан.

10. ACL. 25th Anniversary of the Olmstead Decision. https://acl.gov/news-and-events/events-and-observances/25th-anniversary-olmstead-decision — прочитан.

11. American Bar Association, July 2025. The Olmstead decision: the federal integration mandate for people with disabilities. https://www.americanbar.org/groups/crsj/resources/human-rights/2025-july/olmstead-decision-federal-integration-mandate-people-disabilities/ — прочитан.

12. Treatment Advocacy Center. Prevention Over Punishment, January 2024 (Executive Summary и Full Report). https://www.treatmentadvocacycenter.org/wp-content/uploads/2024/01/Prevention-Over-Punishment-Executive-Summary.pdf; https://www.treatmentadvocacycenter.org/wp-content/uploads/2024/02/Prevention-Over-Punishment-Full-Report.pdf — прочитан.

13. Bureau of Justice Statistics. Indicators of Mental Health Problems Reported by Prisoners (Survey of Prison Inmates 2016). https://bjs.ojp.gov/library/publications/indicators-mental-health-problems-reported-prisoners-survey-prison-inmates — прочитан.

14. Global News; CBC. $35 million settlement in Huronia lawsuit (2013). https://globalnews.ca/news/844958/35-million-settlement-in-huronia-lawsuit; https://amp.cbc.ca/lite/story/1.1857506 — прочитан.

15. CTV London. Court OKs deal for former residents of Ontario institutions; CTV Ottawa. Premier Wynne apologizes to former residents of Rideau Regional Centre; Freaktography (даты закрытия). https://london.ctvnews.ca/court-oks-deal-for-former-residents-of-ontario-institutions-1.1701377; https://ottawa.ctvnews.ca/premier-wynne-apologizes-to-former-residents-of-rideau-regional-centre-1.1780929; https://freaktography.com/?p=17451 — прочитан.

16. CTV Kitchener; CTV London. Former residents of 12 institutions for disabled win $36M lawsuit. https://kitchener.ctvnews.ca/former-residents-of-12-institutions-for-disabled-win-36m-lawsuit-1.2877521; https://london.ctvnews.ca/ontario-reaches-tentative-settlement-in-developmental-facilities-lawsuit-1.2657209 — прочитан.

17. BC Gov News, 2018; CTV BC; Klein Lawyers. Woodlands. https://news.gov.bc.ca/releases/2018PREM0013-000547; https://bc.ctvnews.ca/b-c-announces-new-compensation-for-woodlands-survivors-1.3866484; https://www.callkleinlawyers.com/class-actions/woodlands/ — прочитан.

18. Mental Health Commission of Canada. At Home/Chez Soi Final Report: Main Messages (2014); Government of Canada, 2014. https://mentalhealthcommission.ca/wp-content/uploads/2021/09/At2520Home2520Final2520Report2520-2520Main2520Messages2520-2520ENG_0.pdf; https://www.canada.ca/en/news/archive/2014/04/minister-bergen-applauds-world-leading-homelessness-study-officially-launches-housing-first-approach-canada.html — прочитан.

19. NDIS. Quarterly report dashboards (12 месяцев до 31.12.2025 и до 30.06.2026). https://www.ndis.gov.au/media/8772/download; https://www.ndis.gov.au/media/8768/download; https://www.ndis.gov.au/media/8782/download — только поисковая выдача.

10. NDIS Data and Research. Средняя выплата по схеме, 2024/25 (неаудированные данные). https://dataresearch.ndis.gov.au/media/4297/download — прочитан.

11. Summer Foundation, декабрь 2025. О стоимости SIL. https://www.summerfoundation.org.au/?p=2766 — прочитан.

12. Department of Health, FOI document pack 2026 (part 2); NDIA, 2019. https://www.health.gov.au/sites/default/files/2026-09/26-3321_document_pack_for_release_part2.pdf; https://ndis.gov.au/media/1189/download — только поисковая выдача.

13. NDIA. Annual Financial Sustainability Report 2022–23. https://dataresearch.ndis.gov.au/media/4148/download — прочитан.

14. Department of Health. Release of the final report of the Independent Review into the NDIS; NDIS Commission, consultation summary, December 2024. https://www.health.gov.au/news/release-of-the-final-report-of-the-independent-review-into-the-ndis; https://ndiscommission.gov.au/sites/default/files/2024-12/Next%20steps%20regulation%20for%20in-home%20and%20housing%20supports%20consultation%20summary.pdf — прочитан.

15. Team DSC. What you need to know: the SIL inquiry. https://teamdsc.com.au/resources/what-you-need-to-know-the-sil-inquiry — вторичный пересказ.

16. Department of Health. Disability Royal Commission Progress Report 2025: recommendations 7.43 и 7.44. https://www.health.gov.au/resources/publications/disability-royal-commission-progress-report-2025/volume-7-inclusive-education-employment-and-housing/recommendation-743-a-roadmap-to-phase-out-group-homes-within-15-years; https://www.health.gov.au/resources/publications/disability-royal-commission-progress-report-2025/volume-7-inclusive-education-employment-and-housing/recommendation-744-a-roadmap-to-phase-out-group-homes-over-a-generational-timeframe — прочитан.

Доказательная база (редакция 5)

17. Kozma A., Mansell J., Beadle-Brown J. Outcomes in different residential settings for people with intellectual disability: a systematic review. AJIDD 2009;114(3):193–222. doi:10.1352/1944-7558-114.3.193 (в OpenAlex первый автор записан как Á. Turnpenny — фамилия Козмы после её смены). https://kar.kent.ac.uk/23753/ — только аннотация.

18. Behaviorist Book Club; Epistemonikos — резюме обзора Kozma et al. (2009). https://behavioristbookclub.com/aba-research/service-delivery/outcomes-in-different-residential-settings-for-people-with-intellectua/; https://www.epistemonikos.org/de/documents/3914f4ebf363b6ba789090f455455879d5fa4fd3 — вторичный пересказ.

19. McCarron M., Lombard-Vance R., Murphy E., May P. et al. Effect of deinstitutionalisation on quality of life for adults with intellectual disabilities: a systematic review. BMJ Open 2019. doi:10.1136/bmjopen-2018-025735. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6502057 — только аннотация (полный текст не открылся).

10. Lakin K. C., Larson S., Kim S. Behavioral Outcomes of Deinstitutionalization for People with Intellectual and/or Developmental Disabilities: Third Decennial Review of U.S. Studies, 1977–2010. Policy Research Brief 21(2), Institute on Community Integration, University of Minnesota, апрель 2011 (аналитическая записка, не журнальная статья). Журнальная версия: Behavioral outcomes of moving from institutional to community living. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities 2012;37(4). https://ici.umn.edu/products/prb/212/default.html — только аннотация.

11. Emerson E. et al. The quality and costs of supported living residences and group homes in the United Kingdom. AJMR 2001;106(5):401–415. https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/13534/ — только аннотация.

12. Emerson E. et al. Конференционная версия исследования supported living и групповых домов, тезисы 2000 года (Lancaster eprints 14381); совпадение выводов со статьёй 2001 года [181] не проверено. https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/14381/ — только аннотация.

13. Emerson E. et al. (2000). Сравнение рассредоточенного жилья, резидентных кампусов и деревенских общин. https://kar.kent.ac.uk/16072/ — только аннотация.

14. NDTi. 200 Lives (Easy Read report); Learning Disability Today. https://www.ndti.org.uk/assets/files/200-Lives-Easy-read-report.pdf; https://www.learningdisabilitytoday.co.uk/?p=32468 — прочитан.

15. Flynn S., Totsika V., Hastings R. P. et al. Effectiveness of active support for adults with intellectual disability in residential settings: systematic review and meta-analysis. JARID 2018;31(6):983–998. doi:10.1111/jar.12491. https://research.birmingham.ac.uk/en/publications/effectiveness-of-active-support-for-adults-with-intellectual-disa/; https://discovery-pp.ucl.ac.uk/10122673/1/Totsika_Flynn_et_al_Systematic_Review_Active_Support_ACCEPTED_23.05.2018.pdf — прочитан.

16. National Elf Service. Systematic review suggests active support does not yet meet criteria for evidence-based practice (о Hamelin, Sturmey 2011, Intellectual and Developmental Disabilities 49(3):166–171). https://www.nationalelfservice.net/publication-types/systematic-review/systematic-review-suggests-active-support-does-not-yet-meet-criteria-for-evidence-based-practice/ — вторичный пересказ.

17. Stancliffe R. J., Jones E., Mansell J., Lowe K. Active support: a critical review and commentary. Journal of Intellectual and Developmental Disability 2008;33(3):196–214. doi:10.1080/13668250802315397. https://experts.umn.edu/en/publications/active-support-a-critical-review-and-commentary/ — только аннотация.

18. Strauss D., Eyman R. K., Grossman H. J. AJPH 1996;86(10):1422–1429. doi:10.2105/AJPH.86.10.1422. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8876512; https://ideas.repec.org/a/aph/ajpbhl/199686101422-1429_9.html — только аннотация.

19. Strauss D., Kastner T. Comparative mortality of people with mental retardation in institutions and the community. American Journal on Mental Retardation 1996;101(1):26–40 (данные 1980–1992). https://einstein.elsevierpure.com/en/publications/comparative-mortality-of-people-with-mental-retardation-in-instit — только аннотация.

10. Strauss D., Shavelle R., Baumeister A., Anderson T. AJMR 1998;102(6):569–581 (резюме в библиотеке Lega del Filo d'Oro); Ragged Edge, январь 1998, о критике исследования. https://biblioteca.legadelfilodoro.it/search/detail/mortality-in-persons-with-developmental-disabilities-after-transfer-into-communi/4206; https://www.raggededgemagazine.com/jan98/calif.htm — вторичный пересказ (резюме усечено).

11. Lerman P., Apgar D. H., Jordan T. Mental Retardation 2003;41(4) (Нью-Джерси, смертность после закрытия учреждения). https://digitalcommons.njit.edu/fac_pubs/14238 — только аннотация.

12. HEU. Literature Review, September 2002 (о переводах в долговременном уходе). https://www.heu.org/sites/default/files/uploads/import/2002/HEU_Literature_Review_Sept23.pdf — только поисковая выдача.

13. National Elf Service. Quality of life measures show improvements for people with complex needs leaving hospital (о работах Bhaumik и соавторов). https://www.nationalelfservice.net/populations-and-settings/quality-of-life/quality-of-life-measures-show-improvements-for-people-with-complex-needs-leaving-hospital/ — вторичный пересказ.

14. Global lessons for deinstitutionalisation from the ill-fated transfer of mental health care users in Gauteng, South Africa. Lancet Psychiatry, 2019 (репозиторий APHRC). https://www.mentalhealthdataprizeafrica.aphrc.org/repository/paper/38507/global-lessons-for-deinstitutionalisation-from-the-ill-fated-transfer-of-mental-health-care-users-in-gauteng-south-africa — только аннотация.

15. Baxter A. J., Tweed E. J., Katikireddi S. V., Thomson H. Effects of Housing First approaches on health and well-being of adults who are homeless or at risk of homelessness: systematic review and meta-analysis of RCTs. JECH 2019;73(5):379–387. doi:10.1136/jech-2018-210981. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6581117/ — прочитан.

16. Munthe-Kaas H. M., Berg R. C., Blaasvær N. Effectiveness of interventions to reduce homelessness. Campbell Systematic Reviews 2018;14(1). doi:10.4073/csr.2018.3. https://ideas.repec.org/a/wly/camsys/v14y2018i1p1-281.html — только аннотация.

17. WHO, 08.10.2021. WHO report highlights global shortfall in investment in mental health (Mental Health Atlas 2020). https://www.who.int/news/item/08-10-2021-who-report-highlights-global-shortfall-in-investment-in-mental-health — прочитан.

18. Public Health Update. The Mental Health Atlas 2020 (резюме). https://publichealthupdate.com/the-mental-health-atlas-2020/ — вторичный пересказ.

19. Rural India Online; IAMHRF — резюме WHO Mental Health Atlas 2024; страница WHO WPRO. https://ruralindiaonline.org/en/library/resource/mental-health-atlas-2024/; https://iamhrf.org/resources/whos-mental-health-atlas-2024/; https://www.who.int/westernpacific/publications/i/item/9789240114487 — вторичный пересказ (PDF ВОЗ вернул 403).

10. WHO. Guidance on community mental health services: promoting person-centred and rights-based approaches, 2021. https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707 — прочитан.

11. BJPsych. Why Trieste matters. https://core-cms.cambridgecore.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/67D5001954A41F24F25EBD90032FFDAA/S0007125021001495a.pdf/why-trieste-matters.pdf — прочитан.

12. WayAhead blog о Триесте. https://wayahead.org.au/?p=36655 — вторичный пересказ.

13. Marshall M., Lockwood A. Assertive community treatment, Cochrane review (версия 2011 отозвана). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21491382/ — только аннотация.

14. Killaspy H., Bebbington P. et al. REACT: randomised evaluation of assertive community treatment in North London. https://discovery-pp.ucl.ac.uk/166247/1/Bebbington_REACT.pdf — прочитан.

15. Lloyd-Evans B., Slade M., Jagielska D., Johnson S. Residential alternatives to acute psychiatric hospital admission: systematic review. BJPsych 2009; Johnson S., Morant N. et al. Implementing alternatives to acute inpatient care. https://www.cambridge.org/core/product/6395628CCAFD19C18BC47776C94F1A22/core-reader; https://discovery-pp.ucl.ac.uk/1349841/1/Johnson_Morant_et_al_Implementing_alternatives_to_acute_inpatient_care.pdf — прочитан.

16. Hughes K., Bellis M. A., Jones L. et al. Prevalence and risk of violence against adults with disabilities: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Lancet 2012;379:1621–1629. doi:10.1016/S0140-6736(11)61851-5. https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/prevalence-and-risk-of-violence-against-adults-with-disabilities-/; https://orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/51915/ — только аннотация.

17. Conroy J., Bradley V. Pennhurst Longitudinal Study, 1985 (архив Миннесотского совета по нарушениям развития); BSLS, обзор книги Downey, Conroy (2020). https://www.mn.gov/mnddc/parallels2/pdf/80s/85/85-TPL-DHS.pdf; https://www.bsls.ac.uk/2020/07/dennis-b-downey-and-james-w-conroy-pennhurst-and-the-struggle-for-disability-rights/ — прочитан.

Добавлено в редакции 6

18. Банк России. Инфляция и ключевая ставка Банка России: годовая инфляция по ИПЦ в декабре 2020–2025 годов (4,90; 8,39; 11,94; 7,42; 9,52; 5,59 %). https://cbr.ru/hd_base/infl/ — прочитан (19.10.2026).

Добавлено в редакции 6.1

Метки перенесены из рабочих заметок исследования пробелов от 20.10.2026. Сессия-редактор эти страницы заново не открывала.

19. АСИ, 28.02.2018. Маленькие взрослые (о переводе выпускников ДДИ в ПНИ). https://asi.org.ru/2018/02/28/malenkie-vzroslye/ — вторичный пересказ (доля в треть и 150 тыс. «по данным Минтруда» даны без ссылки на первоисточник).

.0. «Петербургский дневник», 20.12.2018. В Петербурге изменят систему перевода из детских домов-интернатов в психоневрологические интернаты. https://spbdnevnik.ru/news/2018-12-20/v-peterburge-izmenyat-sistemu-perevoda-iz-detskih-domovinternatov-v-psihonevrologicheskie-internaty — вторичный пересказ (устное заявление председателя комитета по социальной политике А. Ржаненкова).

.1. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге, 09.08.2023. Реформа ПНИ должна учитывать положительный опыт ДДИ. https://upchspb.ru/news/reforma-pni-dolzhna-uchityvat-polozhitelnyy-opyt-ddi/ — прочитан.

.2. Департамент труда и социальной защиты населения Москвы, 26.07.2021 (mos.ru). https://www.mos.ru/news/item/93788073/ — прочитан (пресс-релиз; 19 квартир — анонс, передача не подтверждена).

.3. Социальный фонд России, Отделение по Вологодской области, 07.04.2025. Новость о выплате по уходу за ребёнком-инвалидом и инвалидом с детства I группы. https://sfr.gov.ru/branches/vologda/news~2025/04/07/272173 — прочитан.

.4. «Т—Ж». Новость о выплатах по уходу за детьми-инвалидами в 2025 году. https://t-j.ru/news/money-for-disabled-kids-2025/ — вторичный пересказ (10 950 ₽ с 1.02.2025; цифру, по заметкам, подтверждают и другие СМИ).

.5. «Парламентская газета», 22.12.2020. Минтруд: возможность приёмных семей для пожилых появится во всех регионах. https://www.pnp.ru/social/mintrud-vozmozhnost-priyomnykh-semey-dlya-pozhilykh-poyavitsya-vo-vsekh-regionakh.html — вторичный пересказ (там же по заметкам — позиция сенатора Е. Бибиковой по публикации pnp.ru от 26.05.2020, адрес которой в заметках не указан).

6. «Медуза», 18.05.2020, со ссылкой на ТАСС и комитет по социальной политике Петербурга. В психоневрологическом интернате в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией заболели почти 500 человек. https://meduza.io/news/2020/05/18/v-psihonevrologicheskom-internate-v-sankt-peterburge-koronavirusnoy-infektsiey-zaboleli-pochti-500-chelovek — вторичный пересказ.
7. Комитет ООН по правам инвалидов. Заключительные замечания по докладу Российской Федерации, CRPD/C/RUS/CO/1, 2018 (копия на ecoi.net). https://www.ecoi.net/en/file/local/1439226/1930_1532593850_g1809688.pdf — прочитан.
8. Отделение ООН в Женеве. Committee on the Rights of Persons with Disabilities examines the report of Russia, 27–28.02.2018 (пресс-резюме заседания; исходная страница отдаёт 404, текст взят из дословной перепубликации InsuranceNewsNet от 01.03.2018). https://ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2018/02/committee-rights-persons-disabilities-examines-report-russia; https://insurancenewsnet.com/oarticle/committee-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-examines-the-report-of-russia — вторичный пересказ.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Как повторить расчёты

Исходники доклада лежат в папке `report/src` репозитория `qlolp/seminar-mental-health-cost-2026`. Файл `calc.py` содержит формулы и допущения части 6 в одном месте: команда `python3 calc.py` печатает данные таблиц 6.1–6.3 и 6.5 в обоих вариантах цен, а цену часа (`HOUR_PRICE`), стоимость жилья и быта (`LIVING_FIXED`) и год цен данных ВШЭ (`PNI_PRICE_YEAR`, `SP_PRICE_YEAR`) можно поменять в начале файла. Файл `figures.py` строит графики четвёртой редакции из тех же чисел, `content.html` — текст четвёртой редакции, `build.py` собирает из него PDF и веб-версию. Пятая и шестая редакции подготовлены как отдельный Markdown-документ. В редакции 6 в `calc.py` добавлены индексация цен по ИПЦ Банка России [208] (функция `price_index`) и печать результатов в ценах 2025 года; разделяемое сопровождение и предельную стоимость места калькулятор пока не учитывает.

Часть расчётов не входит в `calc.py`. Их можно воспроизвести следующим фрагментом, запущенным из папки `report/src`:

```
from calc import flat_cost, WEEKS_PER_MONTH, price_index, GDP_2024

# Таблица 6.4: петербургская шкала (часов в неделю) [54] и московские тарифы [22]
for degree, hours in (("I", 14), ("II", 28), ("III", 42)):
    support = [round(hours * WEEKS_PER_MONTH * p / 1000, 1) for p in (337, 507)]
    full = [round(flat_cost(hours, p, f), 1) for p, f in ((350, 22), (475, 30), (600, 38))]
    print(degree, hours, "сопровождение:", support, "полная стоимость:", full)

# Часть 4: отношения «учреждение / сообщество»
pairs = {
    "Россия, ВШЭ": (44.8, 52.9),
    "Германия, NRW 2023": (57160, 12561),
    "Германия, Гессен 2024": (52066, 15209),
    "США, RISP 2020": (145306, 49723),
    "США, Индиана 2021": (93649, 25042),
    "Молдова 2020 (мин.)": (4767, 2800),
    "Молдова 2020 (макс.)": (4854, 2650),
    "Чехия, ANED, год": (400000, 144000),
    "Чехия, ANED, сутки": (491, 420),
}
for k, (inst, comm) in pairs.items():
    print(k, round(inst / comm, 2))

# Капитальные затраты (часть 2) и доля ВВП (часть 4)
print("ПНИ с капзатратами:", round(44.8 + 8, 1), round(44.8 + 24, 1), "СП:", round(52.9 + 2, 1), round(52.9 + 6, 1))
pni_total = 139_000 * 44.8 * 12 / 1e6  # млрд ₽
print("Доля ВВП 2024, %: в ценах 2019 –", round(pni_total / GDP_2024 * 100, 3), "; в ценах 2024 –", round(pni_total * price_index(201
print("Охват, % (1,8 и 8 тыс. из 216 тыс.):", round(1.8 / 216 * 100, 1), round(8 / 216 * 100, 1))

# Прочие оценки составителя
print("Германия, взрослые в особых формах:", round(495_700 * (1 - 0.615)))
print("Молдова, € на жителя в 2023:", 13e6 / 2000)
print("Ирландия, лет до завершения при 30 и 20 переездах в год:", round(1300 / 30), round(1300 / 20))
print("Петербург, доля районной системы, %:", round(38 / 5977 * 100, 1))
print("Литва, снижение госпитализаций, %:", round((1 - 11 / 29) * 100))
print("Болгария, мест на центр:", 3060 / 68)
print("Недееспособных по стране, тыс.:", round(0.74 * 139, 1))

# Редакция 6.1: Петербург, умершие после перевода из ДДИ [210]; выплата по уходу с районным коэффициентом [213, 214]
print("Петербург, 45 из 685, %:", round(45 / 685 * 100, 2))
print("Вологда и область (×1,15):", round(10950 * 1.15, 2), "; Череповец (×1,25):", round(10950 * 1.25, 2))
```

Отношения в части 4 округлены до одного знака после запятой; молдавский диапазон 1,7–1,8 получен из крайних сочетаний цены учреждения (4 767–4 854 €) и ассистенции (2 650–2 800 €).

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Раскрытие: как готовился доклад

Этот доклад исследован и написан искусственным интеллектом. Его готовили несколько сессий Claude Code — программного агента компании Anthropic: исследовательские сессии искали источники, сессия-составитель писала текст, отдельные сессии проверяли его. Несколько исследовательских сессий в октябре 2026 года искали сведения в интернете по пяти направлениям (Россия 2024–2026, Восточная Европа и постсоветские страны, Западная Европа, США, Канада и Австралия, доказательная база) и записали рабочие заметки со ссылками на источники и пометками о том, что проверено, а что нет. Сессия-составитель свела эти заметки с текстом четвёртой редакции и калькулятором. Метки доступа в приложении Г перенесены из рабочих заметок, а для источников 1–53 — из записи четвёртой редакции о сверке.

Использованные инструменты. Claude Code — исследовательские сессии, написание текста и проверка. Плагин Research Desk: citation-check, research-litnote, paper-compare, paper-critique, related-work, decision-matrix и llm-council, а также поиск DOI в OpenAlex (reference-lookup). С их помощью подготовлены проверка ссылок, литературная заметка по презентации ВШЭ, внутренняя рецензия редакции 5, черновик обзора литературы для части 3 и совет трёх сессий одной модели о центральном тезисе и рекомендации. Плагин Research integrity — правила разметки утверждений: метки доступа к источникам, знак †, пометка «оценка составителя».

Шестая редакция подготовлена сессией-редактором по внутренней рецензии, выводам совета, черновику обзора литературы, литературной заметке по презентации ВШЭ и пересчёту `calc.py` с индексацией цен. Индекс потребительских цен Банка России прочитан на сайте cbr.ru 19.10.2026 [208]. Сессия-редактор первоисточники, кроме этого, заново не открывала: сверка шла по рабочим заметкам и материалам проверки.

Часть источников при подготовке оказалась недоступна или была прочитана не полностью. Сайт проекта RISP Миннесотского университета возвращал ошибку 503; страница Совета Европы о Грузии и PDF Атласа психического здоровья ВОЗ 2024 года — ошибку 403; полные тексты ряда статей на PMC закрывала капча (в частности, обзор Маккэррон и соавторов); не открылся PDF Европейского парламента 2024 года; ответ ирландской службы здравоохранения на запрос PQ 46009/25 был временно недоступен; не открывались национальная стратегия Чехии 2016–2025 годов и статья 2025 года о чешской трансформации в Journal of Human Rights and Social Work; не прочитаны второй том DECLOC, доклад EEG 2020 года, обзоры FRA и брифинг ENIL о европейских фондах, таблицы Destatis GENESIS, данные Kolada, сборник ФНОЦ им. Альбрехта о региональных практиках. Значения индекса качества жизни ВШЭ в тексте презентации отсутствуют и известны только по пересказу. Сайты Минтруда, Счётной палаты и региональных министерств в поисковую выдачу почти не попадали. Всё, что известно только по поисковой выдаче, аннотации или пересказу, должно быть помечено в тексте знаком †; проверки находили и добавляли пропущенные пометки, но полноты разметки это не гарантирует.

Текст не проходил рецензирования людьми. Внутренняя рецензия, совет трёх сессий и проверки, выполненные внутри проекта той же моделью ИИ, не являются внешним рецензированием и не заменяют его; согласие сессий одной модели весит меньше, чем согласие независимых экспертов. Перед тем как использовать цифры доклада в официальных документах, публичных выступлениях или бюджетных обоснованиях, их следует сверить по первоисточникам, начиная с помеченных знаком †, и показать текст специалистам — экономистам социальной сферы, юристам и людям с опытом жизни в интернате. В первую очередь стоит спросить авторов ВШЭ, в ценах какого года даны 44,8 и 52,9 тыс. ₽ и что входит в «расходы ФЛ».

Оценки составителя в тексте — арифметика, выполненная по цифрам из источников; каждая сопровождается формулой и воспроизводится по приложению Д. Выводы о том, что «не найдено» или «не удалось найти», означают лишь, что этого не нашли исследовательские сессии в ограниченном числе поисковых запросов, а не что таких данных не существует.

Редакция 6.1. Дополнения взяты из одного исследования пробелов доклада, выполненного 20 октября 2026 года инструментом глубокого поиска (deep-research) на основе ИИ. Поиск шёл по пяти направлениям; пятое — кадры и экономика ПНИ — не дало ни одного проверенного факта. Открыто 20 источников, из них извлечено 81 утверждение. 25 утверждений проверены тремя независимыми ИИ-сессиями-проверяющими; утверждение отбрасывалось, если его опровергали двое из трёх. Подтверждено 22, опровергнуто 3 (приложение В). Остальные 56 утверждений не проверялись и в доклад не вошли; почему их не проверили и сколько источников остались без проверки, в рабочих заметках не записано. Это не человеческая проверка: проверяющие — ИИ-сессии, и их согласие не заменяет сверки по первоисточнику. Сессия-редактор перенесла в текст только подтверждённые факты с оговорками из рабочих заметок и сами страницы заново не открывала.

Проверка. Текст редакции 5 прочитан отдельной ИИ-сессией в этом проекте, которой было поручено искать утверждения, выходящие за пределы источников; найденное исправлено в редакции 6. Изменения редакции 6 прочитаны ещё одной отдельной ИИ-сессией в этом проекте; найденное исправлено на месте, перечень находок — в файле проекта `lit/review-2026-10-19.md`. Это не внешняя и не человеческая рецензия. Ссылки на научные статьи проверены по DOI через OpenAlex и веб-поиском; соответствие формулировок тексту статей проверено не везде.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Страны подробно

Это приложение содержит страновые главы редакции 5 с небольшими правками. Сводная таблица и выводы — в части 4.

Ж.1. Западная Европа, Азия и Бразилия: дорогие системы и их незакрытые счета

Чужой опыт полезен не как образец для копирования, а как зеркало. В каждой из историй ниже есть то, что работает, то, что не доказано, и то, что можно взять в российский регион уже сейчас. Западноевропейские системы богаче российской в разы, и поэтому особенно поучительно, что ни одна из них не решила задачу до конца: Германия держит в «особых формах проживания» почти двести тысяч взрослых, Ирландия за первые семь месяцев 2025 года переселила из учреждений около двух десятков человек, а Англия не смогла вдвое сократить число людей с нарушениями интеллекта в психиатрических стационарах.

Германия: помощь по интеграции растёт за счёт жизни в своём жилье

В Германии за людей с инвалидностью платят две разные системы. Первая — обязательное страхование долговременного ухода (Pflegeversicherung), действующее с 1995 года. С 1 января 2025 года взнос составляет 3,6 % облагаемого дохода, для бездетных — 4,2 % [29]. На конец 2023 года социальная страховка ухода выплачивала пособия 5,58 млн человек, из них 4,39 млн получали помощь на дому и 0,84 млн — в стационаре; ещё 0,34 млн застрахованы в частной системе [31]. В 2025 году расходы выросли на 8,2 % и достигли 73,8 млрд €, тогда как взносы принесли 72,5 млрд €; дефицита удалось избежать лишь благодаря федеральному займу в 500 млн €. На 2026 год ожидаются расходы около 79 млрд € при поступлениях 75,3 млрд €, и без нового займа в 3,2 млрд € дефицит составил бы 4,4 млрд € [29]. Страховка покрывает уход, но не жильё и питание: собственная доплата жителя дома престарелых в первый год пребывания на 1 января 2026 года составила в среднем 3 245 € в месяц — на 261 € (9 %) больше, чем годом раньше [30].

Вторая система, куда важнее для темы доклада, — помощь по интеграции (Eingliederungshilfe) по девятой книге Социального кодекса. С 2020 года, после вступления в силу закона об участии (Bundesteilhabegesetz, BTHG), она учитывается отдельной статистикой. Нетто-расходы на неё в 2024 году составили 28,7 млрд €, на 12,9 % больше, чем годом раньше [113]. Получателей, включая детей, по вторичному пересказу данных Destatis, около 1,029 млн† [114]. Немецкий союз районов (Landkreistag) подсчитал, что с 2018 по 2023 год расходы выросли на 40 % [115].

Самое интересное — куда идёт этот рост. По сравнительному отчёту объединения региональных носителей помощи BAGüS за 2024 год, в конце года по стране около 495,7 тысячи совершеннолетних получали услуги ассистенции в проживании и социальном участии, на 5,1 % больше, чем годом раньше. Рост почти целиком пришёлся на людей вне «особых форм проживания» (besondere Wohnformen, так после BTHG называются бывшие стационары): там +8,9 %, а число людей в особых формах слегка снизилось, на 0,5 %. Доля «амбулантизации» — людей, получающих помощь в собственном жилье, — выросла до 61,5 %, а амбулаторные расходы за год — на 22,6 % [116]. Значит, в особых формах по-прежнему живут около 190 тысяч взрослых (оценка составителя: 495,7 тыс. × (1 − 0,615)).

Теперь цены. Средняя по стране стоимость случая в особой форме проживания в 2023 году составила 48 420 € в год при доле амбулантизации 59,4 % [117]. В Гессене в 2024 году на одного получателя в особой форме тратили 52 066 € в год (+11,8 % за год), вне особых форм — 15 209 € (+15,3 %); в особых формах там жили 12 363 человека, вне их — 28 328 (амбулантизация 69,8 %); ещё 17 293 человека работали в мастерских для людей с инвалидностью, по 22 230 € в год на человека [116]. В Северном Рейне — Вестфалии стоимость случая в особой форме выросла с 40 246 € в 2013 году до 57 160 € в 2023-м, в собственном жилье — с 9 865 до 12 561 €. Число людей в особых формах там снизилось с 45 546 до 41 405 (−9,1 %), вне их — выросло с 54 364 до 87 628 (+61,2 %); около 70 % получателей вне особых форм — люди с психическими нарушениями, а доля людей старше 60 лет в особых формах выросла с 23,1 % в 2018 году до 29,2 % в 2023-м [117]. По оценке финансового исследования для федерального министерства труда, прямые дополнительные расходы, вызванные самим законом BTHG, меньше 2 % нетто-расходов; около двух третей расходов приходится на социальное участие, около пятой части — на участие в трудовой жизни [117].

Получается, что место в особой форме обходится носителю помощи в 3,4–4,6 раза дороже амбулаторной поддержки (оценка составителя: 52 066 ÷ 15 209 ≈ 3,4 в Гессене; 57 160 ÷ 12 561 ≈ 4,6 в Северном Рейне — Вестфалии). Но это сравнение нельзя читать «один к одному», и сами немецкие источники дают для этого два основания. После разделения услуг в 2020 году в стоимость особых форм больше не входят жильё и прожиточный минимум — их оплачивают другие системы, так что полная стоимость места выше [117]. А у людей в собственном жилье жильё и содержание тоже оплачиваются отдельно — из базового обеспечения и жилищной субсидии; к тому же в особых формах всё больше пожилых, и, по-видимому, там сосредоточены люди с более высокими потребностями. Подробнее об этом — в части 4.

Что взять России. Не саму страховку, а три её принципа: уход — отдельный риск, который виден в бюджете и считается; пакет помощи определяется уровнем потребности, а не диагнозом; семья, которая ухаживает сама, получает за это деньги, а не только обязанности. И четвёртый, из помощи по интеграции: отдельно считать деньги на сопровождение и деньги на жильё и содержание. Только так можно увидеть, что на самом деле стоит поддержка.

Англия: дома, а не в учреждениях, — но стационары не опустели

В 2024/25 году Англия потратила на социальное обслуживание взрослых 34,5 млрд £, на 7,9 % больше, чем годом раньше. Из 29,4 млрд £ валовых текущих расходов местных властей 23,6 млрд £ (80 %) пришлось на долговременную поддержку. Неделя в доме ухода в среднем по всем взрослым стоила 1 185,55 £, на 7 % дороже, чем годом ранее [32]. На поддержку взрослых 18–64 лет с нарушениями интеллектуального развития (learning disability) местные власти потратили 7 724 млн £ — 26 % всех расходов на взрослую социальную

помощь. Средняя недельная стоимость интерната (residential care) для этой группы составила 1 629 £, ухода с сестринским персоналом (nursing) — 2 058 £ [32]. В годовом исчислении это около 85 тыс. £ и 107 тыс. £ (оценка составителя: 1 629 × 52 и 2 058 × 52). Отдельной строки с недельной ценой supported living в этой статистике нет, и число клиентов она не собирает [32].

Зато другая официальная статистика показывает, где живут люди. По системе показателей результатов социальной помощи (ASCOF) за 2024/25 год, 81,4 % взрослых 18–64 лет с нарушениями интеллекта, получающих долговременную поддержку, живут в собственном доме или с семьёй [118]. Ответы отдельных советов на запросы о свободе информации называют для интерната цену 1 918–2 212 £ в неделю, но к какому совету относится какая цифра, точно не проверено, и выборка не репрезентативна† [119]. Издание PSSRU оценивало «стандартный» уход для взрослых с нарушениями интеллекта и проблемным поведением в 81 478–94 799 £ в год на человека в ценах более ранних лет† [120].

Исследование Mencap и Housing LIN 2018 года, в изложении для парламента, сравнило цены для людей с нарушениями интеллекта: специализированное сопровождаемое жильё обходилось государству в 1 569 £ в неделю на человека, место в доме ухода — в 1 760 £, место в стационаре — в 3 500 £† [34]. Благотворительная жилищная компания Golden Lane Housing, связанная с Mencap, в 2014 году за восемь дней привлекла 11 млн £ первой благотворительной облигацией на Лондонской бирже и купила на эти деньги 30 домов более чем для ста человек; всего компания вложила свыше 83 млн £ в 700 домов для 1 320 жильцов [35].

Тёмная сторона английской системы — люди, застрявшие в психиатрических стационарах. Программа Building the Right Support ставила целью к марту 2024 года сократить их число вдвое относительно марта 2015 года. В марте 2015 года таких пациентов с нарушениями интеллекта и (или) аутизмом было 2 905, в конце марта 2024 года — 2 045, то есть снижение составило около 30 % вместо 50 %; правительство заявило, что не планирует обновлять план действий [121]. Новые плановые указания NHS на 2025/26 год ставят куда более скромную цель — минимум на 10 % меньше пациентов, около двухсот выписок к марту 2026 года† [122]. По официальной статистике NHS England, на конец июля 2026 года в стационарах оставались 2 115 человек, почти половина из них — дольше двух лет, а 315 человек — дольше десяти [33]. По пересказу агентства PA, в 2025 году называлась цифра около 2 025 человек, а число аутичных пациентов без нарушений интеллекта выросло† [123]; дата отсчёта в этом пересказе не проверена, а более поздняя официальная цифра 2026 года выше.

Что взять России. Отдельно считать расходы на сопровождаемое проживание и на учебные квартиры: то, что не выделено в отдельную строку, невозможно ни защитить, ни нарастить. И мерить успех не числом открытых квартир, а долей людей, живущих в собственном доме или с семьёй, — показателем, который англичане публикуют ежегодно.

Ирландия: двадцать переездов в год

Ирландская программа «Время двигаться дальше от конгрегированных учреждений» (Time to Move On from Congregated Settings) — пример реформы, которая идёт десятилетиями. К концу 2019 года в отслеживаемых «конгрегированных» учреждениях — больших, где вместе живёт много людей с инвалидностью, — оставались 1 953 человека [133], в конце декабря 2023 года — 1 415 [134], в сентябре 2025 года, по данным, полученным через поиск, — «чуть меньше 1 300»† [135]. Темп 2025 года — около двадцати переездов за семь месяцев: к маю состоялось 10 переездов при годовой цели 21 [134], к концу июля — 20† [135]. В 2019–2023 годах число оставшихся сокращалось быстрее, на 538 человек за четыре года (оценка составителя: 1 953 − 1 415), но какая часть этого снижения пришлась на переезды, а какая на смерти, в рабочих материалах не разобрано. Сама служба здравоохранения признаёт, что численность различается в зависимости от источника и что часть учреждений не попала в исходный отчёт 2011 года [138].

Ирландские цифры ценны прежде всего тем, что показывают стоимость самого переезда. Национальное управление по делам инвалидности (NDA) оценивает дополнительные затраты примерно в 80 тыс. € на каждого переселённого† [135]. Обзор потенциала служб 2018 года называл среднюю стоимость переезда 140 200 € на человека; некоторые переезды почти нейтральны для бюджета, потому что персонал и деньги переходят вместе с жителями, но удельная стоимость растёт по мере того, как в учреждениях остаются люди с наибольшими потребностями [136]. В ответе парламенту 2025 года для оставшихся 1 300 человек приводится иллюстрация: 325 домов на четверых, около 1 млн € капитальных затрат на дом и около 2 млн € текущих; арифметика этого ответа внутренне не сходится, и пользоваться ею не стоит† [135]. В 2016 году государство вложило 62 млн € в приведение объектов в соответствие с требованиями инспекции HIQA†, а открыть новый дом можно только после такой проверки [135, 137].

При темпе от 20 переездов в год (годовая цель 2025 года — 21) до 30 на вывод оставшихся 1 300 человек понадобится от 43 до 65 лет (оценка составителя: 1 300 ÷ 30 и 1 300 ÷ 20).

Что взять России. Закладывать в план стоимость каждого переезда отдельной строкой. И помнить, что последние переезды, по ирландскому обзору 2018 года, дороже первых [136]: если первая волна шла почти без дополнительных денег, это не значит, что так пойдёт и дальше.

Нидерланды: деревня Хогевейк и очень дорогая система

Хогевейк в Веспе, неподалёку от Амстердама, открылся в 2009 году как «деревня» для людей с тяжёлой деменцией: около 150 жителей в 23 домах по шесть–восемь человек, площадь, магазин, кафе. Жителей подбирают в дома по укладу жизни, а не по диагнозу [37]. Стоимость в разных источниках разнится: по одним данным, она сопоставима с обычным домом престарелых, около 5 000 € в месяц; по другим, приближается к 8 000 $, из которых семья платит в зависимости от дохода† [37].

Самое важное здесь — то, чего мы не знаем. Канадское агентство по оценке медицинских технологий CADTH не нашло опубликованных оценок самого Хогевейка и указало, что объективных доказательств улучшения клинических исходов, качества жизни или эффективности затрат недостаточно, а воспроизведение модели потребует дополнительных капитальных вложений [36].

Сама страна тем временем продолжает перестраивать систему. Реформа 2015 года передала значительную часть внестационарной помощи муниципалитетам и сместила акцент с учреждений на помощь дома [52]; в 2025 году расходы по закону о долговременном уходе (Wlz) выросли на 7,6 % [53]. По письму правительства в Первую палату парламента, законные расходы исполнителей этого закона в 2024 году составили 35,9 млрд € против 29,8 млрд € годом раньше; рост на пятую часть за год необычно велик и может отражать изменения охвата† [144]. На сектор инвалидности в 2026 году, по письму министра, запланировано около 15,3 млрд €, из них 2,6 млрд € — персональные бюджеты† [145]. По оценке отраслевого объединения VGN, на помощь людям с нарушениями интеллекта приходится около 96 % расходов этого сектора† [146]. Для сравнения, на 1 июля 2024 года показания к сестринскому уходу по этому закону имели 197 287 человек, в основном пожилых [147]. Число клиентов с нарушениями интеллекта и средняя стоимость на одного клиента в рабочих материалах не найдены.

Что взять России. То, что не требует строительства: подбирать соседей по укладу жизни, держать группы малыми, снять с немедицинского персонала белые халаты, вернуть людям магазин, кухню и двор.

Италия: больниц нет, долгие резиденции есть

Закон 180, или закон Базальи (1978), прекратил госпитализацию в старые психиатрические больницы. Триест стал витриной реформы. Описания системы 2006–2012 годов совпадают: на город с населением около 240 тысяч человек работают четыре центра психического здоровья, открытые круглые сутки; каждый обслуживает около 60 тысяч жителей и располагает шестью–восемью кроватями для кратковременного пребывания; в больнице общего профиля есть всего шесть психиатрических коек, в основном для ночных экстренных случаев; штат — около одного сотрудника на тысячу жителей [41]. В 1971 году в психиатрической больнице Триеста было около 1 200 коек [41]. По материалам триестского департамента психического здоровья за 2013 год, около двухсот человек в год проходили стажировки в социальных кооперативах и фирмах, и примерно 10 % из них трудоустраивались; деньги на человека выделялись по методу «бюджета здоровья» [142]. Свежих количественных данных о Триесте за 2020-е годы найти не удалось; о политических переменах в местной службе здравоохранения после 2020 года пишет пресса, но без цифр.

Частью итальянской модели стали социальные кооперативы типа B по закону 381 1991 года, в которых не менее 30 % работников — люди из уязвимых групп, включая людей с психическими и интеллектуальными нарушениями; они стабильно составляют около трети всех социальных кооперативов [143]. По переписи 2011 года таких кооперативов было около 4 500; материалы Европейского фонда образования 2025 года называют около 5 300† [42].

Но у итальянской истории есть и менее известная сторона. Больниц нет, а резиденции есть: по сводке триестского университета, в резидентных психиатрических структурах за год находились 29 258 человек, а средняя длительность пребывания составляла 1 236,9 дня — больше трёх лет; к какому году относятся эти цифры, точно не установлено† [141]. Число резидентных структур, по пересказу отраслевой прессы, за 2017–2023 годы сократилось на 13 %, а территориальных служб — на 18,5 %† [140]. По отчёту Минздрава за 2023 год в пересказе прессы, помощь специализированных служб получали 854 040 человек, на 9,9 % больше, чем годом раньше, а укомплектованность кадрами на 30 % ниже стандартов† [139]. Похоже, что закрытие больниц без достаточного финансирования территориальных служб выталкивает людей в долгое пребывание в малых резиденциях.

Что взять России. Круглосуточный районный центр, где в кризис можно провести несколько ночей, снимает главный страх, который удерживает людей в интернатах: «а что, если обострение». И работа в кооперативе, а не занятость в мастерской за забором. Но и предостережение: малая резиденция, где люди живут годами, — это тоже учреждение.

Скандинавия: полное закрытие и его оборотная сторона

Норвегия — страна, где закрытие учреждений для людей с нарушениями интеллекта было доведено до конца. Реформа HVPU стартовала 1 января 1991 года и завершилась к концу 1995-го; ответственность передали муниципалитетам, а цель состояла в переселении жителей учреждений в собственное жильё. На момент старта около 5 500 человек получали круглосуточные услуги этой системы. В оценке, на которую ссылались в Стортинге, «примерно семерым из десяти стало лучше» [129]. Исследование Тёссебро и Лунебю (Tøssebro, Lundeby) 2006 года показало, что услуги получает больше людей, семьи перешли от сопротивления реформе к её поддержке, а жилищные условия «явно лучше» [130]. Критики же говорят, что реформа «на практике стала жилищной реформой», что многие живут в одиночестве, а крупные совместные дома (bofellesskap) грозят реинституционализацией; в сессии 2010–2011 годов в Стортинг вносилось предложение пересмотреть её итоги [131]. Актуальных данных о числе людей в таких домах и о стоимости услуг рабочие материалы не дали.

Швеция. По закону о поддержке и услугах (LSS) взрослые с нарушениями интеллекта и аутизмом живут в «жилье со специальным обслуживанием», в основном в групповых домах (gruppbostad) и сервисном жилье. По официальному государственному докладу 2021 года, в таком жилье жили около 28 680 человек [124]; по пересказу отраслевого объединения со ссылкой на Социальное управление, в 2024 году — около 36 тысяч† [125]. Расхождение может объясняться разными годами и определениями. Средняя стоимость места, по вторичному источнику, — около 1 млн шведских крон в год, и эта услуга составляет около 40 % всех расходов по LSS† [126]. Тарифы муниципалитета Сольна поставщикам дают более надёжный ориентир: от 1 462 до 5 846 крон в сутки в зависимости от потребностей и включения дневной деятельности, то есть примерно 0,53–2,1 млн крон в год [127]. Социальное управление ежегодно обследует такие дома и дневную деятельность (в 2020–2021 годах обследование не проводилось) [128]. В домах престарелых Швеции число жителей сократилось примерно со 118 тысяч в 2001 году до 90 тысяч, хотя число людей старше 65 лет за то же время выросло на 16 %; шведские исследователи отмечают, что люди попадают туда позже и в более тяжёлом состоянии [47].

Финляндия почти завершила закрытие учреждений для людей с нарушениями интеллекта: по презентации родительской организации KVPS 2020 года, в учреждениях жили 4 216 человек в 2010 году и 531 к концу 2018-го; национальная программа деинституционализации основана на решении правительства 2012 года [148]. Это не официальная статистика национального института THL, и свежих данных найти не удалось. Финская же программа Housing First дала бездомному постоянное жильё без

предварительных условий. С 2008 по 2022 год долговременная бездомность в стране сократилась на 68 % [43]. Экономию для общества финские оценки называют на уровне не менее 15 000 € в год на человека — за счёт скорой помощи, полиции и правосудия† [44]. Но и эта история не закончена. В отчёте, опубликованном в феврале 2025 года, насчитали 3 806 бездомных — на 377 больше, чем годом раньше; это был первый рост после одиннадцати лет снижения. В ноябре 2025 года их было уже около 4 579, на 20 % больше, из них 1 306 — долговременно бездомные [43]. Города объясняют разворот ростом стоимости жизни, сокращением социальных выплат и вдвое урезанным бюджетом жилищного консультирования [43].

Дания. В четвёртом квартале 2023 года 84 900 человек получали хотя бы одну социальную услугу для взрослых с инвалидностью и уязвимых, на 13 % больше, чем пятью годами раньше [149]. Место в специализированном жилье (botilbud) в 2018 году стоило в среднем около 650 тыс. датских крон в год, от 500 до 770 тыс. по муниципалитетам региона Зеландия [150]; к 2021 году общие расходы на такие места выросли на 9 %, главным образом из-за цен частных поставщиков [151]. Есть у датской модели и оборотная сторона: по данным исследовательского центра VIVE, доля людей старше 80 лет, получающих помощь на дому, снизилась с 43 % в 2008 году до 30 % в 2019-м, а доля среди всех старше 65 лет — с 18 % до 11 % [46].

Что взять России. Права жильца, а не «проживающего». И предостережение: шведские исследователи отмечают, что в дома престарелых люди попадают позже и в более тяжёлом состоянии [47]. Даже лучшая модель откатывается, когда урезают её обеспечение, — финские цифры бездомности 2024–2025 годов тому пример.

Япония и Корея: страхование ухода и скорость перемен

Япония ввела страхование долговременного ухода в 2000 году. В 2023 финансовом году общие расходы на уход и профилактику для пожилых достигли 11,5 трлн иен, в 2,6 раза больше, чем в 2001 году [38]. Параллельно страна медленно сокращала длительность психиатрической госпитализации: с примерно 500 дней в 1990 году до около 266 дней в 2018-м, хотя коек на 100 тысяч жителей там по-прежнему около 267 при среднем по ОЭСР около 66 [39].

Корея ввела страхование ухода в 2008 году и быстро нарастила систему: расходы по страховке росли в среднем на 15,2 % в год в 2009–2018 годах, доля охваченных людей старше 65 лет поднялась с 3,9 % до 8,4 %, а суммарные расходы на долговременный уход к 2019 году достигли примерно 1,0–1,1 % ВВП [40].

Что взять России. Из Японии — фигуру кейс-менеджера, который собирает для человека пакет услуг из разных ведомств, и оценку потребности вместо оценки по диагнозу. Из Кореи — понимание, что национальную систему можно построить за десятилетие, если решение принято.

Бразилия: деньги вслед за человеком

Закон 10.216 (2001) запустил в Бразилии закрытие психиатрических больниц и развитие общинных центров психосоциальной помощи (CAPS). Число психиатрических коек с 1995 по 2005 год сократилось на 41 %, с 5,4 до 3,2 на 10 тысяч жителей; доля госпитализаций в расходах на психическое здоровье упала с 95,5 % до 49 %, а с 2006 года внебольничные расходы превышают больничные [48]. В 2024 году в стране работало в среднем 1,13 центра CAPS на 100 тысяч жителей [48]. У бразильской истории есть и неудобная деталь: за 1995–2005 годы расходы на психическое здоровье на душу населения снизились с 2,66 до 1,95 доллара [48]. Реформа шла на скудные деньги и до сих пор неравномерна по регионам.

Что взять России. Структура бюджета может измениться без увеличения общей суммы. Это ориентир, а не обещание.

Ж.2. Восточная Европа и постсоветские страны: когда деньги идут на здания, а не на людей

Для российского читателя эта часть, пожалуй, важнее западноевропейской. Страны Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР унаследовали ту же модель, что и Россия: большие закрытые учреждения на окраинах, опека учреждения над жителем, финансирование «на койку». Многие из них начали реформу на несколько лет, а то и на десятилетие раньше и получили на неё деньги, о которых российские регионы могут только мечтать: фонды Европейского союза, чешскую помощь развитию, гранты международных доноров. Тем поучительнее, что почти везде реформа застряла на одном и том же месте. Большие учреждения сменились малыми, а жизнь в сообществе так и не стала нормой.

Чехия: миллиарды крон и минус восемь процентов

Чехия занимается трансформацией социальных услуг с 2007 года. Цепочка документов выглядит образцово: концепция поддержки трансформации стационарных социальных услуг 2007 года, национальная стратегия развития социальных услуг на 2016–2025 годы, план действий по переходу к услугам в сообществе на 2023–2025 годы (правительство утвердило его только в октябре 2023 года) и, наконец, план действий по деинституционализации на 2026–2028 годы [76]. По пересказу национальной стратегии в поисковой выдаче, к февралю 2015 года трансформация сократила вместимость домов для лиц с инвалидностью на 789 мест и увеличила вместимость защищённого проживания на 329, а из 639 зарегистрированных стационарных услуг для людей с инвалидностью 544 имели «институциональный характер»† [75]. Деньги на это доступны с 2006 года из европейских операционных программ, а в 2021–2027 годах ключевыми стали два вызова интегрированной региональной программы IROP «Деинституционализация социальных услуг», открытые до 2027 года; края заранее отобрали 46 учреждений для трансформации [76].

Результат статистика показывает без прикрас. По данным Чешского статистического управления, число клиентов домов для лиц с инвалидностью (DOZP) за 2017–2024 годы снизилось с 11 815 до 10 852 — на 8 %; коек стало меньше, с 12 231 до 11 295, а число самих учреждений даже выросло, с 204 до 217. Одновременно число клиентов «домов с особым режимом» (DZR), которые принимают в том числе людей с психическими расстройствами и деменцией, выросло с 17 856 до 25 517, на 43 %, а число таких учреждений — с 322 до 416.

Защищённое проживание (chráněné bydlení) за то же время выросло с 3 766 до 4 287 клиентов [74]. Рост домов с особым режимом с лихвой перекрывает снижение в домах для лиц с инвалидностью; часть этого роста, вероятно, связана со старением и деменцией, а не с ментальной инвалидностью, но разбивки в статистике нет.

Чешское министерство труда и социальных дел само признаёт это в плане на 2026–2028 годы: «не происходит систематического ограничения услуг институционального характера… в эти услуги поступают новые клиенты». Края использовали средства неравномерно, а преимущественного финансирования услуг в сообществе нет [76]. Исследование Палечека, Коцмана и Валиановой 2024 года с говорящим названием «Всё ещё в начале» в пересказе министерства отмечает, что с 2007 года вместимость домов для лиц с инвалидностью снизилась, но общее число жителей стационаров, особенно крупных, «снижается лишь слегка»; трансформация идёт на уровне отдельных учреждений без пересмотра краевых сетей, а полевые службы не способны заменить стационар для людей с высокой потребностью в поддержке [76]. Анализ министерства 2025 года добавляет: системного видения нет, финансирование «сложное и непрозрачное», данные раздроблены, нет единых идентификаторов клиентов и единиц жилья, качество жизни клиентов систематически не измеряется [76].

Особенно показательно, что именно создаётся на европейские деньги. Общая сумма вызовов — 3,84 млрд крон. На 30 июня 2025 года утверждено 29 трансформационных планов из 40 запланированных, полностью трансформируются пока 12 учреждений; освоение задерживают картирование, покупка участков и разрешения на строительство. Из создаваемых мест 83 % финансирует IROP, 5 % — национальный план восстановления, 10 % — собственные средства. А по типам 60 % новых мест (640) — это всё те же дома для лиц с инвалидностью, только меньше; 22 % (236) — защищённое проживание; 10 % (101) — дома с особым режимом; персональной ассистенции не создаётся вовсе. Больше половины проектов — новостройки, почти треть — реконструкция существующих зданий. В проекте участвуют 11 из 14 краёв [76]. Методический стандарт министерства допускает до 12 клиентов в одном здании при низком уровне поддержки и до 18 при высоком† [77]; ранняя концепция разрешала вкладываться только в «гуманизированные» учреждения вместимостью до 40 человек† [78]. Цель на 2030 год — 80 % мест «характера сообщества» среди всех стационарных мест для людей с инвалидностью; закрепить критерии таких услуг в законе собирались «не позднее 2025 года» [76].

О стоимости чешские данные скудны. По докладу Европейской академической сети экспертов по инвалидности (ANED) 2019 года, средняя годовая стоимость институциональной помощи — около 400 тыс. крон на человека, поддержки проживания в сообществе — около 144 тыс. крон, а суточная стоимость — 420 крон для защищённого проживания и 491 крона для институционального ухода† [79]. Эти цифры взяты из поисковой выдачи, методику их расчёта увидеть не удалось, и две пары плохо согласуются между собой: годовые суммы дают разрыв почти втрое, суточные — меньше чем на пятую часть (оценка составителя: 400 ÷ 144 ≈ 2,8; 491 ÷ 420 ≈ 1,17). Официальную стоимость содержания одного клиента найти не удалось. Отдельно стоит упомянуть экономическую оценку в Lancet Psychiatry 2018 года: выписка людей с психозами из чешских психиатрических больниц в сообщество оказалась экономически эффективной — качество жизни у выписанных было немного ниже, но годовые затраты на стационарную группу непропорционально выше† [80].

Министерство в 2024 году сравнило трансформацию в Эстонии, Хорватии, Ирландии и Швеции и пришло к выводам, которые стоит выписать: в крупных учреждениях Европы живут около 1,5 млн человек, и их число «существенно не меняется»; даже в Швеции есть риск реинституционализации через новые групповые «кластеры»; нужны стабильное финансирование не только инфраструктуры, но и текущих расходов, прозрачный мониторинг с публичными данными и прямые выплаты на персональную ассистенцию по шведскому образцу [76].

Грузия: дома семейного типа на пять–шесть человек

Деинституционализация взрослых в Грузии идёт с 2010–2011 годов и в абсолютных числах невелика. В 2016 году Народный защитник насчитал 64 жителя в Дзеври и 69 в Мартқопи [82]. По оценке Совета Европы, в 2023 году в трёх крупных учреждениях для взрослых с инвалидностью — Мартқопи, Дзеври и Душети — жили 142 человека, а реформа упиралась в неготовность местных сообществ и сопротивление открытию альтернативных службб† [81]. Стратегия и план действий на 2023–2030 годы разработаны в 2020 году и утверждены министерством в 2023-м [83].

Основная модель — «малые дома семейного типа». В декабре 2023 года Caritas Czech Republic купила, отремонтировала и передала Государственному агентству по уходу шесть домов на пять–шесть человек каждый; туда переселяют часть жителей Душети и Мартқопи. Деньги дало Чешское агентство развития, стоимость не раскрывается. Даже в сообщении об открытии звучит предупреждение: если число жителей и персонала будет расти, дома воспроизведут институциональные условия [83]. По другим публикациям, 18 человек переведены из Мартқопи в три малых дома в Душети, а чешский грант предусматривает ещё семь домов† [84].

Оценки реформы суровы. Народный защитник в декабре 2022 года назвал ситуацию в специализированных учреждениях для взрослых «тяжёлой», а деинституционализацию — «фрагментарной, без надлежащего плана»; в годовом докладе за 2024 год — проблемой, которая «годами остаётся нерешённой» [85]. Организация Disability Rights International в докладе «Оставленные позади» отмечает, что Мартқопи был отремонтирован как крупное сегрегированное учреждение: реформа закрыла детские дома для детей без инвалидности, но оставила позади детей и взрослых с инвалидностью [86]. Данных о стоимости места в малом доме и в крупном учреждении, о смертности и о возвратах в рабочих материалах нет.

Грузинская модель по сути похожа на российские «малые дома» и тренировочные квартиры: капитальные затраты оплачивает донор, текущие берёт на себя государственное агентство. Это возможный образец для пилотов, но с той же ловушкой — маленькое учреждение остаётся учреждением.

Молдова: программа, которая работает на учреждения

Молдавская история задокументирована подробнее других в этой части и, пожалуй, горше других. В 2008 году в шести учреждениях жили около 2 500 человек с интеллектуальными и психосоциальными нарушениями. За двенадцать лет, к 2020 году, деинституционализированы лишь 450 человек, около 2 000 оставались в учреждениях, а поскольку моратория на приём нет, их число, по оценке Keystone Human Services, «продолжает расти» [87]. Национальная программа деинституционализации на 2018–2026 годы, утверждённая постановлением правительства № 893/2018, ставила цель вывести половину жителей к 2026 году и превратить учреждения в региональные ресурсные центры [87, 88].

К 2025 году, по расследованию Balkan Insight, в пяти центрах Агентства по управлению высокоспециализированными социальными услугами жили почти 2 000 человек, из них около 300 — в Бэдичень. За семь лет программы в 29 услуг в сообществе переселено около 10 % жителей. Закрыто одно учреждение — в 2024 году, путём слияния с другим центром. Бэдичень должны были закрыть ещё в 2020 году. Обещанная группа по реализации так и не создана, а в 2023 году правительство решило пересмотреть программу и продлить её до конца 2028 года; новая версия на момент публикации не утверждена. Госсекретарь объяснил медлительность тем, что быстрая деинституционализация «слишком дорога» [89].

Исходы за 2018–2023 годы приведены в том же расследовании: в центрах умерли 308 жителей, «социально интегрированы» 133 человека, реинституционализирован 131, из них девять — повторно и многократно; официально трудоустроены 2,5 % жителей (2023) [89]. Те ли это люди, расследование не уточняет, а у числа смертей нет ни знаменателя, ни базы для сравнения. Если интеграции и возвраты относятся к одним и тем же людям, почти равное их число говорит о том, что в сообществе людей ждали дома, но не ждала достаточная поддержка. Там же перечислены случаи насилия: медсестра в Бэдичень осуждена в 2023 году за пытки (условно), психиатр в Бэлць получил 15 лет за изнасилование 16 жительниц в 2004–2013 годах, Европейский суд по правам человека в 2025 году признал нарушение запретов принудительного труда и пыток в отношении бывшего жителя Бэдичень; специальный докладчик ООН требовал немедленного закрытия учреждений ещё в 2015 году [89].

Молдова интересна и тем, что о ней есть сопоставимые цены. По данным Европейской ассоциации поставщиков услуг для людей с инвалидностью (EASPD) за 2020 год, долговременный уход в кишинёвском Центре размещения для пожилых и людей с инвалидностью стоил 274,01 лея в день (13,06 €), около 4 767 € в год; муниципальные закупки в Кишинёве — около 4 854 € в год. Нормы на одного жителя предусматривали 886 € в год на питание, 147 € на медикаменты и 55 € на одежду [88]. Персональная ассистенция обходилась примерно в 2 650 € в год на получателя, в Кишинёве около 2 700 € (2020) и 2 800 € по плану 2021 года; мобильная бригада — около 1 020 € в год на человека. Число ставок персональных ассистентов выросло с 3 590 до 6 058 в 2020 году [88]. Но в этой цене есть важная оговорка: зарплата ассистента около 150 € в месяц, и ассистентами чаще всего работают родственники [88]. Методику расчёта стоимости всех услуг правительство не утвердило, финансирование ложится на местные бюджеты и фонд «минимального пакета», а трансферты колеблются из года в год [88]; по наблюдению Keystone, в одних районах бюджет этого пакета не покрывает потребностей, а в других не осваивается и возвращается в центр [87].

Цены на услугу «общинного дома» на два–шесть жителей с социальным работником [89] найти не удалось. Зато известно, что на содержание резидентной системы в 2023 году выделено около 13 млн €, а бюджеты центров с начала реформы почти удвоились [89]. В расчёте на около 2 000 жителей это примерно 6 500 € в год на человека (оценка составителя: 13 млн € ÷ 2 000). Учреждения, таким образом, получили от реформы больше денег, чем имели до неё.

В 2026 году правительство, по сообщению государственного агентства, объявило о координационном механизме, консолидированном национальном плане и 12 региональных планах; около 120 человек из резидентных учреждений должны получить доступ к жизни в сообществе† [90]. Трансформацию учреждений в Бэдичень, Брынзень, Кочиерь и Бэлць финансировало чешское правительство, исполнителями были Keystone и People in Need, для выходцев купили несколько домов [91].

Болгария: шестьдесят восемь новых «центров резидентного типа»

По данным организации Validity за 2021 год, в Болгарии работают 161 крупное учреждение для взрослых с 10 866 жителями, и лишь 10 из них закрыты для новых поступлений; очередь в учреждения в 2017 году составляла 3 600 человек, в групповые дома — почти 900 [92]. Национальный план долгосрочного ухода, по пересказу европейского документа 2023 года, называет около 9 000 человек в 161 специализированном учреждении и ещё 2 300 в очереди† [93]; расхождение с цифрой Validity может объясняться датой и охватом.

Рамка реформы взрослых — национальная стратегия долгосрочного ухода 2014 года и план действий на 2018–2021 годы; завершение деинституционализации взрослых и пожилых запланировано к 2034 году [92]. Проект поддержки деинституционализации предусматривал закрытие десяти учреждений, затрагивающее 515 человек с интеллектуальными и 363 с психосоциальными нарушениями; приём в них остановлен 9 марта 2018 года. На это выделено 41,37 млн левов (около 21,1 млн €), 85 % из Европейского фонда регионального развития [92]. Параллельно на 50,8 млн € по оси «Региональная социальная инфраструктура» строятся 68 новых «центров резидентного типа» на 3 060 человек — в среднем 45 мест на центр (оценка составителя: 3 060 ÷ 68) — и дневные центры. Предварительно отобраны лишь 54 из 265 общин, заявки подали 26, карты услуг не опубликованы, потребности не изучались [92]. Регулирование допускает до 15 человек в групповом доме [92].

Оценки правозащитников однозначны. Validity называет групповые дома «новыми типами институций» с той же культурой, расписанием и видеонаблюдением и отмечает, что Болгария продолжает вкладывать в эту модель значительные национальные и европейские средства [92]. В 2024 году та же организация констатировала, что помещение взрослых в резидентные учреждения «остаётся частью политики деинституционализации», а новые услуги — «по-прежнему институции, хотя и меньше прежних» [94]. Болгарский омбудсман в феврале 2024 года, в пересказе издания European Times, отмечал, что закрыто лишь девять домов для людей с нарушениями интеллекта, психическими расстройствами и деменцией, а семь учреждений имеют больше ста мест, одно — 228 жителей† [95]. Европейский суд по правам человека ещё в 2012 году в деле «Станев против Болгарии» признал нарушения нескольких статей Конвенции из-за помещения человека в социальное учреждение [92].

Литва, Латвия, Эстония и Румыния: европейские деньги и малые институции

Литовский проект Европейского социального фонда «От ухода к возможностям» (2020–2023) охватил 36 самоуправлений при бюджете 17,11 млн €, из них 10,05 млн € — вклад ЕС. В нём участвовали 1 793 человека; 50 из них вышли на открытый рынок труда, а частота госпитализаций людей с психическими нарушениями снизилась с 29 до 11 случаев на тысячу получателей услуг [102]. Это один из немногих в регионе примеров с измеренным исходом — снижение примерно на 62 % (оценка составителя: 1 − 11 ÷ 29), — хотя и не контролируемое исследование. Вместе с тем, по пересказу позиции ENIL, литовское правительство планировало вывести 2 700–3 000 человек из крупных учреждений, но только в групповые дома и другие малые учреждения, используя 26,5 млн € европейских фондов† [103].

Латвийские муниципалитеты в рамках деинституционализации создают групповые квартиры, групповые дома и дневные центры† [111]. В Эстонии, по обзору Агентства ЕС по основным правам 2017 года, упоминаются программы «деревень ухода» 2007–2013 годов, около 550 мест к 2013 году; отнесение этой цифры именно к Эстонии не подтверждено† [112]. Цифр по эстонской реорганизации крупных учреждений в малые единицы найти не удалось.

В Румынии в июне 2023 года в резидентных учреждениях жили около 16 тысяч взрослых (база 2020 года — 16 911); национальная стратегия ставит цель сократить их число до 11 500 к концу июня 2026 года и до 10 349 к концу 2030 года† [105]. На конец 2024 года в стране работали 746 социальных услуг для взрослых с инвалидностью, из них 668 резидентных [106]. Закон о деинституционализации в рамках национального плана восстановления вводит пособие на переходное жильё для взрослых, покидающих резидентный уход; сумма около 770 млн € названа в политическом заявлении и не проверена† [107]. ENIL после скандалов с насилием в румынских учреждениях напомнила, что малые групповые дома, защищённое жильё и дома семейного типа — «всё ещё институции» [108].

Казахстан и Беларусь: та же модель без реформы

Казахстан и Беларусь — ближайшие к России страны по правовой модели, и сравнивать с ними полезно скорее для ориентира, чем как с образцом.

В Казахстане, по пересказу данных Бюро национальной статистики, в 2024 году работали 46 психоневрологических медико-социальных учреждений для взрослых, в которых жили 11,7 тысячи человек, на 1,9 % меньше, чем годом раньше; детских таких учреждений — 19† [96]. Всего организаций специальных социальных услуг в 2024 году было 304, из них 180 стационарного типа, а проживающих в них на конец года — 41,6 тысячи [97]; у статистического бюро встречается и цифра 40 279, и расхождение не объяснено. Из проживающих с инвалидностью 20 314 человек, или 78 %, имеют психические расстройства и расстройства поведения† [96]. Социальный кодекс, вступивший в силу 1 июля 2023 года, ввёл услуги индивидуального помощника для людей с инвалидностью первой группы [98], но системной программы деинституционализации психоневрологических учреждений и данных о пилотах сопровождаемого проживания взрослых найти не удалось. На 100 тысяч населения в казахстанских психоневрологических учреждениях живёт около 58 человек, в российских ПНИ — около 95 (оценка составителя: 11,7 тыс. ÷ 20 млн и 139 тыс. ÷ 146 млн; численность населения взята округлённо из рабочих заметок, где российская цифра помечена как непроверенная†; типы учреждений в двух странах различаются, так что сравнение грубое).

По Беларуси свежих цифр о числе жителей психоневрологических домов-интернатов в открытых источниках нет. На странице министерства труда, дата которой неизвестна, говорится о сети из 92 домов-интернатов, включая 9 для детей с особенностями психофизического развития [99]. Сопровождаемое проживание развивалось в основном в детских интернатах; в домах-интернатах для взрослых, в том числе психоневрологического профиля, созданы «отделения сопровождаемого проживания»† [100]. По публикации без даты, очередь в такие интернаты составляла 287 человек† [101]. Отделение сопровождаемого проживания внутри интерната — это не деинституционализация, а тренировочный модуль, и в российской реформе тот же риск.

Что переносимо в Россию

Восточноевропейский опыт сводится к нескольким выводам, которые прямо касаются российского региона. Первый — **запрет на новые поступления.** На его отсутствие прямо указывают чешское министерство («в эти услуги поступают новые клиенты») [76] и Keystone в Молдове (моратория нет, и число жителей растёт) [87]; там, где приём остановили, как в десяти болгарских учреждениях с марта 2018 года [92], закрытие хотя бы становится возможным. Для России это мог бы быть, например, запрет на приём в ПНИ молодых людей и выпускников детских домов-интернатов — при условии, что для них есть куда идти.

Второй — **деньги за человеком, а не за зданием.** В Чехии и Болгарии капитальные гранты без перевода текущего финансирования сопровождались созданием малых учреждений: Болгария строит 68 центров по 45 мест, в Чехии 60 % новых мест — малые дома для лиц с инвалидностью, а больше половины проектов — новостройки. Российские федеральные деньги на «малые дома» рискуют повторить этот сценарий.

Третий — **жёсткие стандарты размера.** Чешский порог в 12–18 человек на здание† [77], по оценке составителя, слишком высок, грузинские 5–6 и молдавские 2–6 человек ближе к норме. Закреплять такие стандарты лучше в нормативном акте: Чехия собиралась сделать это до 2025 года и не сделала [76].

Четвёртый — **мониторинг исходов, а не мест.** Смертность, возвраты в учреждение, качество жизни, единые идентификаторы клиентов — всё это стоит заложить в российские пилоты с первого дня. Молдавская пара «133 интеграции и 131 возврат» [89] была бы невидимой, если бы кто-то не посчитал оба числа.

Пятый — **иностранный донор не заменяет государственную систему.** Грузинские и молдавские дома, купленные на чешские деньги, работают точечно: десятки человек на тысячи жителей учреждений.

И шестой, самый неудобный: **аргумент «слишком дорого» опирается на слабые данные** (оценка составителя). Молдова на нём остановила реформу [89], но её же цифры показывают, что бюджеты учреждений за годы реформы почти удвоились, а не сократились [89].

Ж.3. США, Канада, Австралия: суд, страховка и групповой дом

Три англоязычные страны прошли путь деинституционализации разными дорогами. В США главным рычагом стали суд и деньги федеральной медицинской страховки для бедных Medicaid. В Канаде — закрытие учреждений и запоздалые коллективные иски. В Австралии — национальная страховка по инвалидности, которая щедро оплачивает групповые дома и теперь сама спрашивает себя, не построила ли она новую сеть малых учреждений.

США: от одного процента до двух третей

Ряд данных федерального агентства CMS о расходах Medicaid на долговременные услуги и поддержку (LTSS) начинается в 1981 году. Тогда на услуги на дому и по месту жительства (HCBS) приходилось 1,1 % расходов; порог в 50 % был пройден в 2013 году, а в 2023 году доля достигла 63,8 % [152]. Услуги на дому получают 87,1 % всех пользователей. В 2023 году доля HCBS в расходах немного снизилась, с 64,6 до 63,8 %, хотя доля пользователей продолжила расти, с 86,6 до 87,1 % [152]. В 2018–2019 годах сменился источник данных, так что ряд не вполне сопоставим [152]. В абсолютных числах, по поисковому пересказу брифинга CMS, в 2023 году услуги на дому получали 8,4 млн человек на 145,9 млрд $, институциональную помощь — 1,5 млн человек на 82,7 млрд $† [153].

Разброс между штатами огромен: доля услуг на дому в расходах — от 35,8 % в Арканзасе до 94,8 % в Висконсине; высокие показатели также у Миннесоты (84,0 %), Вашингтона (82,7 %), Колорадо (81,2 %) и Орегона (80,5 %), низкие — у Алабамы (38,0 %), Миссисипи (38,2 %), Луизианы (39,8 %) и Калифорнии (47,5 %) [152]. В общих цифрах доминируют дома престарелых, поэтому для людей с нарушениями интеллекта и развития (IDD) баланс сдвинут к услугам на дому сильнее.

Именно для этой группы есть наглядные цифры о стоимости. По данным проекта RISP Миннесотского университета, в 2020 году Medicaid тратил в среднем 145 306 $ в год на получателя в промежуточных учреждениях ухода для людей с нарушениями интеллекта (ICF/IID) и 49 723 $ на участника программ на дому; в 2019 году — 140 210 и 48 458 $† [157]. Сайт RISP при подготовке доклада не загружался, и эти цифры взяты из поисковой выдачи. В Индиане в 2021 финансовом году, по брифингу университетского института 2026 года, на получателя ICF/IID тратили 93 649 $, на участника программ на дому — 25 042 $; крупные частные ICF/IID стоят около 425 тыс. $ на человека в год, supported living — около 73,6 тыс. $† [158]. Разница примерно втрое (оценка составителя: 145 306 ÷ 49 723 ≈ 2,9) по-видимому, частично отражает разный состав получателей: в учреждениях, по выводу рабочих заметок, остаются люди со сложными медицинскими и поведенческими потребностями, а средняя стоимость оставшихся мест растёт по мере того, как учреждения пустеют и постоянные издержки делятся на всё меньшее число жителей. Поэтому экономию от закрытия нельзя считать простым умножением разницы на число переведённых.

Сами учреждения почти исчезли. В 1967 году в крупных государственных учреждениях жили 29,1 % взрослых американцев с нарушениями интеллекта и развития, к 2021 году — 0,7 %; в 2020 году в 103 таких учреждениях в 33 штатах оставалось 15 322 человека† [154]. К 30 июня 2024 года 19 штатов закрыли все крупные (от 16 мест) государственные учреждения для этой группы, хотя когда-то они были во всех 50 штатах и в округе Колумбия; по более узкому определению — все ICF/IID любого размера — их закрыли только четыре штата† [155]. По подсчёту KFF Health News 2022 года, таких штатов было 17, а пять штатов — Айова, Небраска, Южная Каролина, Юта и Вайоминг — не закрыли ни одного учреждения [156]. Штатные профили RISP показывают продолжающееся сокращение: в Нью-Джерси с 1 325 человек в 2018 финансовом году до 1 028 в 2023-м, в Коннектикуте — с 347 до 251, в Массачусетсе — с 385 до 262; Вермонт закрыл последнее ICF/IID в 2020 финансовом году [159]. RISP предупреждает, что резкие годовые изменения часто отражают смену методики, а не закрытия [159].

Правовым рычагом стало решение Верховного суда по делу Olmstead v. L.C. (1999), которое признало необоснованную сегрегацию людей с инвалидностью дискриминацией по закону об американцах с инвалидностью. В июне 2024 года Министерство юстиции и профильные ведомства отметили 25-летие решения [160]. Среди недавних выводов министерства — что Миссури необоснованно помещала взрослых с психическими расстройствами в дома престарелых, Небраска сегрегировала таких людей в учреждениях assisted living и дневных программах, а Юта — людей с нарушениями развития в сфере занятости. Американская ассоциация юристов в июле 2025 года предупредила о «значительных угрозах» применению этой практики при второй администрации Трампа [161]. Общее число мировых соглашений по делам Olmstead найти не удалось.

Есть у американской истории и обратная сторона. Число коек в государственных психиатрических больницах в 2023 году упало до рекордных 36 150, или 10,8 на 100 тысяч населения, на 8 % меньше, чем в 2016 году; в 19 штатах оно сократилось на 20 % и более. При этом 52 % коек заняты пациентами, направленными через систему уголовного правосудия [162]. По опросу заключённых 2016 года, о психическом расстройстве в анамнезе сообщили 43 % заключённых тюрем штатов и 23 % федеральных [163]. О том, к чему привело опустошение больниц без служб в сообществе, рассказано в разделе Ж.4.

Канада: закрытия, иски и извинения

Онтарио закрыло последние три учреждения для людей с нарушениями интеллекта в 2008–2009 годах. Huronia Regional Centre в Орилье, проработавший 133 года, закрылся в 2009 году; Rideau — тоже в 2009-м, Southwestern — по одним источникам в 2008-м, по другим в 2009-м [164, 165]. Затем последовали коллективные иски. По делу Huronia в сентябре 2013 года, за несколько часов до суда, заключено мировое соглашение на 35 млн канадских долларов (максимальная выплата одному человеку — 42 тыс., истцы требовали 2 млрд); провинция передала около 65 тысяч документов и принесла извинения [164]. Соглашение по Rideau и Southwestern составило 32,7 млн $ для примерно 4 300 бывших жителей, с выплатами от 2 до 35 тыс. $, а премьер провинции Кэтлин Уинн принесла официальные извинения [165]. Ещё 36 млн $ получили бывшие жители двенадцати учреждений, закрытых в 1977–1999 годах [166]. В Британской Колумбии школа Woodlands закрыта в 1996 году; омбудсмен в 2002 году установил там «широко распространённое» сексуальное, физическое и психологическое насилие; соглашение по коллективному иску для жителей после 1 августа 1974 года заключено в 2009 году, а в 2018 году провинция объявила выплату по 10 тыс. $ и жившим там раньше [167].

Около 100 млн канадских долларов по трём соглашениям Онтарио (оценка составителя: 35 + 32,7 + 36) — немного по меркам бюджетов. Но эти дела показали скрытую цену институционализации, которую в смету закрытого учреждения никто не вписывал. Данных о стоимости проживания на человека в учреждениях Онтарио перед закрытием и в группах по месту жительства после него, как и канадских исследований смертности после переселения, рабочие материалы не дали.

Канаде же принадлежит крупный эксперимент с жильём без условий — At Home/Chez Soi, о котором рассказано в части 3: Housing First удвоил долю людей, стабильно живущих в жилье, и полностью окупался только для самых «дорогих» пользователей экстренных служб [168].

Австралия: страховка, которая построила групповые дома

Национальная схема страхования инвалидности (NDIS) оплачивает проживание с поддержкой (Supported Independent Living, SIL) — в основном в групповых домах. Это очень дорогая часть схемы. По данным квартальных панелей NDIS за 12 месяцев до 31 декабря 2025 года, средняя выплата на участника составила 66,7 тыс. австралийских долларов: 47 тыс. для участников без SIL и 444 тыс. для участников SIL; средний годовой бюджет плана — 85,1 тыс., 64,7 тыс. и 487,3 тыс. соответственно† [169]. За 12 месяцев до 30 июня 2026 года в одном файле указано 451,8 тыс. на участника SIL, в другом — 434,4 тыс.; вероятно, это национальная и региональная панели, а в регионе Дарвин сумма достигает 595,1 тыс.† [169]. Эти цифры взяты из фрагментов поисковой выдачи. Адвокационная организация Summer Foundation называет среднюю выплату участнику SIL в 438,2 тыс. австралийских долларов и рост почти на 40 % за пять лет [171]. Средняя выплата по всей схеме выросла с 64,4 тыс. в 2023/24 году до 65,8 тыс. в 2024/25-м по неаудированным данным [170]; расходы на все пакеты NDIS в 2023/24 году ожидались на уровне около 41 млрд [173].

Участников SIL около 36,7 тысячи: эта цифра выведена из документа Минздрава 2026 года, где говорится, что у 36 360 участников, составляющих 99 % всех участников SIL, есть определённые бюджеты; в 2019 году их было 16 880† [172]. Если перемножить, получится порядка 16 млрд австралийских долларов в год на SIL, то есть около трети или больше всех выплат NDIS (оценка составителя: 36,7 тыс. × около 440 тыс.; официальной цифрой не подтверждена). Разрыв между 444 тыс. и 47 тыс. на участника — почти в десять раз — нельзя читать как «групповой дом в десять раз дороже квартиры»: участники без SIL — это все остальные участники схемы, включая детей и людей с лёгкими нарушениями.

Независимый обзор NDIS, финальный отчёт которого опубликован в декабре 2023 года, отметил, что проживание с поддержкой и специализированное жильё «продолжают следовать моделям коллективного проживания», а инновации встречаются лишь «очагами» [174]. Расследование комиссии по качеству и безопасности NDIS 2023 года по групповым домам, охватившее семь крупных провайдеров, обслуживающих 18 % участников SIL, пришло к выводу, что многие проблемы определяются установками и квалификацией персонала† [175].

Отдельная история — финальный отчёт Королевской комиссии по вопросам насилия, жестокого обращения, пренебрежения и эксплуатации людей с инвалидностью (сентябрь 2023 года). Комиссия разделилась. Четверо комиссаров рекомендовали совместную дорожную карту Содружества и штатов по закрытию групповых домов в течение 15 лет (рекомендация 7.43); один комиссар — поэтапно, в «поколенческий» срок, и без одобрения новых групповых домов на 4–6 спален (рекомендация 7.44). В отчёте о ходе выполнения 2025 года рекомендация 7.43 значится как «требующая дальнейшего рассмотрения», а совместная работа правительств не начата [176].

Австралийский урок — предостережение. Закрытие крупных учреждений привело к «малым институтам» на четыре–шесть человек, которые очень дороги — сопоставимо с американскими ICF/IID или дороже — и в которых комиссия задокументировала насилие. Деньги сами по себе не гарантировали ни независимости, ни безопасности.

Ж.4. Дорогие уроки: как реформы проваливались

Успехи учат вдохновению, провалы — осторожности. Ниже истории, каждая из которых обошлась кому-то годами жизни. Российские версии этих ошибок сведены в части 5.

США: закрыли больницы, не построив сообщества

Американская деинституционализация 1960–1980-х годов закрывала государственные психиатрические больницы быстрее, чем создавались службы в сообществе. По оценке Treatment Advocacy Center, в 2014 году за решёткой находились около 383 тысяч человек с тяжёлыми психическими расстройствами — почти в десять раз больше, чем пациентов, остававшихся в государственных больницах [49]. В 44 из 50 штатов тюрьма или изолятор содержали больше таких людей, чем крупнейшая психиатрическая больница штата [49]. Пересчитанной общенациональной оценки за 2020-е годы найти не удалось, но более поздние данные той же организации показывают, что больничные койки продолжали сокращаться, а больше половины оставшихся заняли люди, направленные через суд [162]. Урок прост и жесток: сначала альтернатива, потом выписка.

Англия: Уинтербоурн-Вью

31 мая 2011 года программа BBC Panorama показала скрытую съёмку из частной больницы Winterbourne View для людей с нарушениями развития. Одиннадцать сотрудников предстали перед судом, шестеро получили реальные сроки; оператор Castlebeck обанкротился в 2013 году [50]. Из 48 человек, живших в больнице, к июню 2014 года десятеро всё ещё находились в стационарах [50]. Правительство ответило программой Transforming Care, но цель — к марту 2024 года сократить число таких пациентов вдвое относительно 2015 года — не была достигнута: 2 905 человек в 2015 году, 2 045 в марте 2024-го [33, 121]. В июле 2026 года их было 2 115; 49 % находились в больнице дольше двух лет, 315 человек — дольше десяти [33]. Законов и денег хватало. Не хватало жилья, местных команд и чужого взгляда внутрь закрытых стен.

Греция: Лерос

Психиатрическая больница на острове Лерос, открытая в 1958 году, была одной из крупнейших в Европе. 10 сентября 1989 года газета Observer вышла с репортажем «Europe's Guilty Secret» и фотографиями обнажённых пациентов во дворе больницы [51]. Под давлением международного осуждения началась реформа, в которой ключевую роль сыграли итальянские психиатры; больница работала до 1995 года, а наблюдатели Европейской комиссии позднее описали преобразование острова как одно из самых драматичных «бегств в обычную жизнь» [51]. Реформа, которая держится на проектных деньгах, а не на постоянной статье бюджета, рискует откатиться назад.

Южная Африка: сто сорок четыре смерти после спешного перевода

В 2016 году в провинции Гаутенг 1 711 человек с тяжёлыми психическими расстройствами и тяжёлыми нарушениями интеллекта в спешке перевели из учреждений Life Esidimeni в другие места; 144 человека умерли, судьба ещё 44 осталась неизвестной† [194]. Причины и обстоятельства решения в рабочих материалах не разбирались, и здесь они не обсуждаются. Урок из самих цифр: перевод без подготовки, без медицинского сопровождения и без проверки нового места может стоить жизней. Это главный аргумент против того, чтобы «закрывать к дате».

Молдова: реформа, которая укрепила учреждения

Молдавская программа 2018–2026 годов обещала вывести половину жителей учреждений, а за семь лет вывела около десятой части; учреждения за это время почти удвоили бюджеты, а на 133 «социально интегрированных» пришёлся 131 возврат; оба числа взяты из одного журналистского расследования, и те ли это люди, оно не уточняет [89]. Здесь нет ни злого умысла, ни скандальной съёмки — только отсутствие запрета на приём, отсутствие команды, которая отвечает за результат, и деньги, которые продолжали идти учреждениям [87, 89]. По-видимому, именно такой провал наиболее вероятен и для российского региона: не катастрофа, а тихая пробуксовка (оценка составителя).

Австралия и Восточная Европа: малые институции

Австралия закрыла большие учреждения и получила групповые дома на четыре–шесть человек стоимостью около 440 тыс. австралийских долларов в год на жителя, в которых Королевская комиссия нашла насилие и которые четверо её членов предложили закрыть за 15 лет [169, 176]. Болгария на европейские деньги строит центры в среднем на 45 мест, Чехия — малые дома для лиц с инвалидностью [76, 92]. Общее у этих историй одно: деньги шли на здания определённого типа, а не на поддержку конкретного человека там, где он хочет жить.

Скандинавия: что происходит, когда урезают лёгкую помощь

Датские данные показывают, что доля пожилых, получающих помощь на дому, снизилась [46], а шведские исследователи отмечают, что в дома престарелых люди попадают позже и в более тяжёлом состоянии [47]. Возвращает ли экономия на лёгкой помощи людей в учреждения, эти данные не показывают. Финская бездомность, начавшая расти после урезания жилищного консультирования, — пример того, как откатывается даже работающая модель, когда сокращают её обеспечение [43].

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Доказательная база подробно

Здесь сохранён подробный разбор исследований из редакции 5; сжатая версия — в части 3, расходы стран ОЭСР — в части 4.

О деинституционализации написано много манифестов и гораздо меньше исследований. Те немногие, что есть, отвечают на вопрос о деньгах осторожнее, чем хотелось бы сторонникам реформы, и твёрже, чем хотелось бы её противникам. Прежде чем перейти к ним, три оговорки. Почти все строгие работы сделаны в Великобритании, США, Канаде, Скандинавии и Ирландии; для Восточной Европы и стран со средним доходом сопоставимых количественных исследований исходов в рабочих материалах не нашлось. Большинство работ касается людей с нарушениями интеллектуального развития, а работы о жилье для людей с тяжёлыми психическими расстройствами — в основном о бездомных. Наконец, многие полные тексты в ходе подготовки доклада открыть не удалось, и часть сведений взята из аннотаций; такие места помечены знаком †.

Исходы: обзоры указывают на преимущество жизни в сообществе

Опорный обзор этой темы — работа А. Козмы, Дж. Манселла и Дж. Бидл-Браун (Kozma, Mansell, Beadle-Brown) 2009 года в American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, охватившая исследования 1997–2007 годов† [177]. По вторичным пересказам, в неё вошло 68 исследований по десяти областям исходов — здоровье, поведение, социальная жизнь, бытовые навыки и другие, — и в семи из десяти областей большинство исследований показывает преимущество малых домов и квартир перед большими учреждениями и домами престарелых† [178]. Цифру «семь из десяти» в оригинале сверить не удалось. Обзор нарративный, без мета-анализа, поэтому сводных величин эффекта в нём, по всей видимости, нет.

Десять лет спустя систематический обзор М. Маккэррон и соавторов (McCarron et al., 2019) в BMJ Open пришёл к сходному выводу о качестве жизни: переезд в сообщество связан с его улучшением по сравнению с жизнью в учреждении, и эта картина последовательна; пробелами авторы назвали пожилых людей с нарушениями интеллекта и людей со сложными потребностями† [179]. Полный текст обзора открыть не удалось, и число вошедших в него исследований здесь не приводится. В США К. Лейкин и коллеги (Lakin, Larson, Kim) из Миннесотского университета трижды, с интервалом в десять лет, сводили американские исследования поведенческих исходов деинституционализации — адаптивного и проблемного поведения; последний, третий обзор, охватывающий 1977–2010 годы, вышел в 2011 году как аналитическая записка университета (Policy Research Brief), а журнальная версия — в 2012 году в Research and Practice for Persons with Severe Disabilities† [180]. Классическое пятилетнее исследование в Пенсильвании, где учреждение Пеннхерст закрывали по решению суда, в отчёте 1985 года сравнивало развитие бывших жителей и стоимость услуг; оно показало улучшение адаптивного поведения после переезда, и, по позднейшему обзору, его результаты воспроизводились в других штатах [207].

Эти работы подводят к выводу, который важен для любого регионального плана: малый размер жилья — условие необходимое, но не достаточное. Внутри одного и того же типа жилья исходы сильно различаются, и обзор 2026 года в Scandinavian Journal of Disability Research показывает, что даже в Финляндии, Дании и Швеции часть формально «неинституционального» жилья сохраняет институциональные черты: растёт число жителей на единицу, воспроизводится учрежденческая культура, исчезает индивидуальная поддержка† [132].

Supported living, групповой дом, кампус: что показали британские сравнения

Британская группа Э. Эмерсона (Emerson et al.) в 2001 году сравнила 63 человека в supported living — жизни в обычном жилье с индивидуальной поддержкой, — 55 человек в малых групповых домах и 152 в больших [181]. По тезисам конференционной версии исследования 2000 года, скорректированные затраты значимо не различались† [182]; жители supported living делали больше выборов и больше участвовали в жизни сообщества, но у них было меньше запланированных часов занятий и выше риск эксплуатации† [182]. Совпадают ли эти формулировки со статьёй 2001 года, подтвердить не удалось. Годом раньше та же группа сравнила рассредоточенное жильё в сообществе с новыми «резидентными кампусами» и деревенскими общинами: скорректированные полные затраты рассредоточенного жилья оказались на 15 % выше, чем кампусов, но качество ухода и жизни было лучше в рассредоточенном жилье и в деревенских общинах† [183].

Английское исследование «200 жизней» (Hatton и коллеги, NDTi) добавляет к этой картине важную деталь: если учитывать стоимость жилья, интернат (residential care) дороже supported living, но у жителей интернатов значимо выше потребность в поддержке; при этом обе модели могут хорошо работать для людей с высокими потребностями [184].

Для России отсюда следуют два практических вывода. Квартира с индивидуальной поддержкой выигрывает по выбору и участию, но требует защиты от эксплуатации и продуманной занятости. А «кампус» — комплекс малых домов на одной территории — может оказаться дешевле, но хуже по качеству: это прямое предупреждение для проектов «малых домов» на территории действующих ПНИ.

Active Support: один из наиболее изученных рычагов качества

Если размер жилья не гарантирует качества, то что гарантирует? Один из наиболее изученных ответов — метод активной поддержки (Active Support), при котором сотрудник не делает за человека, а организует его участие в повседневных делах: готовке, уборке, покупках, досуге. Мета-анализ С. Флинн, В. Тоцики, Р. Хастингса и соавторов (Flynn, Totsika, Hastings et al.) 2018 года объединил 14 исследований эффективности и 10 исследований опыта участников; через шесть месяцев после обучения персонала вовлечённость жителей в деятельность значимо росла — от малого эффекта (d = 0,33) до большого (Tau-U = 0,95) в зависимости от дизайна исследования [185].

Ранние оценки были сдержаннее. Обзор Хэмелина и Стёрми (Hamelin, Sturmey) 2011 года нашёл всего три эксперимента, отвечающих строгим критериям, и признал Active Support лишь «многообещающим» вмешательством, но не доказанной практикой† [186]. Критический обзор Р. Стэнклиффа, Э. Джонс, Дж. Манселла и К. Лоу (Stancliffe, Jones, Mansell, Lowe) 2008 года, по аннотации,

отметил слабости дизайна ряда работ и всё же увидел последовательные данные о росте вовлечённости† [187]. Данных о стоимости внедрения метода в расчёте на одного жителя в рабочих материалах нет.

Политический вывод отсюда прямой: финансирование жилья в сообществе разумно связывать с обучением персонала активной поддержке и с практическим руководством на месте. Это один из наиболее изученных способов поднять качество внутри одной и той же модели жилья, и, в отличие от переезда, его можно начать в действующем интернате.

Затраты: данных мало, и они противоречивы

В 2007 году центр Тизард Кентского университета вместе с партнёрами из нескольких стран выпустил по заказу Европейской комиссии отчёт «Деинституционализация и жизнь в сообществе: результаты и затраты» (Mansell, Knapp, Beadle-Brown, Beecham), известный как DECLOC. Он охватил 28 европейских стран [24]. Его главные выводы стоит пересказать близко к тексту.

В хорошей системе поддержка людей с серьёзными нарушениями дорога, где бы они ни жили, и не следует ждать, что жизнь в сообществе окажется дешёвой только потому, что заменяемые учреждения кажутся недорогими: дешёвые учреждения почти всегда дают низкое качество. Нет данных о том, что модели в сообществе по своей природе дороже учреждений, если сравнивать их при сопоставимых потребностях жителей и сопоставимом качестве; при правильной организации они дают лучшие результаты. Если учреждение недорого, перевод людей с лёгкими потребностями обычно обходится в те же деньги или дешевле при том же или лучшем качестве, а людям с тяжёлыми потребностями в хороших службах понадобится больше денег, но и качество будет выше. Наконец, закрытие учреждения редко приносит быстрые деньги: здания стары, земля не всегда востребована, а выручка от продажи появляется лишь после полного закрытия. На старте нужны вложения в новые службы, несколько лет приходится оплачивать старую и новую системы параллельно, и бюджет закрываемого учреждения полезно оградить и направить на развитие услуг в сообществе [24].

Обзор европейского опыта М. Нэппа и соавторов (Knapp et al.) 2011 года повторяет ключевую мысль: при сопоставимых потребностях и качестве нет данных о том, что общинные модели «изначально дороже» учреждений† [109].

Двенадцать лет спустя после DECLOC в BMJ Open вышел систематический обзор о затратах при деинституционализации взрослых с интеллектуальными нарушениями (May и соавторы, 2019). Авторы искали работы до сентября 2017 года в любых рамках «затраты — последствия» и с любой перспективой, от плательщика до семьи. Порогу качества отвечали только два исследования — британские когортные работы о людях, покинувших больницы длительного пребывания NHS в 1984–1992 годах, обе с точки зрения плательщика. Одно показало более низкие средние затраты в сообществе (без проверки значимости), другое — статистически значимо более высокие на первом, пятом и двенадцатом году. Вывод обзора: забота в сообществе «не однозначно дешевле», данные неубедительны, нужны современные исследования; приоритетные группы — пожилые люди с нарушениями интеллекта и тяжёлыми соматическими болезнями и молодые люди со сложными потребностями и проблемным поведением [25].

Смертность после переезда: данные противоречивы

Один из самых тяжёлых аргументов противников реформы — «их убьёт переезд». Доказательства здесь действительно противоречивы, и их стоит изложить полностью.

Калифорнийские исследования Штрауса, Шавелла и соавторов (Strauss, Shavelle et al.) 1990-х годов сообщали о повышенной смертности после перевода из государственных учреждений в сообщество. У детей с тяжёлыми нарушениями интеллекта и хрупким здоровьем жизнь дома или в учреждениях в сообществе была связана примерно на 25 % более высокими скорректированными шансами смерти† [188]; по данным 1980–1992 годов скорректированные шансы смерти в сообществе были выше примерно на 72 %† [189]; в работе 1998 года, охватившей около двух тысяч переведённых, смертность в сообществе оказалась выше примерно на 67 % без учёта рака† [190]. Эти работы критиковали за методологию и за то, что их финансирование частично шло от профсоюза работников учреждений [190].

Проспективное контролируемое исследование Лермана, Апгар и Джордана (Lerman, Apgar, Jordan) в Нью-Джерси (2003) сравнило 150 переехавших и 150 оставшихся и не нашло эффекта самого переезда: статус «переехал или остался» и тип нового жилья не улучшали предсказание смертности, а решающими оказались возраст, низкий уровень самообслуживания, медицинские состояния и эпилепсия; фактором риска после закрытия учреждения был перевод в дома престарелых† [191]. Обзор литературы о переводах в долговременном уходе — в основном о пожилых, не о людях с нарушениями интеллекта — сообщает о риске смерти в 1,99–3,76 раза выше у переведённых, оговариваясь, что исследования без эффекта часто методологически слабее† [192]. Британские авторы во главе с Баумиком (Bhaumik) указывают на особую уязвимость людей с эпилепсией после выхода из долговременного стационара† [193].

И есть катастрофа, которая показывает, что риск реален. В 2016 году в провинции Гаутенг (ЮАР) 1 711 человек с тяжёлыми психическими расстройствами и тяжёлыми нарушениями интеллекта в спешке перевели из учреждений Life Esidimeni; 144 человека умерли, местонахождение ещё 44 оставалось неизвестным† [194].

Систематического обзора смертности при деинституционализации людей с нарушениями интеллекта в рабочих материалах не нашлось. Осторожный вывод из того, что есть: данные противоречивы; в единственном найденном контролируемом исследовании сам переезд смертность не предсказывал† [191], а риск, по-видимому, во многом определяется качеством планирования — медицинским сопровождением, особенно при эпилепсии и нарушениях глотания, отказом от «перевода» в дома престарелых и разумным темпом.

Housing First: жильё стабилизирует, но не лечит

Модель «Сначала жильё» (Housing First) даёт человеку постоянную квартиру без предварительных условий — трезвости, лечения, «исправления» — и приносит поддержку по адресу. Её доказательная база создавалась на бездомных людях с тяжёлыми психическими расстройствами, а не на жителях интернатов, поэтому переносить её на ПНИ можно только по аналогии: она

показывает, что жильё без условий не катастрофа, а не то, что оно подходит каждому жителю интерната.

Мета-анализ Бакстера и соавторов (Baxter et al.) 2019 года объединил четыре рандомизированных исследования (25 публикаций) из США и Канады, около 3 400 участников, все с высоким риском систематической ошибки [195]. Housing First увеличивал шанс получить стабильное жильё (отношение рисков 2,46; 95 % ДИ 1,58–3,84) и время в стабильном жилье, снижал число визитов в отделения неотложной помощи (отношение частот 0,63; 0,48–0,82) и госпитализаций (0,76; 0,70–0,83). Но по самооценке психического здоровья, употреблению психоактивных веществ и качеству жизни различий за срок до 24 месяцев не нашлось [195]. Кэмпбелловский обзор Мунте-Каас и соавторов (Munthe-Kaas et al.) 2018 года (43 исследования, 37 из них из США) нашёл, что включённые вмешательства, в том числе Housing First, лучше обычных услуг по жилищной стабильности во всех сравнениях† [196].

Канадский эксперимент At Home/Chez Soi — пять городов, около двух тысяч участников — показал, что в последние полгода исследования 62 % участников Housing First всё время жили в жилье против 31 % в контрольной группе [168]. Экономика проекта выглядит так: каждые 10 канадских долларов, вложенные в Housing First, давали экономию на других службах в 9,60 $ для людей с высокими потребностями и в 3,42 $ для людей с умеренными; для 10 % самых «дорогих» участников программа стоила около 19 582 $ на человека в год, а экономия составила 21,72 $ на каждые вложенные 10 $ [168]. В четвёртой редакции со ссылкой на исполнительное резюме проекта говорилось, что затраты в среднем компенсировались на 54 %, а для людей с самыми высокими потребностями почти полностью [45]. Эти цифры относятся к разным разрезам одного проекта и друг другу не противоречат, но и не складываются: полностью программа окупается только для самой затратной подгруппы, для остальных — частично.

Психиатрия: где заперты деньги

Атлас психического здоровья ВОЗ 2020 года зафиксировал, что в странах со средним доходом более 70 % государственных расходов на психическое здоровье идёт в психиатрические больницы — против 35 % в странах с высоким доходом, а доля психического здоровья в бюджетах здравоохранения держится около 2 % [197]. По резюме Атласа, медианное число коек в психиатрических больницах выросло с 6,5 на 100 тысяч в 2014 году до 11 в 2020-м† [198]. Атлас 2024 года, в который вошло 144 страны против 171 в 2020-м, по вторичным резюме, относит около 53 % стран к ранним стадиям перехода от больниц к сообществу и лишь 9 % — к странам, полностью завершившим переход; более 60 % стационарных коек по-прежнему в психиатрических больницах, расходы на душу — меньше одного доллара в странах с низким доходом и около 66 $ в странах с высоким† [199]. PDF самого Атласа 2024 года при подготовке доклада не открылся. Руководство ВОЗ 2021 года по общинным службам психического здоровья описывает примеры надлежащей практики, в том числе Триест, кризисные службы, поддержку равных и поддерживаемое жильё, и обосновывает уход от институциональных моделей [200].

Триест уже сорок лет служит эталоном сети центров психического здоровья, открытых круглые сутки [201]. По вторичному источнику, число людей на недобровольном лечении снизилось там со 150 в 1971 году до 18 в 2019-м при населении около 240 тысяч† [202]. Для других элементов общинной психиатрии картина неоднородна. Ассертивное общественное лечение (ACT) — мобильная бригада, которая ведёт человека в сообществе, — нацелено на удержание в контакте со службами, сокращение госпитализаций и улучшение социального функционирования; кокрейновский обзор этой линии в версии 2011 года отозван [203]. Британское рандомизированное исследование REACT в Лондоне не нашло значимой разницы в использовании коек за 18 месяцев, хотя пациентам ACT нравился больше [204]. Кризисные дома, по обзору Ллойд-Эванса и соавторов (Lloyd-Evans et al.) 2009 года, могут быть осуществимой и приемлемой альтернативой госпитализации для части людей в остром состоянии, но доказательная база остаётся ограниченной [205].

Для страны, где большая часть жителей интернатов попала туда через психиатрическую систему, вывод из этих данных один: главный денежный ресурс перемен в странах со средним доходом заперт в больничных и стационарных бюджетах, и выгода от общинных служб максимальна там, где альтернатива им — стационар, а не развитая общинная помощь.

Насилие: риск есть везде, но в закрытых стенах его не видно

Мета-анализ Хьюз и соавторов (Hughes et al.), опубликованный в Lancet в 2012 году, показал, что люди с инвалидностью подвергаются насилию чаще остального населения: распространённость недавнего насилия — около 24 % у людей с психическими заболеваниями и около 6 % у людей с нарушениями интеллекта; объединённое отношение шансов для людей с нарушениями интеллекта — 1,60 (1,05–2,45)† [206]. Мета-аналитических данных, которые сравнивали бы риск в учреждении и в сообществе, в рабочих материалах нет. Британское сравнение группы Эмерсона указывает на более высокий риск эксплуатации в supported living, чем в групповых домах† [182]. Разумно предположить, что в учреждении насилие скрыто закрытостью, а в сообществе проявляется как эксплуатация, — и что независимый внешний мониторинг нужен в обеих средах.

Международные обязательства

В 2022 году Комитет ООН по правам инвалидов принял руководящие принципы по деинституционализации, в том числе в чрезвычайных ситуациях. Они дополняют Замечание общего порядка № 5 (2017) к статье 19 Конвенции о праве жить самостоятельно и быть включённым в местное сообщество и прямо говорят, что осуществление этого права не может приостанавливаться даже в чрезвычайных обстоятельствах [27]. Ещё в 2015 году Комитет призвал Европейский союз прекратить использовать европейские структурные и инвестиционные фонды на поддержание учреждений и указал, что использование этих денег на «новые типы институциональных учреждений, включая групповые дома», противоречит условиям их выделения на 2014–2020 годы [92].

Комитет ООН о России: заключительные замечания 2018 года

В 2018 году Комитет ООН по правам инвалидов принял заключительные замечания по докладу России (CRPD/C/RUS/CO/1) [217]. Для темы доклада важны четыре группы пунктов.

Пункты	Что отмечает Комитет	Что рекомендует
17–18	Отдельный пункт о детях-инвалидах	Отдельную стратегию деинституционализации детей-инвалидов с конкретными сроками
26–27	Гражданский и Гражданский процессуальный кодексы закрепляют модель замещающего принятия решений («upholds the concept of substituted decision-making»)	Перейти к поддерживаемому принятию решений и признать полную дееспособность людей с инвалидностью
34–36	Сообщения о жестоком обращении в учреждениях, которое может быть равносильно пыткам; о применении препаратов для «контроля сексуального поведения»; о физической и химической фиксации («the use of physical and chemical restraints against those persons in institutions»)	Пересмотреть законодательство о принудительном введении препаратов
40–41	Глубокая обеспокоенность большим числом людей с инвалидностью в учреждениях и отсутствием стратегии деинституционализации («deeply concerned about the large number of persons with disabilities living in institutions… lack of a strategy for deinstitutionalization»)	Со ссылкой на Замечание общего порядка № 5 — принять стратегию деинституционализации и развивать поддержку по месту жительства

Таблица 3.1. Замечания Комитета ООН по России, 2018 год [217]

Пункты 26–27 и 34–36 перекликаются с российскими данными частей 1 и 5: 74 % жителей ПНИ недееспособны, а их опекун, как правило, интернат [3]; дела «Обручевского» и Троицка показывают немедицинскую фиксацию в действии [62, 65]. Это сопоставление составителя, а не вывод Комитета.

Позиция российской делегации известна по пресс-резюме заседания в Женеве 27–28 февраля 2018 года, а не по стенограмме† [218]. Делегация сообщила, что в психоневрологических интернатах живут около 150 тысяч человек; деинституционализация, по её словам, «только начинается», а закрытие учреждений — «очень чувствительный социальный вопрос». Докладчик Комитета по стране Дамьян Татич говорил о нескольких сотнях учреждений с «шестизначным» числом жителей† [218]. АСИ в том же году со ссылкой на Минтруд писало о более чем 150 тысячах† [209], а ряд «Если быть точным» даёт на 2018 год пик в 161 тысячу [3]; ряды из разных источников стыкуются плохо (приложение И.1), и разницу между ними объяснить нельзя. В 2024 году, по тому же ряду, жителей было 139 тысяч [3].

Две оговорки. Замечания 2018 года остаются последними по России: следующий цикл рассмотрения не завершён. И это оценка Комитета на момент рассмотрения, а не описание действующего российского права на 2026 год: с тех пор приняты закон о сопровождаемом проживании и подзаконные акты к нему [11–13], а законопроект о распределённой опеке отклонён [15].

Деньги не гарантируют реформу

Европейский опыт содержит и предостережение. Европейская коалиция за жизнь в сообществе в 2010 году показала на примере Венгрии и Румынии, что структурные фонды ЕС шли на содержание больших учреждений; Европейская сеть независимой жизни (ENIL) в брифинге 2018 года по 18 странам и в теневом докладе 2025 года фиксировала, что средства по-прежнему уходят в крупные учреждения, малые групповые дома и закрытые мастерские вместо услуг в сообществе† [26]. По одной из критических работ о постсоциалистической Европе, в 2007–2013 годах не менее 150 млн € из фондов ЕС было потрачено на поддержание или расширение институционального ухода в Венгрии, Латвии, Литве, Румынии и Словакии† [104]. Европейский парламент в 2024 году, по пересказу, констатировал, что процесс деинституционализации «проблематично привёл к созданию групповых домов и сегрегированных условий вместо подлинных вариантов независимой жизни»† [110]. Источник денег сам по себе ничего не решает; решают правила, на что их можно тратить. Как это выглядит на практике, показывает раздел Ж.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Россия подробно

Здесь собраны российские подробности, которые в редакции 5 стояли в основном тексте, и дополнения редакции 6.1 (И.8 и И.9). Выводы из них — в частях 1 и 5.

И.1. Почему расходятся цифры о числе жителей

Цифры о числе жителей расходятся, и расхождение само по себе поучительно. Проект «Если быть точным» по ведомственной статистике насчитал в 2024 году 139 тысяч человек в 466 интернатах для взрослых [3]. Для сравнения, в 2017 году, по ранним официальным данным, работали 523 ПНИ, в которых жили более 157 тысяч человек [3]. Ряды из разных источников стыкуются плохо: 523 учреждения в 2017 году по одним данным и 536 в 2022 году по другим, и это ещё одна причина сравнивать цифры только внутри одного ряда. Пресс-служба Минтруда сообщила «Ведомостям», что во всех отделениях для людей с психическими расстройствами, включая отделения внутри других организаций, живёт более 174 тысяч человек и что за 2022–2025 годы это число почти не изменилось [4]. За те же годы число самих ПНИ снизилось с 536 до 466, но и аналитики, и представители НКО объясняют это прежде всего объединением и переименованием учреждений, а не их закрытием [4]. Резкое падение численности жителей на 26 тысяч, или 16 %, в 2023 году авторы исследования объяснить не смогли и допускают, что сменился формат отчётности [3, 5]. Новых федеральных цифр за 2025–2026 годы — от Минтруда, Росстата или Счётной палаты — в открытых источниках найти не удалось; не нашлось и аудитов Счётной палаты по ПНИ за 2024–2026 годы.

И.2. Хронология реформы

Время	Событие	Ист.
2016	Первая дорожная карта реформы ПНИ	[3]
2017	Первые методические рекомендации Минтруда по сопровождаемому проживанию	[1, 3]
2018	Февраль: Комитет ООН по правам инвалидов рассмотрел доклад России в Женеве [218]. В том же году опубликованы заключительные замечания CRPD/C/RUS/CO/1 [217]	[217, 218]
2019	План Минтруда по развитию стационарозамещающих технологий; субсидии регионам по программе «Доступная среда»	[1, 8]
2020	Приказ Минтруда закрепил приоритет жизни вне интерната	[3]
Май 2020	Петербург, ПНИ № 10: 467 случаев COVID-19 к 18 мая†	[216]
2022	Пилот Минтруда в Нижегородской и Воронежской областях; исследование ВШЭ	[1, 8]
Апрель 2023	В Петербурге возбуждено дело о смертях проживающих ПНИ № 10	[61]
2023	Закон № 137-ФЗ от 28 апреля: статья 9.1 о сопровождаемом проживании действует с 1 сентября	[11]
2024	Постановление Правительства № 910 от 3 июля о правилах организации сопровождаемого проживания	[12]
Октябрь 2024	Нижегородская область: приказ министерства социальной политики № 860 о пилоте организационно-финансовой модели жизнеустройства на 2024–2025 годы	[58]
Декабрь 2024	Петербург: распоряжение Комитета по социальной политике № 1519-р об организации сопровождаемого проживания (ред. от 28.07.2025)	[54]
Февраль 2025	Госдума отклонила законопроект о распределённой опеке спустя девять лет после первого чтения	[15]
Март 2025	Вступил в силу приказ Минтруда № 85 от 25 февраля с методическими рекомендациями	[13, 57]
Сентябрь 2025	Вступил в силу приказ Минтруда № 305н от 14 мая: новые правила деятельности и нормативы штатной численности	[55]
Ноябрь 2025	Москва, «Обручевский»: задержаны двое санитаров по делу о тяжком вреде здоровью проживающей	[62]
Март 2026	Доклад петербургского уполномоченного за 2025 год; новым федеральным уполномоченным стала Я. Лантратова	[54, 70]
Июль 2026	Новая примерная номенклатура организаций социального обслуживания без «дома-интерната»	[56]
Сентябрь 2026	«Перспективы» предложили единый стандарт сопровождения выпускников ПНИ	[19]

Таблица И.1. Хронология реформы

Межведомственная «дорожная карта» по развитию сопровождаемого проживания действует до 2026 года [57]; что придёт ей на смену, в открытых источниках найти не удалось. Не нашлась и упоминаемая в публичных обсуждениях «концепция ПНИ до 2030 года». Новых законопроектов о распределённой опеке в 2025–2026 годах тоже не найдено [5]. Федеральный уполномоченный по правам человека Т. Москалькова представила доклад за 2025 год в Госдуме 28 января 2026 года, а 14 июля 2025 года комитеты Госдумы рассматривали её специальный доклад о положении людей с инвалидностью [70]; что в этих докладах сказано о ПНИ, проверить не удалось.

И.3. Петербург: документы, собственность, приёмы

По итогам мониторинга документов с ноября 2023 по декабрь 2024 года 26 % индивидуальных программ реабилитации (ИПРА) оказались устаревшими, у 35 % проживающих ещё действовали старые программы, а 43 % индивидуальных программ предоставления социальных услуг требовали пересмотра. Потенциал для перевода на сопровождаемое проживание на дому нашли у 116 человек, или 26 % выборки: у 68 — в индивидуальной форме, у 48 — в групповой. К концу 2025 года медико-социальная экспертиза проанализировала около 2 000 программ реабилитации, а городской центр актуализировал 145 из 189 программ социальных услуг. Из

117 претендентов на выход шестеро оценены как полностью готовые, 88 — с I–II степенью нарушения автономии, шестеро — с III–IV. Для 48 человек принято решение о тренировочном проживании — в домах ГАООРДИ, центрах реабилитации на улице Цимбалина и в посёлке Шапки, ДСО «Иверский», «Бешкино» при ДСО «Петергоф», квартире фонда «Апельсин» и ДСО «Покровский»; 44 человека отказались. ДСО «Иверский» по итогам 2025 года определил нуждаемость у 60 человек, из них 54 дееспособных, 4 ограниченно дееспособных и 2 недееспособных. Главным барьером уполномоченный называет жильё [54].

В докладе есть и поразительное наблюдение о собственности. Из-за законодательных ограничений недвижимость недееспособных проживающих не используется и превращается, по формулировке семинара Минтруда «ПНИ — пространство новых идей» (Петербург, начало 2025 года), в «источник штрафных санкций вместо доходного актива» [54]. На том же семинаре с участием первого заместителя министра О. Баталиной обсуждался конфликт интересов, когда директор учреждения одновременно опекун; предложения направлены в Минтруд [54].

Наконец, в 2025 году уполномоченный лично принял 30 проживающих. Главные просьбы — восстановление дееспособности и жильё. Среди системных проблем — медицинские организации препятствуют уходу за проживающими во время госпитализации, а у проживающих домов социального обслуживания нет диспансерного наблюдения в психоневрологическом диспансере [54].

И.4. Насилие, смерти, уголовные дела

Ниже — уголовные дела 2023–2026 годов, найденные в открытых источниках. 20 апреля 2023 года Следственный комитет возбудил дело по части 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) в отношении сотрудников петербургского ПНИ № 10: по версии следствия, с 2022 года из-за ненадлежащего ухода умерли шесть проживающих, среди них 23-летний Алексей Дельвари; Нюта Федермессер говорила о семи [61]. Чем закончилось дело, найти не удалось. В ноябре 2025 года в московском социальном доме «Обручевский», бывшем пансионате № 20, 20-летнюю проживающую с эпилепсией и самоповреждениями, по данным СК, связали шерстяными колготками и оставили, после чего у неё развилась гангрена и ей ампутировали обе кисти; возбуждено дело по статье 118 УК, 12 ноября прокуратура задержала двух санитаров, а городской департамент назвал случившееся «халатностью» [62]. С 2015 года в отношении учреждения, по реестру в пересказе поисковой выдачи, инициировано 33 проверки† [62]. Свидетельства бывших сотрудников опубликовали «Такие дела» и «Радио Свобода» [63].

В Дальнегорске бывшая специалистка по социальной работе ПНИ в августе–декабре 2024 года присвоила 1,5 млн ₽ пенсий недееспособных и ограниченно дееспособных проживающих и потратила их на ставки; дело по части 4 статьи 160 УК в июне 2025 года передано в суд, приговор не сообщался [64]. В Саратовской области бывшая заместитель директора Озёрного ПНИ осуждена за мошенничество со штрафом 400 тыс. ₽; дата приговора не проверена† [66]. И ещё одно дело, не о ПНИ, но о той же практике: в Троицке Челябинской области в детском учреждении в июле 2022 года 16-летнего подростка с психическим расстройством привязали к кровати и оставили одного, и он умер от механической асфиксии; в июле 2026 года трое бывших сотрудников получили от 6 до 6,5 лет колонии [65].

Случаи «Обручевского» и Троицка указывают на практику немедицинской фиксации — «связали и забыли». Федеральной статистики смертей в ПНИ, прокурорских проверок и представлений за 2024–2026 годы в открытых источниках найти не удалось.

В том же петербургском ПНИ № 10 за три года до уголовного дела была вспышка COVID-19. К 18 мая 2020 года там выявили 467 случаев COVID-19: 411 среди жителей и 56 среди сотрудников† [216]. Цифра известна по цепочке пересказов — «Медуза» ссылается на ТАСС, ТАСС на городской комитет по социальной политике, — и это срез на одну дату: итоговое число заболевших и число умерших не установлены. Данных о смертности жителей ПНИ от COVID-19 в 2020–2021 годах по стране найти не удалось (приложение В).

И.5. Как менялся персонал интернатов

Между 2017 и 2024 годами обеспеченность интернатов персоналом выросла с 49 до 60 работников на 100 жителей, а социальных работников стало почти вшестеро больше — с 1,5 до 8,6 на сотню [3]. Но три четверти основного персонала по-прежнему составляют медики, а Минтруд учитывает ставки, а не живых людей, так что реальный рост может быть скромнее [3]. По данным ВШЭ за 2020 год, хоть какая-то занятость была только у 19,2 % жителей ПНИ, около 30 тысяч человек; в проектах сопровождаемого проживания расходы на занятость составляют 20–30 % бюджета [1]. С 2017 по 2024 год число лечебно-трудовых мастерских при ПНИ выросло в 1,6 раза, до 450, и в них занято 9,7 тысячи человек, около 7 % жителей; ещё 5,1 тысячи участвовали в работе 207 подсобных хозяйств [3, 5].

С 1 сентября 2025 года действует приказ Минтруда от 14 мая 2025 года № 305н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений», заменивший приказ № 940н 2014 года; он содержит рекомендуемые нормативы штатной численности стационарных организаций [55]. По данным петербургского уполномоченного, новые нормативы исключили должности «сиделка (помощник по уходу)» и «младшая медицинская сестра по уходу» и изменили структуру штата: на диаграмме в докладе доля медицинского профиля снижается примерно с 55 до 49 %, доля педагогического растёт примерно с 5 до 10 % и появляется около 2 % технических специалистов. Подписи диаграммы в PDF разъехались, поэтому точное соответствие процентов категориям не проверено† [54].

И.6. Тренинги по восстановлению дееспособности

Есть и обнадёживающие примеры. Проект Центра лечебной педагогики и экспертно-методического центра «Особое детство» «Новые возможности — новое качество жизни» в течение 2025 года проводил тренинги в 13 ПНИ Башкортостана, Новгородской, Ярославской, Московской областей и Москвы, чтобы обучить не менее 120 проживающих и 26 сотрудников-тренеров. На 4 декабря 2025 года тренинг полностью прошли 33 проживающих, двое вернули ограниченную дееспособность, несколько дел ещё было в судах [67]. Две женщины, прожившие в ПНИ больше 35 лет, в 2024 году восстановили полную дееспособность и живут самостоятельно [68].

И.7. Деньги: что известно и что нет

Конкретных сумм федерального и регионального финансирования строительства ПНИ на 2025–2026 годы и региональных тарифов на сопровождаемое проживание найти не удалось. Известно, что в национальный проект «Семья» на 2025–2030 годы заложено 17,9 трлн ₽, из них 2,8 трлн в 2025 году; в него входит федеральный проект «Старшее поколение», по которому прежде строились корпуса ПНИ и «дома-интернаты нового типа», но отдельной строки «ПНИ» в найденных документах нет [59]. Программа государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2025–2027 годы упоминает помощь людям с психическими расстройствами, в том числе в условиях сопровождаемого проживания, а подушевые нормативы устанавливают субъекты [60]. С 2019 года регионы получают субсидии на сопровождаемое проживание по госпрограмме «Доступная среда» — на подготовку специалистов и обустройство помещений [8]. В Обнинске на месте санатория «Здоровье» обещали открыть в 2026 году дом-интернат; его тип и источник финансирования не проверены [73].

И.8. Из детского дома-интерната в ПНИ

Масштаб. По оценке АСИ на 2018 год, в ПНИ жили более 150 тысяч человек (по данным Минтруда), около трети из них — бывшие воспитанники детских домов-интернатов; ещё около 20 тысяч жили в самих ДДИ, и в 18 лет их переводят во взрослые интернаты† [209]. Источник вторичный, доля в треть дана без ссылки на первоисточник, цифры округлены, а 20 тысяч — численность жителей ДДИ, а не ежегодный поток. Сколько выпускников ДДИ ежегодно поступает в ПНИ по стране в 2022–2025 годах, есть ли такие данные у Минтруда или Росстата и как изменилась картина после переименования ДДИ в социальные дома, найти не удалось.

Петербург. 20 декабря 2018 года председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, по сообщению «Петербургского дневника», сказал, что с 2008 года из ДДИ во взрослую сеть переведены 685 человек, из них впоследствии умерли 45 (6,4 %), в том числе 8 за 2018 год† [210]. Это устное заявление чиновника в изложении городского СМИ. Пересчёт даёт 6,57 %, а не 6,4 % (оценка составителя: 45 ÷ 685). Сравнения с сопоставимой по возрасту и состоянию здоровья группой нет, поэтому цифра не доказывает, что смертность после перевода избыточна. Цифру «8 за 2018 год» подтвердили два проверяющих из трёх. 9 августа 2023 года на сайте петербургского уполномоченного по правам человека написано: «Как правило, выпускники ДДИ, достигнув 18-летнего возраста, переводятся в ПНИ»; там же сказано, что ДДИ № 3 и № 4 «за последние 8 лет претерпели серьезные изменения», а эксперты аппарата сочли оптимальным, чтобы выпускники могли и после 18 лет жить в знакомом ДДИ [211]. Утверждение о том, что постановление Правительства № 481 уже позволяет части выпускников оставаться в ДДИ после 18 лет, проверку не прошло (приложение В).

Москва. Сведения взяты из двух пресс-релизов mos.ru — от 30 ноября 2022 года и 26 июля 2021 года [18, 212]. Это первичные, но рекламные публикации, и их цифры никто независимо не проверял†. В 2022 году (данные до ноября) социальные дома — бывшие ДДИ — подготовили к самостоятельному или семейному проживанию более 80 выпускников; им доступна поддержка кураторов. Эту цифру подтвердили два проверяющих из трёх. Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский», описанный в части 5, за год подготовил к выпуску 13 человек из 60; индивидуальные программы длятся от года до пяти лет, у центра семь квартир в обычных домах. «Подготовлен к выпуску» не значит «переехал». В 2021 году город объявил, что безвозмездно передаст НКО 19 квартир для тренировочного сопровождаемого проживания примерно 60 бывших жителей ПНИ; это анонс, фактическая передача не подтверждена. Центр постинтернатной адаптации работает с 2014 года, в нём 88 однокомнатных и 12 двухкомнатных квартир; в 2020 году он помог 128 людям, 36 из них переехали в собственные квартиры от города†.

Что предлагают НКО. Стандарт сопровождения выпускников ПНИ, предложенный «Перспективами» в сентябре 2026 года, упомянут в частях 5 и 7 [19]. По заметкам исследования, где пересказ АСИ отнесён к вторичным источникам, это предложение одной НКО, а не принятая норма: до выписки выпускник обращается в уполномоченную организацию, которая определяет нуждаемость в социальных услугах на дому; служба по месту будущего жительства с его согласия составляет план сопровождения; первые шесть месяцев помогать может знакомый сотрудник интерната; услуги предлагается финансировать отдельно, а не держать на волонтёрах† [19].

И.9. Поддержка семей и приёмные семьи

Выплата по уходу. Неработающий трудоспособный человек, который ухаживает за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, получает федеральную выплату. Её базовый размер — 10 000 ₽ в месяц. С 2025 года выплату в том же размере получают не только родители, усыновители, опекуны и попечители, но и другие неработающие трудоспособные ухаживающие; раньше им, по найденным материалам, платили 1 200 ₽ [213, 214]. С 1 февраля 2025 года выплату проиндексировали на 9,5 %, до 10 950 ₽† [214]. Вологодское отделение Социального фонда приводит суммы с районным коэффициентом: 12 592,50 ₽ в Вологде и области и 13 687,50 ₽ в Череповце [213]; расчёт сходится (оценка составителя: 10 950 × 1,15 и 10 950 × 1,25). Правовая основа, по заметкам, — Указ Президента № 1125 от 29.12.2024; его текст не читали. Формулировка о том, что все ухаживающие получают 10 000 ₽ с 1 января 2025 года по постановлению Правительства, проверку не прошла (приложение В). Компенсацию 1 200 ₽ при уходе за взрослым инвалидом I группы не с детства или пожилым человеком отдельно не проверяли. В феврале 2026 года выплату снова проиндексировали; новый размер не проверен, и все суммы здесь — на 2025 год.

Для доклада эта выплата важна как точка сравнения, а не как статья калькулятора. Её можно держать рядом с ценой места в ПНИ — 44,8 тыс. ₽ в месяц по данным ВШЭ [1], — но это числа разных лет и разного смысла, и сравнивать их как затраты нельзя. Выплата не оплачивает ни часы профессиональной помощи, ни жильё, ни передышку для семьи, и сколько стоит удержать человека дома, по найденным данным посчитать нельзя.

Приёмные семьи для пожилых и инвалидов. 22 декабря 2020 года заместитель министра труда Ольга Баталина объявила, что Минтруд подготовит для регионов методические рекомендации о развитии приёмных семей для пожилых: «Это первый инструмент, который позволит нам стимулировать те субъекты, которые ещё в эту технологию не вошли»; рекомендации «не будут нормативным регуляторным актом»† [215]. Федеральный закон ведомство, по этой публикации, так и не внесло, хотя сенаторы его предлагали; что

изменилось после 2020 года, не проверено; сенатор Е. Бибикова в мае 2020 года выступала за федеральный рамочный закон и отмечала, что примерно в половине регионов есть свои законы† [215]. Надёжность этих сведений средняя: их подтвердили два проверяющих из трёх. Утверждение о размерах выплат приёмным семьям в Татарстане опровергнуто (приложение В). Насколько распространены приёмные семьи, кратковременное пребывание и «социальная передышка», сколько они стоят и какой у них охват, найти не удалось.